



Nuansa
Fajar
Cemerlang

Bunga Rampai

PERAWATAN PASCA PERSALINAN DAN KESEHATAN IBU

Enok Nurliawati • Machmudah • Santi Wahyuni
Hesti Ratna Sari • Nurmah Rachman
Wulida Litaqia

Editor: Risna Yunita Asmin



BUNGA RAMPAI PERAWATAN PASCA PERSALINAN DAN KESEHATAN IBU

Penulis:

Enok Nurliawati, S.Kp., M.Kep.
Dr. Ns. Machmudah, M.Kep., Sp.Kep.Mat.
Santi Wahyuni, SKp., M.Kep., Sp.Mat.
Ns. Hesti Ratna Sari, M.Kep.
Ners. Nurmah Rachman, S.Kep., M.Med.Ed.
Wulida Litaqia, S.Kep., Ners., M.Kep.

Editor:

Risna Yunita Asmin, S.ST., M.Keb.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

Bunga Rampai: Perawatan Pasca Persalinan Dan Kesehatan Ibu

Penulis: Enok Nurliawati, S.Kp., M.Kep.

Dr. Ns. Machmudah, M.Kep., Sp.Kep.Mat.

Santi Wahyuni, SKp., M.Kep., Sp.Mat.

Ns. Hesti Ratna Sari, M.Kep.

Ners. Nurmah Rachman, S.Kep., M.Med.Ed.

Wulida Litaqia, S.Kep., Ners., M.Kep.

Editor: Risna Yunita Asmin, S.ST., M.Keb.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Tata Letak: Helmi Syaukani

ISBN: 978-634-7219-65-7

Cetakan Pertama: Juni, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2024

by Penerbit PT Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : www.nuansafajarcemerlang.com

Instagram : @bimbel.optimal

PENERBIT:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jl. S. Parman Kav 22-24, Palmerah

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)



PRAKATA



Perawatan pasca persalinan adalah tahap penting dalam perjalanan kesehatan ibu setelah melahirkan. Proses pemulihan pasca melahirkan tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan emosional, yang memiliki dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan ibu. Buku ini hadir untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai perawatan pasca persalinan, dengan fokus pada berbagai tantangan kesehatan yang dihadapi oleh ibu, baik itu yang berkaitan dengan komplikasi fisik, gizi, maupun kesehatan mental.

Pada bab pertama, kita akan membahas tentang perawatan pasca melahirkan pada ibu dengan komplikasi perdarahan post partum. Komplikasi ini merupakan salah satu penyebab utama kematian ibu setelah melahirkan dan memerlukan perhatian medis yang sangat serius. Buku ini memberikan panduan mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi dan mencegah perdarahan post partum, serta perawatan yang tepat agar ibu dapat pulih dengan baik.

Bab kedua membahas tentang kesehatan seksual pasca persalinan dan pentingnya mengembalikan fungsi reproduksi ibu setelah melahirkan. Menyusul proses persalinan, banyak ibu yang mengalami perubahan dalam kehidupan seksual mereka, dan penting untuk memberikan edukasi serta dukungan agar mereka dapat merasa nyaman dan kembali menjalani kehidupan seksual yang sehat.

Di bab ketiga, kita akan mengupas tantangan yang dihadapi ibu setelah menjalani operasi caesar. Pemulihan setelah operasi caesar memerlukan perhatian ekstra dan langkah-langkah perawatan khusus, baik dalam hal fisik maupun emosional. Buku ini memberikan panduan mengenai cara mengelola pemulihan pasca operasi caesar, serta berbagai tantangan yang mungkin dihadapi oleh ibu.

Bab keempat mengangkat isu perawatan ibu dengan komplikasi gizi pasca persalinan, yang juga memengaruhi pemulihan dan kesehatan ibu. Perawatan gizi yang tepat sangat penting untuk mendukung proses pemulihan pasca persalinan, serta untuk memastikan ibu dapat kembali berfungsi dengan baik.

Pada bab kelima, kami juga memberikan perhatian khusus kepada ibu yang mengalami gangguan kesehatan mental setelah melahirkan. Perawatan kesehatan mental pasca persalinan adalah hal yang tak kalah penting, dan buku ini menawarkan panduan mengenai pentingnya pendidikan dan dukungan untuk ibu-ibu yang mengalami gangguan mental, seperti depresi pasca persalinan, agar mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih baik.

Bab terakhir membahas bagaimana mendukung ibu dengan tantangan kesehatan seksual pasca persalinan. Kami menyadari bahwa perubahan fisik dan psikologis yang terjadi pasca persalinan bisa berdampak pada kehidupan seksual ibu, sehingga dukungan yang tepat sangat dibutuhkan agar ibu dapat mengatasi tantangan ini.

Buku ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan informasi yang bermanfaat mengenai perawatan pasca persalinan. Diharapkan juga buku ini bisa menjadi referensi penting bagi tenaga medis, keluarga, serta para ibu yang sedang menjalani masa pemulihan pasca persalinan. Semoga buku ini dapat membantu ibu merasa didukung, mendapatkan perawatan yang optimal, dan melalui masa pemulihan dengan lebih baik.

Maret, 2025

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

CHAPTER 1 PERAWATAN PASCA MELAHIRKAN PADA IBU DENGAN KOMPLIKASI PERDARAHAN POST PARTUM 1

Enok Nurliawati, S.Kp., M.kep.....	1
A. Pendahuluan/Prolog	1
B. Definisi dan Klasifikasi Perdarahan Post Partum	2
C. Faktor Penyebab Perdarahan Post Partum	2
D. Faktor Risiko Perdarahan Post Partum	5
E. Tanda dan Gejala	9
F. Penatalaksanaan Perdarahan Post Partum	10
G. Implikasi dalam Asuhan Keperawatan	11
H. Kesimpulan.....	15
I. Referensi	15
J. Glosarium	18

CHAPTER 2 KESEHATAN SEKSUAL PASKA PERSALINAN: MENGEMBALIKAN FUNGSI REPRODUKSI..... 19

Dr. ns. Machmudah, M.Kep., Sp.Kep.Mat.	19
A. Pendahuluan/Prolog	19
B. Perubahan Fisiologis dan Psikologis Ibu Postpartum yang Memengaruhi Pola Seksual	21
C. Faktor yang Memengaruhi Perubahan Seksual pada Ibu Postpartum.....	24
D. Masalah Seksual pada Ibu Postpartum	26
E. Pengkajian Fungsi Seksual pada Ibu Postpartum	29
F. Cara Mengatasi Masalah Seksual pada Ibu Postpartum	31
G. Simpulan	32
H. Referensi	32
I. Glosarium	34

CHAPTER 3 PERAWATAN PASCA OPERASI CAESAR: PEMULIHAN DAN TANTANGAN 35

Santi Wahyuni, S.Kp., M.Kep., Sp.Mat.	35
A. Pendahuluan	35
B. Perawatan Pasca Sectio Caesarea dengan Metode ERAS.....	38
C. Pemulihan Pasca Sectio Caesarea	42

D. Tantangan dan Solusi dalam Proses Pemulihan Pasca Sectio Caesarea.....	56
E. Simpulan	58
F. Referensi	59
G. Glosarium	64

CHAPTER 4 MENGELOLA KESEHATAN IBU DENGAN KOMPLIKASI GIZI

PASCA PERSALINAN67

Ns. Hesti Ratna Sari, M.Kep.....	67
A. Pendahuluan/Prolog	67
B. KEK dengan Pasca Persalinan.....	68
C. Program Unicef Untuk Gizi Ibu Nifas	69
D. Mengelola Gizi Ibu Pasca Persalinan.....	70
E. Hambatan dalam Mengakses Pelayanan Kesehatan	75
F. Simpulan	76
G. Referensi	76
H. Glosarium	77

CHAPTER 5 PENDIDIKAN DAN DUKUNGAN UNTUK IBU YANG

MENGALAMI GANGGUAN KESEHATAN MENTAL79

Nurmah Rachman, S.Kep., Ns., M.Med.Ed.....	79
A. Pendahuluan	79
B. Strategi Pencegahan Dan Intervensi	81
C. Program Kesehatan Ibu Postpartum	84
D. Hambatan Dalam Pelayanan Kesehatan Mental	87
E. Kesimpulan.....	89
F. Referensi	90

CHAPTER 6 MENDUKUNG IBU DENGAN TANTANGAN KESEHATAN

SEKSUAL PASCA PERSALINAN93

Wulida Litaqia, S.Kep., Ners., M.Kep.	93
A. Pendahuluan/Prolog	93
B. Perubahan Fisik Setelah Persalinan dan Dampak Kesehatan Seksual	94
C. Perawatan untuk Mendukung Kesehatan Seksual Pasca Persalinan.....	100
D. Simpulan	104
E. Referensi	104
F. Glosarium	107

PROFIL PENULIS109

CHAPTER 1

PERAWATAN PASCA MELAHIRKAN PADA IBU DENGAN KOMPLIKASI PERDARAHAN POST PARTUM

Enok Nurliawati, S.Kp., M.kep.

A. Pendahuluan/Prolog

Perdarahan postpartum merupakan penyebab langsung kematian ibu. Meskipun angka kejadiannya menurun dalam 25 tahun terakhir, kasusnya masih tergolong tinggi, dengan 29,3% mengakibatkan kematian dan 26,7% menyebabkan gangguan pada masa postpartum. Variasi kasus perdarahan postpartum menunjukkan angka kematian sebesar 9,3% di negara dengan indeks sosial-ekonomi tinggi dan 45,7% di negara dengan indeks sosial-ekonomi rendah. Jumlah kematian akibat perdarahan postpartum mencapai 49,1% di negara maju dan 73% di negara miskin. Klien yang mengalami perdarahan postpartum memiliki risiko kematian sebesar 17%, yang bergantung pada faktor geografis serta kualitas perawatan yang diberikan dalam penanganan perdarahan postpartum. Estimasi kejadian perdarahan postpartum berkisar antara 1% hingga 10% dari total kelahiran (Borovac-Pinheiro et al., 2018).

Perdarahan postpartum didefinisikan sebagai kehilangan darah sebanyak 500 mL atau lebih pada persalinan pervaginam atau 1.000 mL pada persalinan sesar. Kondisi ini juga dapat terjadi dalam 24 jam pertama setelah melahirkan, disertai dengan peningkatan frekuensi nadi dan penurunan tekanan darah (Ghosh & Chandharan, 2017; Kelly C. Wormer; Radia T. Jamil; Suzanne B. Bryant, 2025). Penyebab terjadinya perdarahan post partum adalah atonia uterus, trauma jalan lahir, retensio placenta dan sisa jaringan serta gangguan pembekuan darah. Adapun faktor risiko terjadinya perdarahan post partum adalah usia, interval kehamilan, paritas, anemia, preeklampsia, kehamilan ganda, polihidamnion, makrosomia (Delpia, 2020; Rifdiani, 2016; L. F. Sari, 2018; M. H. Sari & Nurliah, 2022; Wardani, 2017).

Penanganan kegawatan difokuskan pada pencegahan syok hipovolemik, yang dapat secara langsung menyebabkan kematian. Jika tanda-tanda syok tidak ditemukan dan kondisi tanda vital stabil, pasien akan menjalani observasi lebih lanjut serta menerima transfusi darah. Jenis darah yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan pasien berdasarkan hasil evaluasi klinis dan pemeriksaan hematologi (Kogutt & Vaught, 2019). Pada tahap ini, pasien telah memasuki fase pemulihan.

Perdarahan postpartum merupakan salah satu penyebab kematian ibu yang sebenarnya dapat dicegah. Kematian akibat perdarahan umumnya terjadi akibat pemantauan yang tidak memadai, kegagalan dalam menangani penurunan tanda vital, kurangnya komunikasi yang efektif antar tenaga kesehatan, koordinasi yang tidak optimal dengan konsultan, serta keterbatasan tenaga kesehatan yang terlatih (Gyamfi-Bannerman et al., 2018). Upaya pencegahan kematian dapat dilakukan melalui penatalaksanaan yang optimal, yaitu dengan memberikan asuhan keperawatan yang tepat pada setiap fase perdarahan postpartum.

B. Definisi dan Klasifikasi Perdarahan Post Partum

Perdarahan post partum atau juga disebut Perdarahan Pasca-Salin (PPS) adalah pengeluaran darah dari jalan lahir lebih dari 500 ml setelah persalinan pervaginam atau lebih dari 1000 ml setelah persalinan dengan seksio sesarea (POGI & Himpunan Kedokteran Feto Maternal, 2016). Lebih lanjut POGI menjelaskan bahwa perdarahan pasca-salin dapat bersifat minor dan mayor. Perdarahan bersifat minor apabila jumlah pengeluaran darah berkisar antara 500 ml – 1000 ml, sedangkan dikatakan mayor apabila jumlah darah lebih dari 1000 ml. Perdarahan mayor dibagi dua yaitu perdarahan sedang apabila pengeluaran darah 1000 ml – 2000 ml dan perdarahan berat apabila pengeluaran darah lebih dari 2000 ml.

C. Faktor Penyebab Perdarahan Post Partum

Perdarahan post partum disebabkan oleh tone, tissue, trauma dan thrombin atau sering disebut 4 T.

1. *Tone* (Tonus)

Tone atau tonus yang dimaksud adalah tonus uterus yaitu kontraksi uterus setelah placenta lahir. Setelah lahirnya placenta dan selaput ketuban secara lengkap, maka secara fisiologis akan mulai terjadinya homeostatis sebagai mekanisme tubuh untuk mencegah kehilangan cairan atau darah yang berlebihan. Mekanisme fisiologis yang utama dan pertama adalah homeostatis mekanis. Mekanisme tersebut terdiri dari kontraksi dan retraksi dari myometrium yang dipengaruhi oleh hormon oksitosin endogen dan prostaglandin. Struktur otot polos uterus berbentuk spiral dan memanjang ke segala arah. Retraksi otot uterus akan memastikan kondisi kontraksi tetap terjaga. Dengan demikian maka apabila berkontraksi maka pembuluh spiral rahim tertekan sehingga aliran darah akan menurun (Masuzawa & Yaeko, 2017). Mekanisme kedua yakni homeostatis kimiawi atau aktivasi sistem koagulasi. Setelah placenta lepas dari dinding uterus maka pembuluh darah akan terbuka atau mengalami kerusakan. Kondisi tersebut akan segera mengaktifkan juga faktor pembekuan darah dan fibrinolitik yang juga

secara fisiologis sudah mengalami peningkatan pada masa kehamilan. Mekanisme pertama adalah trombosit akan beraglutinasi pada pembuluh darah yang rusak yang kemudian akan juga merangsang protombin untuk membentuk benang-benang fibrin yang akan menutupi ujung pembuluh darah yang terbuka. Tidak hanya itu faktor pembekuan darah yakni faktor VII dan X sehingga akan terjadi peningkatan koagulasi darah yang akan mempercepat berhentinya perdarahan

Namun demikian dalam kondisi tertentu maka mekanisme tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya dan menyebabkan perdarahan post partum. Perdarahan post partum yang paling sering atau hampir 70% disebabkan karena adanya atonia uterus (Ende et al., 2021). Atonia uterus adalah tonus uterus yang menurun atau tidak berkontraksi dengan baik setelah placenta dan selaput ketuban lahir atau setelah kala III persalinan (kala uri). Faktor risiko terjadinya atonia uterus diantaranya adalah distensi uterus yang berlebihan akibat kehamilan kembar, bayi yang besar (makrosomia), Riwayat perdarahan post partum sebelumnya, anemia (Ende et al., 2021; Gyanendra et al., 2024). Hasil penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa faktor risiko yang paling dominan terjadinya atonia uterus adalah kehamilan kembar (*gemelli*) dimana ibu yang hami kembar memiliki risiko 52,39 kali dibandingkan dengan kehamilan tunggal (Melati Julizar, Jusuf S.Effendi, 2019)

2. Tissue (Jaringan)

Perdarahan postpartum (PPH) yang berkaitan dengan faktor jaringan (tissue) berhubungan erat dengan proses pelepasan dan pengeluaran plasenta yang bergantung pada kontraksi serta retraksi uterus. Pelepasan plasenta yang sempurna memungkinkan retraksi uterus yang optimal dan oklusi pembuluh darah, sehingga mencegah terjadinya perdarahan (Pribadi, 2023). Sebaliknya, retensio plasenta atau sisa selaput ketuban yang tertinggal dapat memicu perdarahan postpartum. Sisa jaringan yang tidak sepenuhnya dikeluarkan dapat menghambat kontraksi uterus yang optimal, sehingga menyebabkan perdarahan terus-menerus. Selain itu, kelainan pada proses implantasi plasenta, seperti plasenta akreta, placenta inkreta dan placenta perkreta dapat mengakibatkan kegagalan pelepasan plasenta dari dinding uterus dengan sempurna, sehingga meningkatkan risiko terjadinya perdarahan pada ibu pascapersalinan (Harsono et al., 2023).

Prevalensi plasenta akreta bervariasi di berbagai negara dan menunjukkan tren peningkatan. Di Amerika Serikat, prevalensi plasenta akreta dilaporkan sekitar 0,29% dari total persalinan. Peningkatan ini sejalan dengan meningkatnya angka operasi caesar, yang merupakan faktor risiko utama. Studi menunjukkan

bahwa sekitar 6,7% pasien dengan riwayat lima kali operasi caesar mengalami plasenta akreta, dibandingkan dengan 0,3% pada pasien dengan satu kali operasi caesar (Evensen et al., 2017). Di Indonesia, data prevalensi plasenta akreta masih terbatas. Namun, sebuah penelitian di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung menemukan 39 kasus plasenta akreta dalam periode 2015–2019. Mayoritas pasien berusia di atas 35 tahun, multipara, dan memiliki riwayat operasi caesar lebih dari satu kali. Sebanyak 76,9% pasien membutuhkan transfusi darah, dan 83,7% bayi yang lahir dari ibu dengan plasenta akreta lahir prematur (Gurnita & Irianti, 2023)

3. Trauma

Perdarahan postpartum dapat terjadi akibat trauma pada jalan lahir, baik yang terjadi secara spontan maupun akibat tindakan medis yang dilakukan untuk memperlancar proses persalinan. Pada persalinan melalui seksio sesarea, jumlah perdarahan dapat mencapai dua kali lipat dibandingkan dengan persalinan pervaginam. Trauma yang terjadi dapat berupa laserasi pada perineum, vagina, dan serviks saat persalinan pervaginam. Tingkat keparahan laserasi diklasifikasikan berdasarkan kedalamannya, mulai dari derajat satu hingga empat. Beberapa tingkat laserasi dapat menyebabkan komplikasi hingga 60%, dengan 80% di antaranya merupakan kasus ringan. Namun, laserasi derajat tiga hingga empat dapat berisiko merusak struktur di sekitar saluran genital, seperti uretra, arteri vagina, dan sfingter anus. Laserasi yang parah memerlukan tindakan pembedahan serta transfusi darah untuk mengatasi perdarahan yang terjadi (Medscape, 2018; Papazian & Kacmar, 2017).

Selain laserasi, trauma lainnya yang dapat menyebabkan perdarahan postpartum adalah ruptur uteri. Kondisi ini umumnya terjadi pada ibu yang memiliki riwayat persalinan melalui operasi perut sebelumnya. Oleh karena itu, pemeriksaan palpasi transvaginal pada bekas luka operasi tidak lagi direkomendasikan. Setiap ibu hamil yang pernah menjalani prosedur medis yang mempengaruhi dinding uterus dianggap memiliki risiko mengalami ruptur uteri. Prosedur tersebut meliputi miomektomi, uteroplasti, reseksi kehamilan ektopik di kornu, serta perforasi uterus akibat laparotomi, histerektomi, biopsi, dilatasi dan kuretase, serta pemasangan alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR). Prevalensi ruptur uteri diperkirakan sekitar 0,1%, dengan faktor risiko utama adalah riwayat persalinan melalui operasi caesar. Risiko ini meningkat hingga 40 kali lipat dibandingkan dengan ibu yang menjalani persalinan pervaginam (Ahmad et al., 2020)

4. *Thrombin*

Pada periode pascapersalinan, gangguan pada faktor koagulasi umumnya tidak memberikan dampak signifikan terhadap mekanisme penghentian perdarahan, karena kontraksi dan retraksi uterus berperan utama dalam proses hemostasis. Namun, kondisi ini dapat menjadi berbahaya apabila terjadi deposisi fibrin dan pembentukan bekuan darah dalam pembuluh darah beberapa jam hingga beberapa hari setelah persalinan. Trombositopenia dapat terjadi akibat penyakit yang telah diderita ibu sebelumnya, seperti idiopathic thrombocytopenic purpura, sindrom HELLP (Hemolysis, Elevated Liver Enzymes, and Low Platelet Count), disseminated intravascular coagulation (DIC), dan sepsis. Kelainan pada faktor koagulasi bisa merupakan penyebab langsung perdarahan post partum meskipun insidennya hanya 1 % (Hapsari Dewi et al., 2022). Meskipun kondisi ini umumnya dapat terdeteksi sebelum persalinan, dalam beberapa kasus dapat tidak teridentifikasi. Selain itu, gangguan koagulasi hereditas seperti *familial hypofibrinogenemia* dan penyakit *von Willebrand* juga perlu dipertimbangkan.

D. Faktor Risiko Perdarahan Post Partum

1. Distensi uterus berlebihan

Distensi uterus yang berlebihan merupakan salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap terjadinya atonia uteri, yaitu kegagalan otot-otot uterus untuk berkontraksi secara efektif setelah persalinan. Atonia uteri merupakan penyebab utama perdarahan postpartum yang dapat berujung pada komplikasi serius, termasuk syok hipovolemik dan kematian ibu (Cunningham et al., 2022).

Secara fisiologis, setelah persalinan, uterus seharusnya mengalami kontraksi yang kuat untuk mengurangi aliran darah ke tempat pelepasan plasenta dan membantu hemostasis. Namun, dalam kondisi distensi uterus yang berlebihan yang bisa disebabkan oleh kehamilan multipel, polihidramnion, makrosomia janin, atau persalinan yang berkepanjangan maka serat-serat otot miometrium meregang secara ekstrem. Peregangan ini dapat menyebabkan kelelahan otot sehingga menurunkan respons uterus terhadap oksitosin, hormon yang berperan dalam stimulasi kontraksi (Sentilhes et al., 2015).

Selain itu, distensi yang berlebihan dapat mengganggu interaksi antara aktin dan miosin dalam sel otot uterus, sehingga kontraksi menjadi kurang efektif. Akibatnya, setelah persalinan, uterus tidak dapat mengecil dengan optimal, menyebabkan perdarahan yang berlebihan karena pembuluh darah di tempat implantasi plasenta tetap terbuka. Kondisi ini memperparah risiko perdarahan

postpartum yang sulit dikendalikan tanpa intervensi medis, seperti pemberian uterotonika atau tindakan bedah (FIGO, 2022).

2. Anemia

Anemia pada ibu hamil merupakan kondisi di mana kadar hemoglobin dalam darah berada di bawah normal atau kurang dari 11 gr%. Menurut WHO klasifikasi anemia yaitu anemia ringan apabila kadar hemoglobin 9 – 10 gr%, anemia sedang apabila kadar hemoglobin 7 – 8 gr% dan anemia berat apabila kadar hemoglobin < 7 gr%. Kondisi anemia pada ibu hamil dapat berdampak signifikan pada proses persalinan dan masa nifas. Salah satu komplikasi serius yang berhubungan dengan anemia adalah peningkatan risiko terjadinya perdarahan post partum (*postpartum hemorrhage*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara anemia dengan kejadian perdarahan post partum (Gustika Anggriani, 2020). Penelitian lebih lanjut yang dilakukan oleh Melati Julizar & Jusuf S.Effendi (2019) menunjukkan bahwa ibu yang mengalami anemia selama kehamilan mempunyai risiko atonia uteri setelah melahirkan sebesar 2,08 kali dibandingkan dengan ibu yang memiliki kadar hemoglobin normal. Penelitian lainnya menunjukkan bahwa ibu yang mengalami anemi mengalami risiko perdarahan post partum sebesar 8,17kali dibandingkan dengan ibu yang memiliki kadar hemoglobin normal (Janah et al., 2023).

Kadar hemoglobin yang rendah dapat memengaruhi kontraksi otot, termasuk otot uterus, terutama selama persalinan. Hemoglobin berperan penting dalam mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otot-otot. Ketika kadar hemoglobin menurun, suplai oksigen ke otot juga berkurang, yang dapat mengganggu fungsi otot. Penelitian yang dipublikasikan dalam *Jurnal Keperawatan* menyatakan bahwa kekurangan hemoglobin dalam darah mengakibatkan kurangnya oksigen yang dibawa ke sel-sel tubuh, termasuk otot uterus. Hal ini menyebabkan otot-otot uterus tidak dapat berkontraksi dengan adekuat, sehingga meningkatkan risiko inersia uteri atau gangguan kontraksi, yang pada akhirnya dapat menyebabkan persalinan lama dan perdarahan postpartum (Rudiyanti & Metti, 2017). Selain itu, penelitian lain yang diterbitkan dalam *Jurnal Kebidanan* menunjukkan bahwa pada ibu bersalin yang mengalami anemia, kontraksi uterus cenderung lemah, pendek, dan jarang. Kondisi ini disebabkan oleh terganggunya pembentukan adenosin trifosfat (ATP) akibat kurangnya oksigen. ATP adalah sumber energi utama untuk kontraksi otot, sehingga penurunan produksinya berdampak langsung pada kekuatan kontraksi otot, termasuk otot uterus (Atmoko et al., 2021).

Dengan demikian, kadar hemoglobin yang rendah dapat mengurangi suplai oksigen ke otot, mengganggu produksi energi yang diperlukan untuk kontraksi, dan akhirnya menyebabkan kontraksi otot yang lemah atau tidak efektif.

3. Preeklampsia.

Preeklamsia adalah kondisi yang terjadi selama kehamilan, persalinan, dan masa nifas, ditandai dengan hipertensi dan proteinuria tanpa riwayat hipertensi sebelumnya (Saifuddin.A., 2014). Berdasarkan hasil penelitian di RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang menunjukkan bahwa preeklamsia berhubungan dengan kejadian perdarahan post partum (Delpia, 2020). Penelitian lainnya menunjukkan bahwa jumlah responden berdasarkan faktor risiko terjadinya perdarahan post partum yang paling banyak atau 55% adalah pre eklamsia (Sulistyoningtyas, 2020).

Pre eklamsia merupakan salah satu kondisi yang dapat menyebabkan perdarahan akibat iskemia plasenta dan gangguan fungsi endotel, yang menghambat suplai darah ke plasenta serta memicu vasospasme sistemik. Gangguan ini berdampak pada berbagai organ, termasuk hati yang sering mengalami iskemia dan trombositopenia, sehingga meningkatkan risiko perdarahan mikro dan gangguan koagulasi. Selain itu, preeklamsia menyebabkan vasokonstriksi dan kerusakan endotel, yang berujung pada peningkatan permeabilitas vaskular, edema, serta aktivasi koagulasi. Disfungsi endotel juga memicu gangguan pembekuan darah, yang memperparah perdarahan postpartum.

4. Paritas

Paritas adalah jumlah kelahiran yang pernah dialami oleh seorang ibu. Paritas merupakan salah satu faktor risiko dalam kejadian perdarahan post partum. Hasil penelitian (L. F. Sari, 2018) menyatakan bahwa ibu dengan paritas lebih dari 4 memiliki risiko lebih besar mengalami perdarahan post partum. Hal ini disebabkan oleh seringnya peregangan otot uterus pada paritas tinggi, yang mengakibatkan penipisan dinding uterus dan melemahnya kontraksi setelah persalinan. Kondisi ini meningkatkan kemungkinan terjadinya atonia uteri, yaitu kegagalan uterus berkontraksi dengan efektif, yang merupakan salah satu penyebab utama perdarahan post partum.

Selain itu, penelitian lain menemukan bahwa ibu dengan paritas berisiko (paritas 1 dan >3) memiliki risiko 3,040 kali lebih besar mengalami PPH dibandingkan dengan ibu dengan paritas tidak berisiko (paritas 2-3). Hal ini menunjukkan bahwa baik paritas rendah (primipara) maupun paritas tinggi (grande multipara) dapat meningkatkan risiko perdarahan post partum (M. H. Sari & Nurliah, 2022). Hasil studi literatur yang dilaksanakan oleh (Rachman Adi

Pradana & Febri Asshiddiq, 2021) menunjukkan bahwa ada hubungan antara paritas tinggi dengan kejadian perdarahan post partum.

Mekanisme yang mendasari hubungan antara paritas dan perdarahan post partum melibatkan perubahan pada otot uterus. Pada paritas tinggi, otot uterus lebih sering mengalami peregangan, yang dapat menyebabkan penurunan elastisitas dan kontraktilitas. Akibatnya, setelah persalinan, uterus mungkin tidak mampu berkontraksi dengan efektif untuk menghentikan perdarahan. Sebaliknya, pada paritas rendah, terutama pada primipara, ketidaksiapan fisiologis dalam menghadapi persalinan dapat menyebabkan kontraksi uterus yang tidak optimal, sehingga meningkatkan risiko perdarahan post partum.

Dengan demikian, baik paritas rendah maupun tinggi dapat menjadi faktor risiko terjadinya perdarahan pascapersalinan. Oleh karena itu, penting bagi tenaga kesehatan untuk memberikan perhatian khusus pada ibu dengan paritas berisiko dan melakukan tindakan pencegahan serta penanganan yang tepat untuk mengurangi risiko perdarahan post partum.

5. Jarak Kehamilan

Jarak kehamilan yang kurang dari dua tahun telah dikaitkan dengan peningkatan risiko perdarahan postpartum, yang merupakan salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas maternal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu dengan jarak kehamilan kurang dari dua tahun memiliki risiko 17,95 kali lebih tinggi mengalami perdarahan post partum dibandingkan dengan ibu yang memiliki jarak kehamilan lebih dari dua tahun Izfi. Dan penelitian lainnya menunjukkan bahwa ibu hamil dengan jarak kurang dari dua tahun memiliki risiko 3,589 kali lebih besar dibandingkan dengan ibu yang interval kehamilannya lebih dari 2 tahun Psiari.

Beberapa mekanisme fisiologis mendukung hubungan ini, termasuk belum optimalnya pemulihan uterus, meningkatnya risiko atonia uteri, defisiensi nutrisi maternal, serta gangguan implantasi plasenta. Secara fisiologis, setelah proses persalinan, rahim mengalami involusi, yaitu kembali ke ukuran dan kondisi normalnya. Namun, jika kehamilan terjadi dalam waktu yang terlalu singkat, otot-otot rahim mungkin belum pulih sepenuhnya. Kondisi ini dapat menyebabkan kontraksi uterus yang kurang efektif dalam menghentikan perdarahan setelah persalinan, yang pada akhirnya meningkatkan risiko perdarahan post partum. Selain itu, jarak kehamilan yang pendek juga meningkatkan kemungkinan terjadinya atonia uteri, yaitu kondisi di mana rahim gagal berkontraksi secara adekuat setelah melahirkan, yang merupakan penyebab utama perdarahan post partum. Berdasarkan hasil penelitian Psiari menunjukkan bahwa ibu dengan jarak kehamilan kurang dari 2 tahun memiliki risiko terjadinya perdarahn post partum

sebesar 3,972 kali dibandingkan dengan ibu yang jarak kehamilannya lebih dari 2 tahun.

Ibu yang masa kehamilan dan menyusui berdekatan dapat menyebabkan defisiensi zat besi, kalsium, dan nutrisi esensial lainnya. Defisiensi nutrisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan ibu selama kehamilan, tetapi juga meningkatkan risiko anemia yang dapat memperburuk perdarahan postpartum. Jarak kehamilan yang kurang dari dua tahun juga dikaitkan dengan peningkatan risiko kelainan plasenta seperti plasenta previa dan plasenta akreta, yang dapat menyebabkan perdarahan hebat selama atau setelah persalinan.

E. Tanda dan Gejala

Tanda utama perdarahan pascasalin akibat atonia uteri adalah keluarnya darah dalam jumlah berlebihan setelah kelahiran bayi atau plasenta. Gejala yang khas meliputi aliran darah yang deras, lemahnya kontraksi uterus yang tidak membaik meskipun telah dilakukan pijatan, serta pasien yang dengan cepat mengalami syok hemoragik. Metode kuantifikasi kehilangan darah telah direkomendasikan untuk perhitungan yang lebih akurat, termasuk penggunaan kain penutup bokong bertingkat, bantalan laparotomi, penimbangan spons, teknologi berbasis kecerdasan buatan, serta tabung irigasi. Pendekatan ini lebih efektif dibandingkan strategi sebelumnya yang bergantung pada pemantauan perubahan kadar hemoglobin dan bertujuan untuk mendeteksi perdarahan pascapersalinan lebih dini (Kelly C. Wormer; Radia T. Jamil; Suzanne B. Bryant, 2025).i. Perkiraan jumlah darah dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini.

			
Puddle of 100 cm in diameter	Bed with puddle on sheet	Vaginal bleeding with blood flowing to the floor	
Dressings			
			
50% = 25 mL	75% = 50 mL	100% = 75 mL	Dripping compress = 100 mL
Puddle 50 cm in diameter		500 mL	
Puddle 75 cm in diameter		1,000 mL	
Puddle of 100 cm in diameter		1,500 mL	
Bed with puddle of blood on the sheet -		Probably less than 1000 mL	
Vaginal bleeding with blood flowing to the floor		Probably exceeds 1000 mL	

Gambar 1.1 Penilaian Visualisasi Jumlah Perdarahan
(Sumber: Sirait.Batara, 2022)

Keterlambatan dalam menilai volume darah yang keluar dapat menyebabkan dampak serius atau menyebabkan syok hipovolemi. Penilaian klinis tanda-tanda kehilangan darah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1 Tanda Klinis pada Perdarahan Post partum

Volume Darah	Denyut Nadi	Tekanan Darah Sistolik	Tanda	Syok
500 -1000 ml (10 – 15%)	80 – 100 kali/menit	Normal	Teraba takikardi, pening	Terkompensasi
1000 – 1500 ml (15 – 30 %)	100 – 120 kali/menit	Turun ringan (80 – 90 mmHg)	Lemas, takikardi, berkeringat	Ringan
1500 – 2000 ml (30 – 40%)	> 120 kali/menit	Turun sedang (70 – 80 mmHg)	Gelisah, pucat, oliguria	Sedang
2000 - 3000 ml (> 40%)	> 120 kali /menit dengan adanya kegagalan miokardium sehingga menimbulkan reduksi paradoksial hingga terjadi <i>cardiac arrest</i> .	Turun Berat (50 – 70 mmHg)	Peingsan, anuria, sesak	Berat

(Sumber: (Ghosh & Chandharan, 2017)

F. Penatalaksanaan Perdarahan Post Partum

Algoritma penatalaksanaan perdarahan post partum menggunakan Mnemonic HAEMOSTASIS telah diusulkan sebagai panduan dalam menangani perdarahan postpartum secara sistematis dan bertahap. Studi observasional retrospektif terbaru menunjukkan bahwa penerapan algoritma ini berkontribusi dalam meningkatkan luaran klinis serta mengurangi risiko histerektomi peripartum (Ghosh & Chandharan, 2017; Julieta & Widiastuti Giri, 2021; The American College of Obstetricians and Gynecologists, 2020).

Istilah "HAEMO" merujuk pada tindakan segera untuk menghentikan perdarahan, sedangkan "STASIS" mengacu pada langkah-langkah lanjutan dalam penatalaksanaan. Langkah-langkah dari penatalaksanaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. **H= Help** atau meminta bantuan segera dari tim medis lain untuk penanganan yang lebih efektif

2. **A = Asses** atau menilai kondisi pasien, termasuk tanda-tanda vital dan tingkat kesadaran, serta memasang akses intravena dengan kateter berukuran besar (18G) untuk resusitasi cairan.
3. **E = Establish etiology** yaitu menentukan penyebab perdarahan dengan melakukan evaluasi terhadap uterus dan jalan lahir.
4. **M = Massage** yaitu melakukan masase uterus untuk merangsang kontraksi dan mengurangi perdarahan.
5. **O = Oxytocin** dengan cara memberikan obat uterotonika seperti oksitosin atau misoprostol untuk meningkatkan kontraksi uterus.
6. **S = Shift to surgery if needed**, apabila terjadi perdarahan yang tidak terkontrol dengan langkah sebelumnya, pertimbangkan intervensi bedah seperti kompresi bimanual, kompresi aorta abdominal, atau prosedur bedah lainnya.
7. **T = Tamponade** yaitu menggunakan tamponade uterus, seperti balon Bakri, untuk menekan area perdarahan.
8. **A = Apply compression sutures** yaitu melakukan jahitan kompresi pada uterus jika diperlukan.
9. **S = Systematic devascularization** yaitu melakukan ligasi arteri uterina atau arteri iliaka interna untuk mengurangi aliran darah ke uterus.
10. **I = Interventional radiology** yaitu mempertimbangkan embolisasi arteri uterina melalui prosedur radiologi intervensional jika fasilitas tersedia.
11. **S = Subtotal/total hysterectomy**, sebagai upaya terakhir, melakukan histerektomi subtotal atau total jika perdarahan tidak dapat dikendalikan dengan metode lain.

G. Implikasi dalam Asuhan Keperawatan

1. Pengkajian Keperawatan

Langkah pertama dalam asuhan keperawatan adalah melakukan pengkajian keperawatan secara komprehensif untuk mengumpulkan data subjektif dan objektif dari pasien yang mengalami perdarahan post partum yang meliputi data-data sebagai berikut:

- a. Gejala perdarahan post partum akut
 - 1) Umum: lemas, merasa lemas saat berdiri, merasa kedinginan, gelisah
 - 2) Sistem saraf pusat: pusing, kehilangan kesadaran
 - 3) Kardiovaskular: palpitasi, takikardia, penurunan tekanan darah
 - 4) Pernapasan: takipnea
 - 5) Integumen: berkeringat, pucat
 - 6) Genitourinari: penurunan atau tidak ada produksi urine

b. Riwayat Kesehatan

Kaji riwayat kesehatan pasien sebelumnya meliputi riwayat perdarahan atau kondisi- kondisi pyang berisiko terjadinya perdarahan post partum, misalnya preeklampsia, eklampsia, anemia, hipertensi, gangguan pembekuan darah, infeksi, usia risiko (< 20 tahun atau > 35 tahun).

c. Riwayat Obstetri

Kaji kondisi yang berisiko terjadinya perdarahan post partum, misalnya masalah placenta, retensio placenta, kehamilan kembar, makrosomia, polihidramnion, interval kehamilan < 2 tahun, primigravida atau grande gravida.

d. Penggunaan obat-obatan

Kaji apakah pasien menggunakan obat-obatan antikoagulan, NSIAD, steroid oral, SSRI atau SNRI.

e. Pemeriksaan fisik

1) Observasi tanda-tanda vital dan pengeluaran darah pervaginam

Takikardia dan hipotensi adalah dua gejala yang berhubungan dengan kehilangan darah pada wanita pascapersalinan. Perhatikan perubahan denyut jantung dan tekanan darah sebagai respons terhadap kehilangan volume darah yang signifikan (lebih dari 25% dari total volume darah).

2) Periksa genetalia

Kaji adanya laserasi, hematoma atau ruptur uterus. Periksa dan palpasi serviks dan vagina setelah melahirkan per vaginam.

3) Periksa apakah ada jaringan placenta yang tertinggal

Plasenta seharusnya dikeluarkan secara keseluruhan melalui vagina dalam waktu 30 menit setelah persalinan. Plasenta yang dikeluarkan harus dalam keadaan utuh, dan perawat bertanggung jawab untuk memeriksanya guna memastikan tidak ada bagian yang tertinggal. Jika terdapat sisa jaringan plasenta di dalam tubuh, hal ini dapat menyebabkan komplikasi seperti demam, keluarnya cairan dengan bau tidak sedap, perdarahan, serta nyeri.

4) Periksa uterus

Lakukan palpasi uterus untuk melakukan penilaian kontraksi atau tonus dan ukuran uterus. Apabila uterus teraba lembek atau lunak atau tidak berkontraksi maka akan menyebabkan terjadinya perdarahan. Kondisi tersebut dinamakan atonia uterus yang merupakan penyebab tersering dari perdarahan post partum.

5) Periksa kemungkinan Disseminated intravascular coagulation (DIC)

DIC merupakan gangguan pada faktor pembekuan darah yang mengakibatkan perdarahan luas dari berbagai area tubuh, seperti hidung,

gusi, dan lokasi pemasangan infus. Kondisi ini juga dapat menimbulkan gejala berupa memar, tekanan darah rendah (hipotensi), sesak napas (dispnea), serta kebingungan.

6) Observasi Lokia

Setelah persalinan, perdarahan melalui vagina merupakan kondisi yang diperkirakan akan terjadi. Pada beberapa hari pertama postpartum, lokia berwarna merah dan menyerupai perdarahan menstruasi yang cukup deras. Namun, apabila pasien mengalami perdarahan yang berlebihan hingga harus mengganti lebih dari satu pembalut setiap jam atau mengeluarkan gumpalan darah berukuran besar, maka diperlukan tindakan medis segera.

f. Prosedur Diagnostik

1) Pemeriksaan darah : Hitung sel darah lengkap, hemoglobin, hematokrit, trombosit, waktu pembekuan darah dan golongan darah,

2) USG

Untuk menilai uterus apakah ada gumpalan darah atau ada jaringan placenta yang tertahan.

2. Intervensi Keperawatan

a. Mengelola Perdarahan

1) Atasi faktor penyebab

Penanganan dan manajemen perdarahan postpartum bertujuan untuk melakukan resusitasi terhadap pasien sambil menentukan serta mengatasi penyebab yang mendasarinya.

2) Pastikan perfusi organ berlangsung secara terus-menerus.

Mempertahankan stabilitas hemodinamik pasien sangat penting untuk memastikan perfusi yang berkelanjutan pada organ vital. Pastikan akses intravena (IV) dengan diameter besar tetap terbuka. Angkat kaki pasien untuk meningkatkan aliran balik vena. Berikan oksigen tambahan sesuai kebutuhan.

3) Berikan cairan intravena

Pemberian cairan intravena secara masif akan membantu menjaga homeostatis cairan pasien, misalnya NaCl 0,9 % atau ringer laktat.

4) Berikan transfusi darah

Pemberian produk darah perlu menjadi prioritas utama, dengan pemantauan ketat terhadap jumlah darah yang hilang secara keseluruhan. Jika terjadi gangguan koagulasi, transfusi plasma beku segar atau trombosit dapat diperlukan.

5) Monitor tanda-tanda vital dan urine output

Lakukan pemantauan terhadap tekanan darah, denyut nadi, saturasi oksigen, dan keluaran urin untuk menilai perfusi serta respons terhadap pengobatan.

6) Perbaiki trauma

Memperbaiki trauma dapat dilakukan dengan segera melakukan tindakan bedah yang meliputi eksplorasi uterus untuk mendeteksi ruptur, perbaikan laserasi dan perbaikan insersi uterus.

7) Atasi Atonia uterus

Penanganan perdarahan postpartum akibat atonia uteri dapat dilakukan melalui kompresi bimanual, tindakan bedah, tamponade uterus, embolisasi arteri panggul, serta pemberian obat uterotonika, seperti oksitosin atau karboprost intramuskular.

8) Membantu dalam mengeluarkan jaringan yang tertahan

Pengangkatan jaringan yang tertahan dapat dilakukan secara manual atau melalui prosedur dilatasi dan kuretase.

9) Persiapkan pasien untuk tindakan bedah

Jika terjadi perdarahan berulang pada pasien yang stabil, diperlukan ligasi arteri yang mengalami perdarahan. Fluoroskopi digunakan untuk mengidentifikasi dan menutup pembuluh darah yang berdarah. Ruptur uterus dapat memerlukan laparotomi atau histerektomi jika perbaikan tidak memungkinkan.

b. Mencegah Perdarahan Lebih Lanjut

1) Identifikasi risiko perdarahan

Identifikasi pasien dengan risiko tinggi sebelum persalinan merupakan langkah penting dalam mencegah morbiditas dan kematian akibat perdarahan postpartum. Evaluasi ultrasonografi sebelum melahirkan dapat membantu dalam memilih metode persalinan yang paling sesuai.

2) Berikan suplemen zat besi sesuai anjuran

Pemberian suplemen zat besi secara oral diberikan pada pasien yang mengalami anemia terutama apabila hematokrit kurang dari 30%.

3) Berikan Agen Eritropoietin sesuai anjuran

Pasien berisiko tinggi, terutama yang menolak transfusi darah, sebaiknya diberikan obat perangsang eritropoietin dengan pendampingan konseling hematologi.

4) Kolaborasi dengan penyedia layanan kesehatan

Kolaborasi dengan penyedia layanan kesehatan sangat penting dalam menentukan keputusan yang tepat selama persalinan, terutama dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko

perdarahan, seperti operasi sesar, anestesi umum, persalinan yang berkepanjangan, infeksi saat persalinan, serta riwayat perdarahan postpartum sebelumnya.

5) Segera menyusui

Mendorong ibu untuk menyusui sesegera mungkin dapat merangsang pelepasan oksitosin secara alami, yang membantu kontraksi uterus dan mengurangi risiko perdarahan.

6) Berikan edukasi tentang tanda-tanda perdarahan post partum sekunder

Perdarahan post partum sekunder terjadi hingga enam minggu setelah melahirkan. Berikan edukasi kepada pasien untuk memantau tanda-tanda perdarahan seperti perubahan lochia, kram perut yang parah, demam, atau pusing dan segera hubungi fasilitas kesehatan.

H. Kesimpulan

Perdarahan post partum tetap menjadi tantangan serius dalam pelayanan maternal. Pencegahan dan deteksi dini dapat dilakukan melalui pemeriksaan antenatal yang baik serta manajemen aktif kala III. Penggunaan algoritma penanganan seperti HAEMOSTASIS dapat membantu meningkatkan kualitas asuhan dan menurunkan risiko komplikasi. Dengan kolaborasi tenaga kesehatan, ketersediaan fasilitas medis yang memadai, serta edukasi kepada ibu hamil dan keluarga, angka kejadian dan dampak perdarahan post partum dapat ditekan secara signifikan.

I. Referensi

- Ahmad, H. F. S. D., Setyawati, T., & Saranga, D. (2020). Laporan Kasus: Ruptur Uteri Inkomplit Disertai Intrauterine Fetal Death Pada Pasien Multiparitas. *Jurnal Medical Profession (MedPro)*, 2(2), 155–160.
- Atmoko, R. W., Amelia, R., & Setianingsih, A. (2021). The Corellations between Anemia and Chronic Energy Deficiency with the Long of First Stage of Childbirth. *Jurnal Kebidanan*, 11(2), 169–174. <https://doi.org/10.31983/jkb.v11i2.7798>
- Borovac-Pinheiro, A., Pacagnella, R. C., Cecatti, J. G., Miller, S., El Ayadi, A. M., Souza, J. P., Durocher, J., Blumenthal, P. D., & Winikoff, B. (2018). Postpartum hemorrhage: new insights for definition and diagnosis. *American journal of obstetrics and gynecology*, 219(2), 162–168. <https://doi.org/10.1016/j.ajog.2018.04.013>
- Delpia, Y. V. (2020). The Relationship of Pre Eclampsia With Postpartum Hemorrhage at Dr. Abdul Aziz Hospital Singkawang. *Journal GEEJ*, 7(2).

- Ende, H. B., Lozada, M. J., Chestnut, D. H., Osmundson, S. S., Walden, R. L., Shotwell, M. S., & Bauchat, J. R. (2021). Risk Factors for Atonic Postpartum Hemorrhage: A Systematic Review and Meta-analysis. *Obstetrics and Gynecology*, 137(2), 305–323. <https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000004228>
- Evensen, A., Anderson, J. M., & Fontaine, P. (2017). Postpartum Hemorrhage: Prevention and Treatment - American Family Physician. *Am Fam Physician*, 95(7), 442–449. <https://www.aafp.org/afp/2017/0401/p442.html>
- Ghosh, M., & Chandharan, E. (2017). Management of post-partum haemorrhage. *Obstetrics, Gynaecology, and Reproductive Medicine*, 27(8), 239–244. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ogrm.2017.06.002>
- Gurnita, A., & Irianti, S. (2023). Prevalensi dan Luaran Pasien dengan Spektrum Plasenta Akreta. *Indonesian Journal of Obstetrics & Gynecology Science*, 6(2), 247–254. <https://doi.org/10.24198/obgynia/v6.n2.293>
- Gustika Anggriani. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Perdarahan Pasca Persalinan di RSUD Kota Prabumulih Tahun 2019. *Jurnal Kebidanan: Jurnal Medical Science Ilmu Kesehatan Akademi Kebidanan Budi Mulia Palembang*, 10(2), 22–27. <https://doi.org/10.35325/kebidanan.v10i2.235>
- Gyamfi-Bannerman, C., Srinivas, S. K., Wright, J. D., Goffman, D., Siddiq, Z., D'Alton, M. E., & Friedman, A. M. (2018). Postpartum hemorrhage outcomes and race. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, 219(2), 185.e1–185.e10. <https://doi.org/10.1016/j.ajog.2018.04.052>
- Gyanendra, I. M., Tresna, N., Ayu, N., Maharani, A., & Devian, N. W. (2024). Atony : A Literatur Review. *Jurnal Biologi Tropis Uterine*, 24(1b), 272–280.
- Hapsari Dewi, F., Uyun, Y., & Suryono, B. (2022). Peran Rotational Tromboelastometry pada Perdarahan Postpartum. *Jurnal Anestesi Obstetri Indonesia*, 5(1), 51–59. <https://doi.org/10.47507/obstetri.v5i1.77>
- Harsono, O., Bisri, D. Y., & Rachman, I. A. (2023). Gambaran Jumlah Perdarahan pada Seksio Sesarea Spektrum Plasenta Akreta di RSUP Hasan Sadikin Bulan Januari 2020-Desember 2021. *Jurnal Anestesi Obstetri Indonesia*, 6(2), 69–75. <https://doi.org/10.47507/obstetri.v6i2.135>
- Janah, N., Altika, S., Darsono, & Fauzia, R. L. (2023). Hubungan Anemia dengan Kejadian Perdarahan Pada Ibu Postpartum di RS Elia Waran Kabupaten Manokwari Selatan. *Jurnal Penelitian Pengabdian Bidan*, 1(1), 21–30. <https://jppb.stikesbup.ac.id/index.php/jppb/issue/view/1>
- Julieta, N. P. N., & Widiastuti Giri, M. K. (2021). Postpartum Hemorrhage: Kegawatdaruratan dalam Persalinan Ibu Hamil. *Ganesha Medicine*, 1(1), 48. <https://doi.org/10.23887/gm.v1i1.31709>

- Kelly C. Wormer ; Radia T. Jamil ; Suzanne B. Bryant. (2025). *Postpartum Hemorrhage*. StatPearls Publishing LLC.
- Kogutt, B. K., & Vaught, A. J. (2019). Postpartum hemorrhage: Blood product management and massive transfusion. *Seminars in Perinatology*, 43(1), 44–50. <https://doi.org/10.1053/j.semperi.2018.11.008>
- Masuzawa, Y., & Yaeko, K. (2017). Uterine activity during the two hours after placental delivery among low-risk pregnancies: an observational study. *Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine*, 30(20), 2446–2451. <https://doi.org/10.1080/14767058.2016.1253057>
- Melati Julizar, Jusuf S.Effendi, H. S. (2019). Analisis Faktor Risiko Atonia Uteri. *Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan*, 7(3), 108–117. <https://dx.doi.org/10.33366/jc.v7i3.1399>
- POGI Himpunan Kedokteran Feto Maternal. (2016). Perdarahan Pasca-Salin. *Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran POGI*.
- Pribadi, A. (2023). Upaya memperkecil komplikasi spektrum plasenta akreta. 23(1), 211–214. <https://doi.org/10.24815/jks.v23i1.25833>
- Rachman Adi Pradana, M. A., & Febri Asshiddiq, M. R. (2021). Hubungan Antara Paritas dengan Kejadian Perdarahan Post Partum. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 10(1), 326–331. <https://doi.org/10.35816/jiskh.v10i1.565>
- Rifdiani, I. (2016). Pengaruh Paritas, BBL, Jarak Kehamilan dan Riwayat Perdarahan Terhadap Kejadian Perdarahan Post Partum. *Jurnal Berkala Epidemiologi*, 4(3), 396–407. <https://doi.org/10.20473/jbe.v4i3>
- Rudiyanti, N., & Metti, D. (2017). Anemia dan kontraksi rahim dalam proses persalinan. *Jurnal Ilmiah Keperawatan Sai Betik*, 10(1), 57–63.
- Saifuddin.A. (2014). *Buku Panduan Praktis: Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*. Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardja.
- Sari, L. F. (2018). Kejadian Perdarahan postpartum dengan paritas dan Anemia. 3(2), 1–6.
- Sari, M. H., & Nurliah. (2022). Hubungan Paritas Dan Umur Ibu Dengan Kejadian Perdaean Post Partum. *Journal of Nursing and Midwifery, Volume 4 n(1)*, 1–10.
- Sulistyoningtyas. (2020). Characteristics and Treatment of Bleeding in Postpartum Mothers. *Jurnal Keperawatan*, 12(1), 141–146. <https://doi.org/10.32583/keperawatan.v12i1.713>
- The American College of Obstetricians and Gynecologists. (2020). Clinical Management Guidelines for Obstetrician. *ACOG Practice Bulletin*, 135(72), 1–17.

Wardani, P. K. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Perdarahan Pasca Persalinan. *Jurnal Aisyah: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 2(1), 51–60. <https://doi.org/10.30604/jika.v2i1.32>

J. Glosarium

Atonia uteri	= kondisi ketika uterus gagal berkontraksi setelah proses persalinan
Hemostatis	= proses alamiah tubuh dalam menghentikan perdarahan melalui pembekuan darah dan penyempitan pembuluh darah
Kompresi bimanual	= Teknik menekan rahim dengan tangan dari dalam dan luar untuk membantu menghentikan perdarahan akibat atonia uteri
PPS	= Perdarahan Pasca Salin

CHAPTER 2

KESEHATAN SEKSUAL PASKA PERSALINAN: MENGEMBALIKAN FUNGSI REPRODUKSI

Dr. ns. Machmudah, M.Kep., Sp.Kep.Mat.

A. Pendahuluan/Prolog

Kehamilan dan persalinan akan menyebabkan beberapa perubahan pada perempuan yang akan memengaruhi kesejahteraan dan kualitas hidup. *World Health Organization* (WHO) menjelaskan bahwa kesehatan seksual merupakan komponen penting dari kualitas hidup seseorang yang mencakup aspek fisik, emosional, mental, dan sosial yang berkaitan dengan seksualitas (WHO, 2022). Fase postpartum bagi seorang ibu menjadi salah satu periode kritis dalam kehidupan seksual karena berbagai perubahan yang terjadi setelah persalinan. Perubahan ini tidak hanya memengaruhi fungsi reproduksi, tetapi juga kualitas hubungan pasangan secara keseluruhan. Dalam periode postpartum, ibu sering kali menghadapi tantangan dalam mengembalikan fungsi seksual dan reproduksi yang optimal akibat faktor fisiologis, hormonal, psikologis, dan sosial yang kompleks (Khajehei et al., 2018).

Secara fisiologis, proses persalinan dapat menimbulkan trauma pada area genital, seperti robekan perineum, episiotomi, atau prosedur operasi sesar. Trauma ini membutuhkan waktu pemulihan yang bervariasi, yang sering kali disertai dengan rasa nyeri saat berhubungan seksual (dyspareunia) dan kekeringan vagina akibat penurunan kadar estrogen. Selain itu, kelelahan fisik yang dialami ibu sebagai akibat dari perawatan bayi baru lahir dan perubahan pola tidur turut berkontribusi terhadap penurunan libido (Baattaiah et al., 2023). Pada ibu menyusui, peningkatan hormon prolaktin yang mendukung laktasi juga menyebabkan penghambatan ovulasi, yang secara tidak langsung menekan dorongan seksual (Grussu et al., 2021).

Dari sisi psikologis, perubahan besar yang terjadi dalam tubuh setelah persalinan dapat memengaruhi citra tubuh ibu. Perubahan bentuk tubuh, stretch marks, dan kenaikan berat badan sering kali menurunkan rasa percaya diri perempuan terhadap penampilan mereka, yang berdampak pada kehidupan seksual mereka (Khajehei et al., 2018). Selain itu, perasaan cemas, stres, dan depresi postpartum yang dialami oleh sebagian ibu dapat mengurangi minat terhadap aktivitas seksual (Basnet et al., 2020). Kesehatan mental ibu yang terganggu juga

dapat memengaruhi interaksi emosional dengan pasangan, yang menjadi faktor penting dalam menjaga keintiman seksual.

Secara sosial, relasi pasangan juga mengalami dinamika selama masa postpartum. Peran baru sebagai orang tua sering kali menyita waktu dan energi, sehingga menurunkan prioritas terhadap hubungan intim dengan pasangan. Kurangnya komunikasi antara pasangan mengenai perubahan yang dialami ibu postpartum juga dapat menciptakan jarak emosional yang berujung pada penurunan kualitas hubungan seksual (Jahangiry et al., 2021). Selain itu, tekanan sosial untuk segera kembali ke fungsi seksual seperti sebelum melahirkan dapat menyebabkan stres tambahan bagi ibu.

Dimulainya kembali hubungan seksual setelah melahirkan membutuhkan penyesuaian bagi pasangan, baik penyesuaian fisik, psikologis, sosial dan budaya. Dari beberapa hasil penelitian, para profesional kesehatan mempertimbangkan enam minggu sebagai periode minimum untuk memulai kembali hubungan seksual dengan nyaman. Upaya mengembalikan fungsi reproduksi dan kesehatan seksual ibu postpartum memerlukan pendekatan holistik yang mencakup aspek medis, psikologis, dan sosial. Edukasi kesehatan seksual kepada ibu dan pasangan menjadi salah satu intervensi utama yang dapat membantu mengurangi ketidaknyamanan dan meningkatkan pemahaman mengenai perubahan yang normal terjadi selama masa postpartum. Intervensi lain seperti latihan otot dasar panggul, penggunaan pelumas vagina, konseling psikologis, serta pemberdayaan pasangan dalam mendukung pemulihan ibu juga penting untuk dilakukan (McDonald et al., 2020).

Kajian literatur menunjukkan bahwa prevalensi disfungsi seksual postpartum cukup tinggi, yaitu berkisar antara 40-80% pada tiga bulan pertama setelah melahirkan, dan sebagian ibu mengalami keluhan tersebut hingga satu tahun postpartum (Artieta-pinedo et al., 2025; Naigino & Makumbi, 2021). Hal ini menunjukkan pentingnya perhatian khusus terhadap kesehatan seksual ibu postpartum sebagai bagian dari perawatan pasca persalinan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pemulihan fungsi seksual postpartum dan mengembangkan intervensi berbasis bukti untuk mendukung ibu dalam fase ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, pembahasan dalam bab ini difokuskan pada perubahan fisik, hormonal, psikologis, dan sosial yang memengaruhi kesehatan seksual postpartum, serta strategi intervensi yang dapat membantu ibu mengembalikan fungsi reproduksi dan meningkatkan kualitas hidup. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai kesehatan seksual postpartum, diharapkan tenaga kesehatan dapat memberikan perawatan yang lebih komprehensif dan

berpusat pada ibu, sehingga mendukung transisi yang lebih sehat menuju peran sebagai orang tua.

B. Perubahan Fisiologis dan Psikologis Ibu Postpartum yang Memengaruhi Pola Seksual

1. Perubahan Fisiologis

a. Involusi Uterus

Involusi uterus merupakan proses kembalinya uterus pada ukuran dan konsistensi seperti sebelum hamil (Reeder, 2011). Proses involusi uterus ini di kaji dengan cara mengukur tinggi dan konsistensi fundus uteri. Fundus uteri akan turun sekita 1 cm atau satu jari per hari. Pada hari ke-10 postpartum, fundus uteri sudah tidak adapat lagi di palpasi diatas abdomen. Involusi uterus yang bagus akan di tandai dengan konsistensi fundus yang keras.

Proses pulihnya uterus juga di tandai dengan pengeluaran lokea. Jumlah dan karakter lokea menggambarkan kemajuan penyembuhan endometrium. Jumlah lokea perlahan-lahan akan berkurang diikuti dengan perubahan warna yang menunjukkan penurunan komponen darah dalam lokea. Lokea alba berwarna gelap, keluar pada hari 1 sampai 3 hari setelah persalinan. Setelah hari ke empat postpartum lokea menjadi leboh seros dan warna merah muda, disebut lokea serosa. Setelah 1 minggu sampai 10 hari postpartum, lokea menjadi berwarna putih kekuningan dengan jumlah yang sangat sedikit, disebut lokea alba. Lokea alba diproduksi sampai sekitar tiga minggu paskapartum dan menandakan kemajuan penyembuhan endometrium.

Jika lokea serosa atau lokea alba terus keluar disertai dengan rabas kecokelatan dan berbau tidak sedap, demam serta nyeri abdomen, maka ada kemungkina terjadi infeksi pada endometrium (endometritis).

b. Serviks

Segera setelah persalinan, serviks akan mendatar dan terjadi perubahan tonus, menjadi lebih lunak, edema dan mengalami banyak laserasi. Serviks ukurannya dapat mencapai dua jari dan ketebalannya sekitar 1 cm. Serviks dalam 24 jam akan memendek dan menjadi lebih keras dan tebal. Mulut serviks secara bertahap menutup, ukurannya 2 sampai 3 sm setelah beberapa hari dan menjadi 1 cm dalam waktu 1 minggu. Pemeriksaan histologi serviks segera setelah melahirkan menunjukkan adanya edema dan perdarahan. Proses involusi serviks terus berlanjut sampai lebih dari 6 minggu dengan edema dan infiltrasi sel bundar yang masih terjadi selama tiga sampai empat bulan.

c. Vagina dan Perineum

Vagina menjadi lunak dan bengkak dan memiliki tonus yang buruk setelah persalinan. Setelah tiga minggu vaskularisasi, edema dan hipertropi akibat kehamilan dan persalinan berkurang secara nyata. Pemeriksaan mikroskopik sel vagina menunjukkan bahwa sel epitelium vagina tampak atropik pada minggu ke tiga sampai ke empat. Sel-sel vagina mencapai indeks estrogen sebagaimana mestinya pada minggu ke -6 sampai minggu ke-10 paskapartum. Defisiensi estrogen ini akan menyebabkan berkurangnya lubrikasi pada vagin dan penurunan vasokongesti yang menyebabkan penurunan respon seksual pada minggu awal setelah persalinan.

Rugae vagina muncul kembali setelah minggu ke empat paskapartum, meskipun tidak setebal pada ibu nullipara. Mukosa vagina menebal ketika fungsi ovarium kembali dan sering ditemui tetap atropik pada ibu yang menyusui sampai siklus menstruasi kembali.

Pada ibu yang melahirkan pervaginam dapat terjadi robekan perineum atau luka yang disebabkan tindakan episiotomi. Nyeri perineum (dyspareunia) akan berkurang dan hilang setelah satu bulan paskapartum meskipun pada beberapa ibu dyspareunia dirasakan sampai lebih dari 6 bulan pada ibu yang melahirkan dengan episiotomi, laserasi, persalinan dengan forceps atau ekstraksi vakum. Nyeri akibat trauma jaringan atau sayatan perineum dapat menyebabkan ketakutan dan kecemasan saat melakukan hubungan seksual.

d. Payudara

Payudara mengalami perubahan yang progresif selama kehamilan untuk persiapan laktasi. Peningkatan hormon estrogen dan progesteron saat kehamilan akan menyebabkan tumbuhnya lobulus dan alveolus payudara. Setelah proses persalinan selesai yaitu dengan pelepasan plasenta terjadi penurunan kadar hormone estrogen dan progesterone dalam darah. Sebagai gantinya terjadi sekresi hormone prolactin oleh kelenjar hipofisis anterior. Sekresi air susu dimulai dari dasar sel-sel alveolar, tempat tetesan kecil dibentuk dan kemudian bermigrasi ke membrane sel, tetesan kecil ini dikeluarkan kedalam saluran alveolar untuk disimpan. Pengeluaran air susu atau letdown merupakan suatu proses kontraksi sel mioepitel payudara yang mendorong air susu melewati saluran lalu masuk ke sinus laktiferus yang terletak dibawah areola. Air susu keluar dari sinus laktiferus melalui mekanisme isapan bayi. Suatu refleks neurohormonal mengontrol pengeluaran air susu atau refleks letdown dan bekerja melewati jaras saraf aferen menuju hipotalamus yang akan menyebabkan di sekresikannya hormone oksitosin yang dilepaskan oleh hipofisis posterior dan menyebabkan kontraksi mioepitel

payudara. Isapan bayi merupakan stimulus aferen utama untuk menstimulus refleks letdown, meskipun refleks letdown dapat di stimulus dengan pendengaran (mendengar tangisan bayi) dan stimulus visual (melihat bayi) (Bland, 2012).

Pada ibu menyusui, peningkatan prolaktin dan penurunan estrogen dapat menyebabkan kekeringan pada vagina karena berkurangnya lubrikasi pada vagina serta menurunkan hasrat seksual. Selain itu, refleks let-down saat menyusui dapat menyebabkan kebocoran ASI selama hubungan seksual, yang dapat membuat ibu merasa canggung (Yılmaz, 2019). Menyusui menjadi salah satu penyebab dyspareunia yang dirasakan oleh ibu postpartum. Ibu yang menyusui mempunyai keluhan dyspareunia lebih dari 4 kali dibandingkan dengan ibu yang tidak menyusui (Signorello et al., 2021).

e. Perubahan Hormon

Setelah plasenta dilahirkan, kadar plasma hormone yang diproduksi oleh plasenta mengalami penurunan secara cepat. Hormon *human placental lactogen* (hPL) tidak dapat dideteksi dalam 24 jam dan hormon gonadotropin korionik turun dengan cepat. Kadar hormon estrogen dan progesteron menurun drastis (90% dalam 3 jam setelah persalinan) dan secara kontinu menurun secara lambat sampai hari ke 7. setelah melahirkan. Penurunan estrogen dapat menyebabkan kekeringan pada vagina, yang sering kali membuat hubungan seksual menjadi tidak nyaman atau menyakitkan (Berens & Brook, 2019). Selain itu, hormon prolaktin, yang meningkat untuk mendukung laktasi, dapat menekan dorongan seksual karena mengurangi kadar hormon testosteron yang juga berperan dalam libido. Pada ibu yang tidak menyusui, proses ovulasi akan terjadi pada hari ke 27 paska persalinan. Menstruasi yang terjadi setelah 6 minggu paska persalinan jarang melepaskan ovum.

2. Perubahan Psikologis

a. Perubahan Citra Tubuh

Perubahan fisik setelah persalinan, seperti kenaikan berat badan, stretch marks, atau perubahan bentuk tubuh, dapat membuat ibu merasa kurang percaya diri terhadap penampilan mereka. Hal ini dapat menurunkan minat untuk berhubungan seksual (Nazanin et al., 2017; Signorello et al., 2021).

b. Gangguan Psikologis pada Ibu Postpartum.

Depresi postpartum dialami oleh sekitar 10-15% perempuan setelah melahirkan. Gejala seperti kelelahan emosional, rasa bersalah, dan kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya menyenangkan (termasuk aktivitas

seksual) merupakan ciri khasnya (Lara-Cinisomo et al., 2017). Kecemasan terkait tanggung jawab sebagai orang tua baru juga dapat menurunkan libido.

c. Perubahan Peran dan Hubungan dengan Pasangan

Dinamika hubungan pasangan dapat berubah pasca persalinan. Fokus yang teralihkan kepada bayi baru lahir, kurangnya waktu untuk komunikasi, dan kelelahan bersama dapat menciptakan jarak emosional yang berpengaruh pada kehidupan seksual pasangan (Malley et al., 2023).

d. Pengaruh Sosial dan Budaya

Beberapa budaya menempatkan tekanan pada ibu untuk segera pulih secara seksual setelah melahirkan. Tekanan ini dapat menciptakan kecemasan tambahan yang berdampak negatif pada fungsi seksual (Yildiz, 2021).

C. Faktor yang Memengaruhi Perubahan Seksual pada Ibu Postpartum

1. Jenis Persalinan

Peningkatan kerusakan pada saraf pudenda dan sfingter ani terjadi pada persalinan pervaginam spontan, persalinan pervaginam dengan bantuan dan episiotomi membuat ibu berisiko lebih besar mengalami disfungsi seksual, terutama nyeri perineum dan dispareunia, inkontinensia fekal dan urin yang lebih besar, keinginan yang lebih rendah untuk terlibat dalam aktivitas seksual, dan penundaan dalam memulai kembali hubungan seksual setelah melahirkan (Jansson et al., 2020). Episiotomi, terutama pada garis tengah dibandingkan dengan mediolateral, tampaknya menjadi faktor risiko utama terjadinya dispareunia (Naigino & Makumbi, 2021), yang menyebabkan nyeri perineum lebih parah dibandingkan nyeri akibat robekam perineum spontan. Nyeri perineum dan dispareunia, yang signifikan di antara parameter disfungsi seksual yang paling sering terjadi setelah melahirkan, berkorelasi dengan tingkat trauma perineum dan dengan demikian memengaruhi keputusan untuk melakukan hubungan seksual (Review & Moghadam, 2024). Pada tiga bulan pascapersalinan, ibu postpartum dengan kerusakan perineum yang lebih besar mengalami dispareunia lebih sering dan untuk waktu yang lebih lama daripada ibu dengan kerusakan perineum yang lebih sedikit atau tidak ada, tetapi perbedaannya menurun pada enam bulan. Ada perbedaan yang signifikan dalam keterlambatan dimulainya kembali hubungan seksual pascapersalinan serta masalah seksual dan depresi tambahan. Persalinan pervaginam operatif menyebabkan nyeri perineum dalam jangka pendek dan menengah, tetapi ternyata menjadi faktor risiko independen untuk dispareunia dalam studi jangka panjang (Opondo et al., 2023).

Sebaliknya, bukti lain menunjukkan bagaimana dispareunia pascapersalinan tampaknya berkorelasi sebagian besar dengan dispareunia sebelum melahirkan

dan menyusui daripada dengan metode persalinan. Demikian pula, kemampuan untuk mencapai orgasme, dan hasrat serta kepuasan seksual tampaknya tidak terkait dengan metode persalinan enam bulan setelah persalinan (Nazanin et al., 2017).

Peran protektif operasi caesar terhadap seksualitas tidak jelas. Operasi caesar tampaknya menurunkan kejadian dispareunia dalam tiga hingga enam bulan pertama pascapersalinan dibandingkan dengan persalinan pervaginam, tetapi tampaknya tidak memiliki dampak jangka panjang mengingat pada satu tahun setelah melahirkan tidak ada perbedaan Kepuasan seksual tampaknya secara kualitatif lebih baik pada ibu yang melahirkan melalui operasi caesar karena otot-otot dasar panggul tetap kuat (Signorello et al., 2021). Pada saat yang sama, bukti lain menunjukkan bahwa operasi caesar dapat berdampak negatif pada fungsi seksual karena perkembangan morbiditas ibu dan komplikasi setelah operasi perut. Demikian pula, meskipun trauma pada dasar panggul tampaknya berkurang pada ibu yang melahirkan melalui operasi caesar sebelum dilatasi 8 cm, nyeri panggul kronis meningkat dibandingkan dengan ibu yang melahirkan secara normal (Jansson et al., 2020).

2. Menyusui dan Perubahan Hormon

Menyusui dapat memengaruhi seksualitas secara positif karena ukuran payudara yang lebih besar dan sensitivitas puting yang lebih tinggi yang dapat menyebabkan persepsi citra tubuh yang lebih baik, respons erotis yang lebih tinggi terhadap rangsangan payudara, dan hasrat yang lebih besar. Pada beberapa wanita, pelepasan oksitosin selama menyusui dapat menyebabkan gairah seksual dan karakterisasi menyusui sebagai pengalaman erotis (Yılmaz, 2019).

Namun, dampak negatif menyusui terhadap seksualitas tampaknya lebih relevan, seperti frekuensi aktivitas seksual yang lebih rendah, minat terhadap seks yang lebih rendah, kenikmatan yang berkurang, hasrat yang menurun, dan dispareunia (Banaei et al., 2019). Menyusui memiliki dampak negatif yang lebih besar terhadap frekuensi hubungan seksual daripada terhadap responsivitas dan orgasme [atau terhadap penundaan dimulainya kembali hubungan seksual setelah melahirkan (Ying et al., 2023). Kadar prolaktin yang tinggi mengurangi produksi androgen dan estrogen ovarium yang dapat menyebabkan berkurangnya pelumasan vagina dan hasrat yang menurun, dan karenanya minat untuk melakukan aktivitas seksual berkurang (Yılmaz, 2019). Bukan insiden menyusui yang tampaknya berdampak pada seksualitas, tetapi lebih pada durasinya. Wanita yang menyusui lebih lama melanjutkan aktivitas seksual di kemudian hari, kurang tertarik pada seks, dan mengalami lebih banyak rasa sakit

dan kenikmatan selama hubungan seksual. Bagaimanapun, dampak menyusui sangat berbeda bagi wanita yang menyusui secara eksklusif, dibandingkan dengan mereka yang menggabungkan pemberian ASI dengan susu botol (ASI dan/atau susu formula), dan mereka yang hanya memberikan susu botol. Perbedaan ini memengaruhi jumlah tidur dan kelelahan orang tua yang dapat memengaruhi keputusan untuk melakukan hubungan seksual atau tidak.

3. Gangguan Psikologis pada Ibu Postpartum

Hasil tinjauan menunjukkan bahwa depresi pascapersalinan memiliki pengaruh negatif pada minat, hasrat, dan kenikmatan seksual, serta pada frekuensi hubungan seksual (Khajehei et al., 2018). Gejala yang terkait dengan kesehatan mental seperti suasana hati yang tertekan dan ketidakstabilan emosi tampaknya memiliki pengaruh negatif baik selama kehamilan maupun pascapersalinan, seperti halnya kelembutan yang dirasakan pasangan. Wanita yang terkena depresi pada periode pascapersalinan cenderung tidak melanjutkan hubungan seksual pada enam bulan setelah melahirkan, dan mereka melakukan lebih sedikit aktivitas seksual dan melaporkan lebih banyak masalah seksual. Selain itu, pengobatan depresi mungkin tidak memperbaiki disfungsi seksual karena memburuknya hubungan pasangan. Selain itu, beberapa antidepresan dapat memiliki efek samping berupa dampak negatif pada hasrat, gairah, dan orgasme (Artieta-pinedo et al., 2025).

D. Masalah Seksual pada Ibu Postpartum

Periode postpartum merupakan fase pemulihan baik secara fisik maupun psikologis bagi ibu setelah melahirkan. Banyak ibu yang mengalami masalah seksual yang dapat memengaruhi kualitas hidup dan kualitas hubungan dengan pasangan. Masalah seksual yang sering dialami ibu postpartum antara lain : (McBride & Kwee, 2017).

1. Penurunan Libido

Penurunan hasrat seksual dapat dialami oleh ibu postpartum dalam bulan-bulan pertama setelah melahirkan. Kondisi ini disebabkan karena perubahan hormon dan kelelahan fisik yang dialami ibu. Turunnya kadar hormon estrogen dan progesteron menyebabkan ketidaknyaman fisik dan psikis ibu. Peran maternal baru yang harus ibu jalani membuat perhatian ibu tercurah kepada bayi dan mengurangi perhatian pada pasangan. Kesibukan baru dalam merawat bayi akan menyebabkan kelelahan fisik, ibu kurang tidur dan kegiatan menyusui membuat ibu merasa Lelah dan kurang berminat dalam berhubungan seksual. Penurunan libido ini disebabkan karena :

- a. Perubahan hormonal : setelah melahirkan, kadar hormone estrogen dan progesterone mengalami penurunan drastis yang menyebabkan perubahan fisiologis pada organ reproduksi perempuan Estrogen dan progesterone yang rendah akan menyebabkan berkurangnya sekresi lender pada organ reproduksi sehingga mengurangi lubrikasi saat berhubungan seksual. Kadar prolactin yang meningkat selama menyusui juga berkontribusi terhadap rendahnya hasrat seksual pada ibu postpartum (Botros et al, 2021).
- b. Faktor psikologis : Perubahan psikologis yang sering dialami oleh postpartum mulai dari perubahan mood (baby blues/postpartum blues), depresi dan kecemasan menyebabkan ketertarikan terhadap aktivitas seksual menurun (Khajehei et al., 2018).
- c. Kelelahan dan stress : Kurangnya waktu istirahat akibat merawat bayi dan menyusui dapat mengurangi energi dan minat terhadap aktivitas seksual (Ying et al., 2023).
- d. Perubahan citra tubuh : Perubahan fisik yang dialami ibu postpartum akan menyebabkan ibu tidak nyaman dan mempengaruhi citra tubuh yang menghambat aktivitas seksual (Artieta-pinedo et al., 2025).

2. Nyeri saat berhubungan seksual (dyspareunia)

Dispareunia postpartum merupakan salah satu keluhan seksual yang sering dialami oleh ibu paska melahirkan dalam beberapa bulan pertama setelah melahirkan.

Penyebab dyspareunia antara lain :

- a. Trauma perineum : Trauma persalinan bisa disebabkan karena Tindakan episiotomy atau rupture perineum pada persalinan pervaginam, atau persalinan dengan bantuan forceps maupun ekstraksi vakum. Trauma perineum ini dapat menjadi penyebab masalah seksual yang dialami pada ibu postpartum pada periode menengah (6 bulan pertama) maupun pada periode panjang (12 bulan postpartum)(Signorello et al., 2021).
- b. Vagina kering : Penurunan estrogen pada ibu postpartum terutama pada ibu menyusui akan menyebabkan penipisan mukosa vagina dan berkurangnya sekresi lendir vagina yang berfungsi sebagai pelumas atau lubrikan yang dapat meningkatkan keluhan nyeri saat berhubungan seksual (Opondo et al., 2023).
- c. Hipertonia otot dasar panggul : Hipertonia otot dasar panggul adalah kondisi dimana otot-otot dasar panggul mengalami ketegangan atau kontraksi yang berlebihan sehingga menyebabkan rasa nyeri termasuk nyeri pada saat berhubungan seksual. Pada ibu postpartum hipertonia ini dapat disebabkan karena ruptur perineum atau episiotomi dan perubahan hormonal yang menyebabkan penurunan elastisitas jaringan otot dasar panggul. Selain itu itu,

hypertonia otot dasar panggul dapat disebabkan karena tekanan yang berlebih pada saraf pudensal saat persalinan pervaginam (Ying et al., 2023).

3. Disfungsi orgasme

Beberapa ibu postpartum mengalami kesulitan dalam mencapai orgasme atau mengalami orgasme yang lebih lemah dibandingkan sebelum melahirkan. kondisi

- a. Kerusakan saraf panggul : persalinan per vaginam, terutama yang melibatkan penggunaan alat bantu seperti vakum atau forceps, dapat menyebabkan trauma pada saraf panggul yang menghambat respons seksual (McBride & Kwee, 2017).
- b. Penurunan sensitivitas klitoris : Perubahan aliran darah ke daerah genital akibat persalinan dapat mempengaruhi sensitivitas dan respons seksual (Lindberg et al., 2021).
- c. Gangguan psikologis : Stres, kecemasan, atau trauma persalinan dapat menghambat kemampuan ibu untuk menikmati aktivitas seksual dan mencapai orgasme (Khajehei et al., 2018).

4. Ketidakpuasan seksual

Ketidakpuasan seksual adalah masalah yang sering terjadi setelah melahirkan, yang dapat memengaruhi kehidupan seksual wanita, hubungan pasangan, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Perubahan fisik, emosional, dan hormonal yang dialami wanita setelah melahirkan dapat menyebabkan ketidakpuasan seksual. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi ketidakpuasan seksual pada ibu postpartum antara lain (Nazanin et al., 2017; Review & Moghadam, 2024; Yılmaz, 2019) :

a. Perubahan hormon

Setelah melahirkan, perempuan mengalami perubahan besar dalam kadar hormon, termasuk peningkatan prolaktin yang mendukung produksi ASI. Tingginya kadar prolaktin dapat menekan libido dan mengurangi gairah seksual. Selain itu, rendahnya kadar estrogen setelah persalinan dapat menyebabkan kekeringan vagina, yang membuat hubungan seksual menjadi tidak nyaman atau menyakitkan

b. Kelelahan dan stress

Kelelahan fisik dan emosi yang disebabkan karena peran maternal (merawat bayi dan menyusui) akan memengaruhi dorongan seksual pada ibu. Kebutuhan tidur yang tidak tercukupi, perasaan cemas tentang perawatan bayi dan bertambahnya peran dan tugas sebagai ibu dapat menurunkan keinginan seksual dan menyebabkan ketidakpuasan seksual.

c. Perubahan fisik paska persalinan

Ibu postpartum mengalami perubahan fisik seperti penurunan elastisitas otot dasar panggul, rasa sakit atau ketidaknyamanan akibat episiotomi atau robekan perineum, serta penurunan bentuk tubuh yang dapat mempengaruhi citra tubuh mereka dan menyebabkan ketidaknyamanan saat berhubungan seksual.

d. Gangguan citra tubuh

Banyak ibu postpartum merasa cemas atau tidak puas dengan tubuh mereka setelah melahirkan. Perubahan bentuk tubuh dan peningkatan berat badan setelah melahirkan dapat mengurangi rasa percaya diri, yang berdampak pada keinginan seksual mereka dan ketidakpuasan seksual.

E. Pengkajian Fungsi Seksual pada Ibu Postpartum

1. *Sexual Activity Questionnaire (SAQ)*

Aktivitas seksual merupakan dimensi penting dari kualitas hidup. Oleh karena itu, penting untuk menilai dampak yang mungkin ditimbulkan oleh pengobatan atau perubahan fisik yang disebabkan karena kehamilan, persalinan dan postpartum terhadap fungsi seksual sehingga ibu dapat diperingatkan tentang kemungkinan efek samping dan intervensi yang ditawarkan untuk membantu memperbaiki efek samping tersebut. Kuesioner Aktivitas Seksual (SAQ) merupakan instrument untuk menilai fungsi seksual yang dapat dijelaskan oleh tiga faktor: kenikmatan dari hubungan seksual, ketidaknyamanan selama hubungan seksual, dan kebiasaan. SAQ merupakan ukuran yang valid, andal, dan dapat diterima untuk menggambarkan fungsi seksual wanita dalam hal aktivitas, kenikmatan, dan ketidaknyamanan. Kuesioner ini cepat dan mudah diberikan serta memiliki validitas yang baik dalam membedakan antara fungsi seksual pada perempuan pra- dan pasca-menopause (tools terlampir).

2. *Female Sexual Function Index (FSFI)*

Female Sexual Function Index (FSFI) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai fungsi seksual wanita. FSFI dirancang untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai aspek dari fungsi seksual wanita, baik yang berkaitan dengan masalah fisik, emosional, maupun psikologis. Alat ukur ini dikembangkan oleh (Rosen et al., 2000) dan telah menjadi salah satu instrumen standar untuk penelitian dan klinis dalam bidang kesehatan seksual perempuan.

FSFI terdiri dari 19 item yang dibagi menjadi 6 domain utama, yaitu (tools terlampir) :

- a. *Desire* (Keinginan Seksual) : Menilai tingkat keinginan atau dorongan seksual wanita dalam periode tertentu.

- b. *Arousal* (Kegairahan Seksual) : Mengukur tingkat gairah atau respons tubuh terhadap rangsangan seksual, seperti kekasaran dan kelembapan.
- c. *Lubrication* (Pelumasan) : Menilai kemampuan tubuh wanita untuk menghasilkan pelumasan alami selama aktivitas seksual.
- d. *Orgasm* (Orgasme) : Menilai frekuensi dan kepuasan wanita dalam mencapai orgasme selama hubungan seksual.
- e. *Satisfaction* (Kepuasan Seksual) : Menilai tingkat kepuasan wanita terhadap pengalaman seksual mereka, baik dalam hal hubungan seksual maupun hubungan emosional dengan pasangan.
- f. *Pain* (Nyeri) : Mengukur sejauh mana wanita mengalami rasa sakit atau ketidaknyamanan selama hubungan seksual.

3. *Sexual Function Questionnaire (SFQ28)*

Sexual Function Questionnaire (SFQ28) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai fungsi seksual pada perempuan dan pria. SFQ28 terdiri dari 28 item pernyataan yang dirancang untuk mengevaluasi berbagai aspek kehidupan seksual seperti Hasrat, kepuasan, keinginan seksual dan disfungsi seksual. Alat ukur ini sering digunakan dalam penelitian dan pengaturan klinis untuk menilai masalah seksual dan mendalami faktor-faktor yang memengaruhi kehidupan seksual seseorang. SFQ28 mengukur aspek fungsi seksual secara komprehensif dan multidimensial. Berdasarkan respon individu terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada, SFQ28 dapat memberikan informasi tentang kualitas dan pengalaman seksual dalam periode tertentu (biasanya dalam 4 minggu atau 3 bulan terakhir) (Quirk et al., 2002).

Komponen SFQ28 antara lain :

- a. *Desire* (keinginan seksual) : mengukur dorongan atau Hasrat seksual seseorang yang mencerminkan seberapa sering seseorang merasa tertarik untuk berhubungan seksual.
- b. *Arousal* (gairah seksual) : Menilai bagaimana tubuh merespon rangsang seksual termasuk tingkat gairah yang dicapai sebelum dan selama hubungan seksual.
- c. *Lubrication* (pelumasan) : Menilai kemampuan tubuh untuk menghasilkan pelumasan alami yang diperlukan untuk kenyamanan dan kepuasan seksual.
- d. *Orgasme* : Menilai frekuensi dan intensitas orgasme, serta kepuasan terkait pengalaman seksual tersebut.
- e. *Satisfaction* (kepuasan seksual) : Menilai tingkat kepuasan seseorang terhadap pengalaman seksual yang mereka alami.
- f. *Pain* (nyeri seksual) : menilai tingkat nyeri atau frekuensi ketidaknyamanan atau rasa sakit yang dialami selama melakukan hubungan seksual.

- g. Functionality (fungsi seksual) : Menilai fungsionalitas seksual seperti kemampuan menikmati aktivitas seksual dan kualitas hubungan seksual.

F. Cara Mengatasi Masalah Seksual pada Ibu Postpartum

Mengatasi masalah seksual pada ibu postpartum memerlukan pendekatan yang holistik, yang mencakup pendekatan fisik, psikologis, dan emosional. Beberapa masalah seksual yang sering dialami oleh ibu postpartum seperti penurunan hasrat seksual, nyeri saat berhubungan seksual, dan masalah dengan orgasme sebagian besar disebabkan oleh perubahan hormon, kelelahan, stres, dan masalah citra tubuh setelah melahirkan.

Langkah mengatasi masalah seksual pada ibu postpartum antara lain :

1. Pendidikan seksual dan peningkatan komunikasi dengan pasangan : Pendidikan seksual yang diperlukan adalah tentang perubahan fisik dan psikis yang dialami oleh ibu postpartum, seperti perubahan hormonal, pengeluaran laktasi dan menyusui yang memengaruhi aktivitas seksual. Komunikasi terbuka dengan pasangan mengenai kebutuhan dan Batasan aktivitas seksual setelah melahirkan diperlukan untuk meningkatkan kualitas hubungan dan kualitas hubungan seksual (Khajehei et al., 2018).
2. Edukasi penggunaan lubrikan/pelumas :Penggunaan pelumas diperlukan untuk mengatasi rasa nyeri saat berhubungan seksual yang sering dialami oleh ibu postpartum yang disebabkan karena sekresi vagina yang kering. Pelumas berbasis air dapat digunakan untuk membantu mengatasi masalah kekeringan vagina yang disebabkan karena tingginya kadar hormone prolactin selama menyusui
3. Terapi fisik dan Latihan Otot Dasar Panggul : Latihan otot dasar panggul (Kegel Exercise) dapat membantu mengatasi masalah seperti inkontinensia urine dan meningkatkan kepuasan seksual dengan memperkuat otot-otot yang terlibat dalam respons seksual (Hadizadeh-Talasaz et al., 2019).
4. Konseling dan pendekatan psikologis (Cognitive Behavior Therapy) : Gangguan psikologis pada ibu postpartum atau kecemasan dapat berpengaruh besar pada kesehatan seksual ibu. Penyuluhan dan konseling psikologis dapat membantu ibu mengatasi perasaan cemas, depresi, atau stres yang dapat memengaruhi kehidupan seksual mereka. Terapi perilaku kognitif (CBT) juga dapat membantu mengatasi kecemasan dan perasaan negatif terhadap tubuh setelah melahirkan (Nezamnia et al., 2020; Zamani et al., 2019).

G. Simpulan

Kesehatan seksual pada ibu postpartum dipengaruhi oleh perubahan fisik, psikis dan hormonal setelah melahirkan. Peningkatan prolaktin dan penurunan estrogen dapat menyebabkan kekeringan vagina, nyeri saat berhubungan seksual, dan penurunan libido. Selain itu, kelelahan fisik, stres, dan masalah tubuh dapat memperburuk ketidakpuasan seksual. Untuk mengatasinya, dibutuhkan pendekatan yang holistik meliputi edukasi seksual, komunikasi dengan pasangan, penggunaan pelumas, dukungan psikologis, dan latihan otot dasar panggul. Pengelolaan hormon dan terapi medis juga penting untuk mengatasi masalah fisik. Pendekatan yang holistik dan berbasis bukti dapat membantu ibu postpartum mengatasi hambatan seksual dan meningkatkan kualitas hidup dan kualitas hubungan seksual ibu.

H. Referensi

- Artieta-pinedo, I., Paz-pascual, C., Garcia-alvarez, A., & Bully, P. (2025). Resumption of sexual activity after childbirth and its related factors in Spanish women , a cross-sectional study ☆. *Midwifery*, 141(September 2024), 104259. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2024.104259>
- Baattaiah, B. A., Alharbi, M. D., Babteen, N. M., Maqbool, H. M. Al, Babgi, F. A., & Albatati, A. A. (2023). The relationship between fatigue , sleep quality , resilience , and the risk of postpartum depression : an emphasis on maternal mental health. *BMC Psychology*, 1–17. <https://doi.org/10.1186/s40359-023-01043-3>
- Banaei, M., Azizi, M., Moridi, A., Dashti, S., Yabandeh, A. P., & Roozbeh, N. (2019). *Sexual dysfunction and related factors in pregnancy and postpartum : a systematic review and meta-analysis protocol*. 1–5.
- Basnet, S., Frongillo, E. A., Nguyen, P. H., Moore, S., & Arabi, M. (2020). Associations of maternal resources with care behaviours differ by resource and behaviour. *Maternal and Child Nutrition*, 16(3). <https://doi.org/10.1111/mcn.12977>
- Bland, K. I. (2012). Anatomy of the breast. *Fischer's Mastery of Surgery: Sixth Edition*, 1. <https://doi.org/10.1016/B978-1-4377-0788-5.10002-1>
- Grussu, P., Vicini, B., & Quatraro, R. M. (2021). Sexuality in the perinatal period: A systematic review of reviews and recommendations for Practice. *Sexual & Reproductive Healthcare*, 100668. <https://doi.org/10.1016/j.srhc.2021.100668>
- Hadizadeh-Talasaz, Z., Sadeghi, R., & Khadivzadeh, T. (2019). Effect of pelvic floor muscle training on postpartum sexual function and quality of life: A systematic review and meta-analysis of clinical trials. *Taiwanese Journal of Obstetrics and Gynecology*, 58(6), 737–747.

<https://doi.org/10.1016/j.tjog.2019.09.003>

- Jahangiry, L., Aliyari, Z., & Ponnet, K. (2021). A study on the knowledge, attitudes, and behaviors of pregnant women regarding hiv and routine rapid testing: An assessment in a high-risk marginal area. *Healthcare (Switzerland)*, 9(7). <https://doi.org/10.3390/healthcare9070793>
- Jansson, M. H., Franzén, K., Hiyoshi, A., Tegerstedt, G., Dahlgren, H., & Nilsson, K. (2020). *Risk factors for perineal and vaginal tears in primiparous women – the prospective POPRACT-cohort study*. 0, 1–14.
- Khajehei, M., Health, N., Hospital, W., & Doherty, M. (2018). *Exploring postnatal depression, sexual dysfunction and relationship dissatisfaction in Australian women. March*. <https://doi.org/10.12968/bjom.2017.25.3.162>
- Lara-Cinisomo, S., McKenney, K., Di Florio, A., & Meltzer-Brody, S. (2017). Associations between Postpartum Depression, Breastfeeding, and Oxytocin Levels in Latina Mothers. *Breastfeeding Medicine*, 12(7), 436–442. <https://doi.org/10.1089/bfm.2016.0213>
- Malley, D. O., Higgins, A., & Smith, V. (2023). *Sexuality of the Couple in Postpartum and Early Parenthood (1st Year)*.
- McBride, H. L., & Kwee, J. L. (2017). Sex After Baby: Women's Sexual Function in the Postpartum Period. *Current Sexual Health Reports*, 9(3), 142–149. <https://doi.org/10.1007/s11930-017-0116-3>
- Naigino, R., & Makumbi, F. (2021). *Resumption of Sexual Intercourse Among Postnatal Women Enrolled on Lifelong Antiretroviral Therapy in Uganda*. 1–25.
- Nazanin, R., Arman, A., & Kourosh, S. (2017). *Postpartum Sexual Functioning and Its Predicting Factors among Iranian Women*.
- Nezamnia, M., Iravani, M., Bargard, M. S., & Latify, M. (2020). Effectiveness of cognitive-behavioral therapy on sexual function and sexual self-efficacy in pregnant women: An rct. *International Journal of Reproductive BioMedicine*, 18(8), 625–636. <https://doi.org/10.18502/ijrm.v13i8.7504>
- Opondo, C., Harrison, S., Sanders, J., Quigley, M. A., & Alderdice, F. (2023). The relationship between perineal trauma and postpartum psychological outcomes: a secondary analysis of a population - based survey. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 6, 1–10. <https://doi.org/10.1186/s12884-023-05950-6>
- Quirk, F. H., Heiman, J. R., Rosen, R. C., Laan, E., Smith, M. D., & Boolell, M. (2002). Development of a sexual function questionnaire for clinical trials of female sexual dysfunction. *Journal of Women's Health and Gender-Based Medicine*, 11(3), 277–289. <https://doi.org/10.1089/152460902753668475>
- Review, S., & Moghadam, Z. B. (2024). *Women's sexual function during the*

postpartum period. June, 1–8.

- Rosen, R., Brown, C., Heiman, J., Leiblum, S., Meston, C., Shabsigh, R., Ferguson, D., & D'Agostino, R. (2000). The female sexual function index (Fsf): A multidimensional self-report instrument for the assessment of female sexual function. *Journal of Sex and Marital Therapy, 26*(2), 191–205. <https://doi.org/10.1080/009262300278597>
- Signorello, L. B., Harlow, B. L., Chekos, A. K., & Repke, J. T. (2021). *Postpartum sexual functioning and its relationship to perineal trauma: A retrospective cohort study of primiparous women.* 881–890. <https://doi.org/10.1067/mob.2001.113855>
- WHO. (2022). *WHO recommendations on maternal and newborn care for a positive postnatal experience.*
- Ying, Y., Id, N., Muhamad, R., & Ahmad, I. (2023). *Sexual dysfunction among six months postpartum women in north-eastern Malaysia.* 1–13. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0284014>
- Yilmaz, F. A. (2019). *Breastfeeding and Sexual Activity and Sexual Quality.* XX(Xx), 1–5. <https://doi.org/10.1089/bfm.2018.0249>
- Zamani, M., Sc, M., Roudsari, R. L., Ph, D., & Moradi, M. (2019). *The effect of sexual health counseling on women ' s sexual satisfaction in postpartum period: A randomized clinical trial.* 17(1), 41–50. <https://doi.org/10.18502/ijrm.v17i1.3819>

I. Glosarium

CBT = Cognitive Behavior Therapy
FSFI = Female Sexual Function Index
SAQ= Sexual Activity Questionnaire

CHAPTER 3

PERAWATAN PASCA OPERASI CAESAR: PEMULIHAN DAN TANTANGAN

Santi Wahyuni, S.Kp., M.Kep., Sp.Mat.

A. Pendahuluan

Sectio caesarea atau operasi caesar, merupakan prosedur atau tindakan pembedahan yang umum dilakukan dalam bidang obstetri untuk mengakhiri kehamilan melalui insisi pada dinding abdomen (laparotomi) dan dinding uterus (histerektomi). Tujuan utama dari tindakan sectio caesarea adalah untuk menyelamatkan nyawa ibu dan bayi ketika terjadi komplikasi kehamilan dan persalinan. Tindakan ini dilakukan apabila kelahiran per vaginam menyebabkan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan ibu dan janin (Prawirohardjo 2014).

Berdasarkan indikasi medis dilakukannya tindakan sectio caesarea dapat dibedakan indikasi yang berasal dari ibu, janin, ataupun keduanya. Sedangkan berdasarkan jenis operasi caesar dibedakan menjadi dua, yaitu operasi caesar elektif dan operasi caesar darurat (cito). Pada sectio caesarea yang elektif, tindakan operasi telah direncanakan sebelumnya, umumnya karena kondisi medis telah diketahui sebelum persalinan, sedangkan pada sectio caesarea darurat dilakukan secara mendadak karena adanya komplikasi selama persalinan. Indikasi dilakukannya sectio caesarea secara elektif dibedakan menjadi indikasi absolut dan relatif (Mylonas and Friese 2015). Indikasi absolut seperti pelvis yang kecil (panggul sempit) sehingga tidak memungkinkan persalinan pervaginam, *chorioamnionitis* yang merupakan infeksi pada plasenta yang memerlukan penanganan segera, eklamsia dan plasenta previa. Sedangkan indikasi relatif seperti persalinan lama dan telah menjalani sectio caesareasebelumnya yang tidak memungkinkan dilakukan persalinan spontan atau pervaginam.

Beberapa indikasi obstetri dari tindakan sectio caesarea dibedakan menjadi 4 (empat) kategori. Kategori 1, kondisi ancaman langsung bagi kelangsungan hidup ibu dan janin, contohnya seperti : *fetal distress* menetap, *prolaps* tali pusat atau tali pusat menumbung, gagal *vacum* atau *forcep*, *rupture uteri imminent* (RUI), *haemoragia antepartum* (HAP) dengan *syok hipovolemik*, *solusio plasenta*, *Vaginal Birth After Caesarean Section* (VBAC). Kategori 2, kondisi dengan komplikasi yang terjadi bukan merupakan ancaman secara langsung bagi kehidupan ibu dan janin, namun jika penanganan tidak adekuat akan menimbulkan morbiditas bahkan

mortalitas. Contoh indikasi kategori 2 seperti: *antepartum haemorrhagia (APH)*, *obstructed labor* (tidak terjadi kemajuan persalinan), letak lintang kasep. Kategori 3 dan 4 kondisi tanpa ancaman bagi ibu dan janin sehingga dapat dilakukan perencanaan yang memperhatikan kebutuhan ibu, janin dan keluarga serta kemampuan fasilitas pelayanan beserta ketersediaan tenaga kesehatan (PP POGI 2022).

Sectio caesarea berencana (elektif) dengan indikasi kelainan letak janin, kehamilan multipel (kehamilan gemeli dan kehamilan triplet), plasenta previa, plasenta akreta, persalinan pada ibu dengan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV positif), dan infeksi lain (hepatitis dan virus herpes simpleks), kehamilan preterm, kelahiran pada bekas sectio caesarea, Bayi Kecil Masa Kehamilan (KMK), kehamilan dengan tumor ginekologi (kanker serviks, mioma uteri), sectio caesarea postmortem, *Cephalopelvic Disproportion* (CPD), obesitas, dan operasi caesar atas permintaan pasien (PP POGI 2022).

Komplikasi selama proses persalinan dapat menjadi indikasi untuk dilakukannya tindakan sectio caesarea, meliputi : 1) persalinan yang lama, yaitu persalinan yang berlangsung terlalu lama dan tidak ada kemajuan, 2) ketuban pecah dini, yaitu ketuban pecah sebelum persalinan dimulai, 3) lilitan tali pusat, yaitu suatu keadaan bayi terlilit oleh tali pusatnya sehingga membahayakan janin akibat kekurangan oksigen, 4) prolaps tali pusat, yaitu keadaan tali pusat yang menumbung) (Sungkar and Basrowi 2020).

Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia mengalami peningkatan, pada tahun 2022 sebanyak 3.572 menjadi 4.482 di tahun 2023 (Kementerian Kesehatan RI 2024). Penyebab kematian ibu terbanyak pada tahun 2023 adalah Hipertensi Dalam Kehamilan (HDK) sebanyak 412 kasus, perdarahan obstetrik sebanyak 360 kasus, dan komplikasi obstetrik lain sebanyak 204 kasus (Kementerian Kesehatan RI 2024). Berbagai upaya telah dilakukan untuk mempercepat penurunan AKI diantaranya dengan memberikan jaminan agar setiap ibu mampu mengakses pelayanan kesehatan ibu hamil yang berkualitas, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas pelayanan kesehatan, perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi, perawatan khusus dan rujukan jika terjadi komplikasi, dan pelayanan keluarga berencana (KB). Apabila ibu mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan, maka dapat dilakukan tindakan pembedahan sectio caesarea sehingga dapat mencegah bertambahnya AKI.

World Health Organization (WHO) telah merekomendasikan tingkat operasi caesar untuk nasional hanya sekitar 10-15% dari jumlah kelahiran (WHO, 2015). Rekomendasi tersebut didasarkan pada analisis risiko yang dapat terjadi akibat sectio caesarea bagi ibu maupun bayi. Akan tetapi, kenyataannya pada sebagian

besar negara di dunia memiliki tingkat sectio caesarea yang lebih tinggi dari tingkat yang direkomendasikan WHO. Terlepas dari batasan tersebut, sectio caesarea harus dilakukan berdasarkan indikasi medis, dan hal ini dipastikan oleh penyelenggara atau pemberi pelayanan kesehatan yang merawat ibu berdasarkan kasus per kasus (Betran et al. 2016). WHO telah merekomendasikan beberapa tindakan non-klinis yang dapat mengurangi atau membatasi terhadap penggunaan operasi caesar yang tidak diperlukan secara medis (Sungkar and Basrowi 2020).

Insiden kasus sectio caesarea di seluruh dunia telah meningkat dari sekitar 7% pada tahun 1990 menjadi 21% saat ini, dan diproyeksikan akan terus meningkat selama dekade ini. Jika trend ini terus berlanjut, pada tahun 2030 angka tertinggi kemungkinan akan terjadi di Asia Timur (63%), Amerika Latin dan Karibia (54%), Asia Barat (50%), Afrika Utara (48%), Eropa Selatan (47%), serta Australia dan Selandia Baru (45%) (Sungkar and Basrowi 2020).

Di Indonesia, trendnya serupa diungkapkan melalui data hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 yang mencatat sekitar 17,6% dari seluruh kelahiran bayi dilahirkan melalui operasi caesar, lebih tinggi dari angka yang direkomendasikan WHO pada tingkat populasi. Insiden kasus sectio caesarea di Indonesia berdasarkan data proporsi metode persalinan pada perempuan umur 10-54 tahun menurut provinsi, digambarkan sebagai hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 menunjukkan bahwa metode persalinan sectio caesarea di Indonesia mencapai 25,9%, sedangkan persalinan normal pervaginam sebesar 73,2%, dan lainnya (vacum dan forcep) sekitar 1,0%. Tiga propinsi dengan kasus sectio caesarea tertinggi adalah Bali (53,2%), Daerah Khusus Indonesia (DKI) Jakarta (40,8%) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (38,1%) (Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, 2023).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, bab ini akan membahas secara mendalam mengenai proses pemulihan pasca sectio caesarea dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif bagi para pembaca, baik tenaga kesehatan (perawat), mahasiswa keperawatan, maupun ibu-ibu yang baru saja menjalani operasi caesar. Diskusi akan mencakup aspek fisik, psikologis, dan nutrisi yang krusial dalam mendukung pemulihan optimal. Selain itu, bab ini juga akan mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh ibu pasca operasi caesar, serta solusi atau strategi pengelolaan yang efektif. Melalui pemahaman yang mendalam mengenai proses pemulihan pasca sectio caesarea, diharapkan ibu dapat menjalani masa nifas dengan lebih nyaman dan percaya diri. Dengan demikian, ibu dapat fokus pada perawatan bayi dan membangun ikatan yang kuat dengan anak.

B. Perawatan Pasca Sectio Caesarea dengan Metode ERAS

Konsep *Enhanced Recovery After Surgery* (ERAS) pertama kali diperkenalkan pada tahun 1997 oleh Henrik Kehlet, seorang ahli bedah asal Denmark (Greenshields and Mythen 2020). Konsep ERAS bertujuan untuk mempercepat pemulihan pasien setelah operasi dengan cara memberikan perawatan terbaik sebelum, selama, dan setelah operasi. ERAS merupakan pendekatan yang berbasis bukti ilmiah untuk mengoptimalkan proses pemulihan pasca operasi dengan cara meminimalkan stres pada tubuh pasien. Komunitas dan kelompok penelitian ERAS telah menerbitkan berbagai pedoman berbagai spesialisasi bedah termasuk thoraks, kardiovaskular, digestif, ginekologi, dan urologi. Semua pedoman tersebut ditujukan untuk memastikan bahwa pasien mendapatkan perawatan terbaik sesuai dengan jenis operasinya (Kesty and Bernolian 2022).

ERAS merupakan pendekatan komprehensif, interdisipliner, dan berbasis protokol dalam perawatan pasien bedah, yang dimulai dari kunjungan sebelum operasi hingga periode pasca operasi yang bertujuan untuk mempersingkat waktu penyembuhan pasien. Pada berbagai bidang, ERAS telah terbukti dapat meningkatkan kualitas perawatan, mengurangi biaya perawatan, serta meningkatkan kepuasan pasien (Habib and Ituk 2018); (Greenshields and Mythen 2020).

Pedoman *Enhanced Recovery After Surgery* (ERAS) pada operasi caesar atau dikenal dengan pedoman *Enhanced Recovery After Caesarean Section* (ERACS) terbit pada tahun 2018, telah memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kualitas pemulihan ibu post operasi caesar. Berdasarkan bukti ilmiah yang kuat, metode ERACS terbukti efektif dalam mempercepat proses penyembuhan dan mengurangi risiko komplikasi pasca operasi (Habib and Ituk 2018). Tujuan pedoman ERACS untuk mempercepat pemulihan ibu setelah melahirkan, sehingga waktu perawatan di rumah sakit dapat lebih pendek. ERACS mengutamakan proses perawatan yang terdiri dari berbagai intervensi untuk mengurangi stres pembedahan, mempertahankan fungsi fisiologis, dan mempercepat proses penyembuhan pasien (Astilia 2024).

Metode ERACS terdiri dari optimalisasi pelayanan antepartum, pelayanan intrapartum termasuk manajemen anestesi dan pelayanan postpartum pasien rawat inap dan rawat jalan sehingga tercipta pedoman yang terstandarisasi. Prinsip *enhanced recovery* meliputi seluruh perawatan dan intervensi selama fase pra, intra, dan pasca operasi. Namun, berbeda dengan pasien bedah pada umumnya, tindakan operasi pada pasien obstetri seringkali tidak direncanakan. Selain pemulihan pasca

operasi, pasien juga akan menghadapi tantangan baru sebagai seorang ibu sehingga dibutuhkan perawatan pasca operasi yang lebih baik.

Berdasarkan periode waktunya, komponen protokol ERAS pada persalinan *sectio caesarea* meliputi :

1. Periode pra operasi :

- a. Pemberian edukasi pada pasien
- b. *Informed consent* dan penjelasan pada pasien dan keluarga untuk persalinan *section caesarea*
- c. Optimalisasi hemoglobin
- d. Waktu pembatasan cairan
- e. Waktu pembatasan makanan (puasa 6-8 jam sebelum operasi)
- f. Antibiotik profilaksis 30-60 menit sebelum operasi

2. Periode intra operasi :

- a. Pemberian obat-obatan anestesia, analgetik dan antiemetik yang adekuat
- b. Insisi transversal / mediana
- c. Mengeluarkan bayi
- d. Penundaan waktu *clamp* tali pusat (*delayed cord clamping*)
- e. Menjahit luka operasi dengan tidak mengeluarkan uterus dari kavum abdomen
- f. Penutupan luka (*sub-cuticular wound closure*)
- g. Tidak memberikan misoprostol oral/rektal pada pasien untuk menghindari efek menggigil
- h. Tetap memberikan oksitosin sesuai dosis tetapi tidak boleh memberikan cairan > 3 liter
- i. Mempertahankan suhu kamar operasi antara 23-25 derajat C
- j. *Immediate skin to skin contact*, termasuk Insiasi Menyusu Dini (IMD)

3. Periode post operasi :

- a. Menghindari pasien dan bayi dari risiko hipotermi
- b. Pemberian cairan dan makanan pada masa pemulihan (*early oral intake*)
- c. Perawatan kandung kemih (*bladder care plan*), pelepasan kateter 2 jam pasca operasi
- d. Pelepasan infus intravena 12 jam pasca operasi
- e. Pemeriksaan darah dilakukan 12 jam pasca operasi
- f. Pemberian analgesik (*regular analgesia*)
- g. Mobilisasi dini (*early mobilisation*)
- h. Pemberian edukasi menyusui (*breastfeeding education*)
- i. Konseling kontrasepsi
- j. Skrining dan edukasi mengenai postpartum depression

(Adshead, Wrench, and Woolnough 2016) ; (Habib and Ituk 2018) ; (Kesty and Bernolian 2022).

Rekomendasi ERACS pada periode pra operasi berupa pemberian edukasi pra-operasi merupakan hal yang sangat penting bagi pasien yang akan menjalani operasi Caesar. Informasi yang diberikan meliputi teknik operasi, tujuan operasi, dan rencana perawatan pasca operasi, meliputi: upaya perawatan nyeri, asupan makanan, aktivitas fisik (mobilisasi dini), cara pemberian ASI, dan lama perawatan di rumah sakit (Adshead, Wrench, and Woolnough, 2016). Hal ini bertujuan agar pasien merasa lebih siap dan tenang menghadapi operasi.

Rekomendasi ERACS pada periode intra operasi, dilakukan pemberian antibiotik profilaksis yang bertujuan untuk mengurangi insidensi infeksi postpartum; pemberian cairan kristaloid untuk *maintenance* untuk mengurangi risiko hipotensi; pemberian vasopressor dapat dipertimbangkan sebagai penatalaksanaan hipotensi yang dipicu oleh anestesi, serta untuk mengurangi kejadian mual dan muntah (Adshead, Wrench, and Woolnough, 2016). Selain itu juga, pemberian anestesi multimodal menggunakan opioid lipofilik dengan onset cepat (*short acting*) untuk efek anestesi neuraxial, seperti fentanil atau sufentanil. Sedangkan opioid hidrofilik dengan durasi panjang seperti morfin, diberikan pasca operasi sebagai analgesik.

Rekomendasi ERACS untuk tindakan pada neonatus adalah *skin to skin contact* yang dilakukan secepat mungkin untuk meningkatkan keberhasilan rasio dan durasi menyusui serta pelaksanaan inisiasi menyusui dini (IMD) ; penundaan waktu penjepitan (*clamp*) tali pusat selama 1–3 menit untuk mengurangi risiko perdarahan intraventrikular, meningkatkan hematokrit, dan menurunkan risiko resusitasi bayi baru lahir serta mencegah anemia defisiensi besi pada tahun pertama kehidupan anak.



Gambar 3.1 *Early Skin to skin contact*
(<https://www.freepik.com> 2024)

Lebih difokuskan pada bahasan ini adalah prosedur ERAS setelah tindakan operasi caesar yang meliputi :

1. Pemberian asupan secara dini, analgesik, dan antiemetik

Secara tradisional, pemberian makanan per oral setelah operasi ditunda hingga fungsi usus kembali normal, yang sering ditandai dengan keluarnya flatus. Namun, bukti ilmiah menunjukkan bahwa memulai asupan oral lebih dini dapat mempercepat pemulihan fungsi usus, mempercepat proses ambulasi, menurunkan risiko infeksi atau sepsis, dan mengurangi waktu rawat inap (Habib and Ituk 2018) ; (Macones et al. 2019).

2. Pelepasan kateter uretra dini

Berdasarkan protokol ERAS, pelepasan kateter uretra dapat dilepas <24 jam. Informasi atau data penelitian mengenai waktu yang tepat untuk melepaskan kateter urin pada ibu pasca sectio caesarea dengan anestesi spinal masih terbatas. Temuan dari peninjauan atau pemeriksaan terhadap protokol ERAS memberikan bukti empiris bahwa pengangkatan (up) kateter urin 7 jam setelah prosedur aman dan efektif dalam mendukung pemulihan pasca operasi, terutama dalam hal mobilisasi dini (Habib and Ituk 2018).

3. Mobilisasi dini

Mobilisasi dini dapat meningkatkan fungsi dan oksigenasi jaringan, memperbaiki resistensi insulin, mengurangi risiko tromboemboli, dan mempersingkat waktu rawat inap. Efektivitas pemberian obat analgesik pasca operasi menjadi faktor kunci untuk memfasilitasi mobilisasi dini (Habib and Ituk 2018).



Gambar 3.2 Latihan mobilisasi pada ibu pasca sectio caesarea
(<https://www.freepik.com> 2024)

4. Pemulangan pasien yang tidak terlalu lama

Sebelum pasien dipulangkan, harus dipastikan pasien memiliki akses ke tenaga kesehatan yang mudah. Pasien harus dapat menghubungi tenaga kesehatan sesegera mungkin jika terdapat masalah (Caughey et al. 2018).

C. Pemulihan Pasca Sectio Caesarea

Masa nifas, khususnya setelah menjalani tindakan operasi caesar, merupakan periode yang penuh tantangan bagi para ibu dan keluarga. Masa nifas juga merupakan periode yang kritis bagi kesehatan ibu. Mengingat tingginya AKI pada periode ini, perawatan pasca persalinan memerlukan perhatian khusus. Pemantauan rutin yang dilakukan pasca sectio caesarea untuk memastikan kondisi jalan napas dan kardiorespirasi stabil. Setelah pemulihan dari anastesi, pemantauan umum tanda-tanda vital, keadaan nyeri, sedasi, pemantauan kontraksi uterus, tinggi fundus uteri (TFU) dan perdarahan pervaginam (PP POGI 2022).



Gambar 3.3 Pemantauan ibu pasca sectio caesarea
(<https://www.freepik.com> 2024)

Proses pemulihan pasca operasi menuntut ibu untuk meluangkan waktu yang mencukupi agar tubuh untuk beradaptasi dengan perubahan fisiologis yang terjadi. Pembatasan aktivitas fisik dan dukungan lingkungan yang suportif akan sangat membantu untuk mempercepat proses penyembuhan. Pemberian dukungan sosial kepada ibu nifas, dapat bersumber dari keluarga inti, kerabat, teman hingga tenaga profesional yang berpengalaman. Dukungan sosial adalah bantuan yang mengacu pada kenyamanan, perhatian, penghargaan yang diterima seseorang dari orang lain, berupa dukungan emosional dan penghargaan, dukungan instrumental, dukungan informasi dan dukungan persahabatan (Sarafino and Smith 2011). Adanya dukungan sosial dapat membuat ibu merasa lebih dicintai dan dihargai, sehingga termotivasi untuk menjaga kesehatan diri dan bayi. Rasa percaya diri dan ketenangan yang muncul dari dukungan ini juga dapat membantu mereka mengatasi stres pasca

persalinan, meningkatkan kualitas ikatan batin dengan bayi, dan memaksimalkan potensi tumbuh kembang anak.



Gambar 3.4 Pemberian dukungan pada ibu pasca sectio caesarea
(<https://www.freepik.com> 2024)

Tindakan pembedahan termasuk sectio caesarea, memiliki potensi komplikasi pasca operasi yang dapat meningkatkan risiko kematian jika tidak ditangani dengan tepat. Komplikasi ini dapat berupa gangguan fisik yang ringan hingga berat. Komplikasi yang ringan pada pasca pembedahan dapat berupa mual, muntah, nyeri dan nyeri kepala. Komplikasi yang berat dapat mempengaruhi sistem sirkulasi tubuh berupa hipovolemi, hipotensi, hipertensi, gagal jantung hingga henti jantung. Selain itu, aspek psikologis juga perlu diperhatikan, karena ibu dapat mengalami gangguan tidur, mimpi buruk, bahkan gangguan mental seperti depresi.

Early Recovery After Surgery atau *ERAS Guideline* adalah satu acuan yang ditujukan bagi tim medis yang terdiri dari dokter bedah, anestesi, perawat dan tenaga medis lainnya untuk meminimalisir komplikasi post operasi. Mobilisasi dini adalah prinsip utama dalam *ERAS* yang didukung dengan pelepasan kateter urine secara dini post operasi dan penggunaan anestesi yang optimal. Mobilisasi dini dapat dilakukan segera pasca pembedahan atau dalam 24 jam pasca operasi (Sari 2024).

Sebagai bagian dari proses pemulihan, ibu pasca sectio caesarea dianjurkan untuk melakukan mobilisasi dini. Mobilisasi adalah suatu kebutuhan dasar manusia yang diperlukan oleh individu untuk melakukan aktivitas sehari-hari yang berupa pergerakan sendi, sikap, gaya berjalan, latihan maupun kemampuan aktivitas, sehingga dalam mempertahankan mobilisasi fisik secara optimal maka sistem saraf, otot, dan skeletal harus tetap utuh dan berfungsi baik (Potter & Perry, 2010). Mobilisasi dini pada ibu pasca sectio caesarea harus segera dilakukan untuk mencegah terjadinya komplikasi pada ibu dan membantu mempercepat proses penyembuhan ibu.

Menurut panduan ERAS, ibu pasca sectio caesarea akan diberikan intervensi mobilisasi dini yang terbagi menjadi 4 tahap. Tahapan ini akan dilakukan dalam 4 hari pertama setelah operasi. Setiap tahapnya akan dilakukan di bawah pengawasan tenaga medis atau anggota keluarga yang telah dilatih ataupun diberikan panduan untuk melakukan mobilisasi dini (Sari 2024). Berikut adalah tahapan mobilisasi dini pada ibu pasca sectio caesarea:

1. Tahap pertama mobilisasi dini dimulai pada 6-24 jam pertama pasca operasi

Ibu mulai diberikan edukasi mengenai pentingnya mobilisasi dini, diajarkan dan dibantu untuk melakukan *ROM (Range Of Motion)* secara pasif. *ROM* pasif berupa pergerakan sendi tangan dan kaki serta mengelevasi atau menaikkan posisi kepala tempat tidur pada kisaran 15-90° diikuti dengan teknik relaksasi nafas dalam dan batuk efektif.

2. Tahap kedua dilakukan pada 24 jam kedua (25-48 jam) pasca operasi

Ibu disarankan untuk mulai duduk di tempat tidur tanpa bersandar, kaji dan observasi keadaan nyeri yang dirasakan. Bila nyeri dirasa dapat ditoleransi, maka selanjutnya ibu dapat duduk di tepi tempat tidur sebagai aktivitas lanjutan pada tahap kedua.

3. Tahap ketiga dilakukan pada 24 jam ketiga (49-72 jam) pasca operasi

Pada tahap ini diharapkan kateter urine sudah dilepas karena akan mulai berlatih berdiri di samping tempat tidur dan berjalan di sekitar tempat tidur.

4. Tahap keempat dilakukan pada 4x24 jam pasca operasi (73-96 jam)

Pada tahapan akhir ini, diharapkan ibu sudah dapat berjalan.



Mobilisasi Tahap ke-1



Mobilisasi tahap ke-2



Mobilisasi dini tahap ke-3

Mobilisasi tahap ke-4

**Gambar 3.5 Mobilisasi Dini pada Ibu Post Sectio Caesarea
(Lecturio Nursing 2024)**

Monitoring tanda-tanda vital seperti tekanan darah, saturasi oksigen, frekuensi nafas, dan frekuensi nadi, serta tingkat nyeri sangat penting dilakukan sebelum dan sesudah latihan mobilisasi. Beberapa faktor yang dapat menjadi kendala bagi ibu untuk melakukan mobilisasi dini adalah nyeri, kurangnya edukasi, kurangnya kesadaran pasien terhadap pentingnya mobilisasi dini pasca operasi, termasuk faktor budaya (adanya anggapan bahwa jika ibu banyak bergerak dapat menyebabkan luka jahitan operasi menjadi kurang baik atau akan terbuka).

Perawat dapat memberikan edukasi mengenai pentingnya mobilisasi dini. Ibu pasca sectio caesarea merasakan nyeri terutama ketika bergerak dari berbaring ke posisi duduk dan sebaliknya. Meskipun nyeri, namun ibu perlu memahami bahwa bergerak atau mobilisasi akan membantu proses penyembuhan luka operasi, memperlancar peredaran darah, dan proses pencernaan. Selama proses pemulihan, ibu disarankan untuk tidak mengangkat beban yang berat.

Selain mobilisasi dini, penggunaan metode ERACS juga dapat membantu mengurangi nyeri pasca operasi. Hal ini dikarenakan penerapan beragam tatalaksana nyeri dan dosis pemberian obat anastesi dikurangi sehingga dengan penurunan dosis memungkinkan terjadi proses pemulihan yang lebih cepat (Ruspita, Cholifah, and Rosyidah 2023). ERACS dapat meredakan nyeri pada pasien pasca operasi melalui rute intraoperatif untuk menginduksi analgesia multimodal, termasuk pemberian morfin intratekal (50-150 gram) atau morfin epidural (1-3 mg) (Bollag et al. 2021). Untuk mengontrol rasa sakit, pasien pasca ERACS biasanya menerima opioid intratekal setiap 6 jam, diikuti dengan asetaminofen dan obat antiinflamasi nonsteroid (NSAID). Pasien dijadwalkan untuk menerima 24 jam acetaminophen intravena (IV) diikuti dengan acetaminophen oral. Manajemen nyeri rawat inap bertujuan untuk memisahkan pemberian opioid dari analgesik lain (seperti NSAID dan asetaminofen).

Implementasi program ERACS pada pasien yang menjalani operasi caesar elektif dikaitkan dengan pengurangan paparan opioid rawat inap dan rawat jalan dan perubahan dalam perawatan bedah tanpa memperburuk hasil bedah (Hedderson et al. 2019). ERACS adalah program pemulihan operasi caesar yang telah dievaluasi manfaatnya seperti meminimalkan komplikasi serta menghasilkan pemulihan fungsional yang lebih cepat. Evaluasi program ERACS mengungkap adanya manfaat tambahan, termasuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan upaya memberikan kenyamanan maksimal bagi ibu bersalin, serta mempercepat proses perawatan dan pemulihan dengan tetap mengutamakan keselamatan pasien. Mobilisasi dini dalam protokol ERACS menurunkan angka kejadian infeksi pasca operasi seperti infeksi luka pasca operasi dan infeksi saluran kemih. Penggunaan analgesik yang baik dan pemanasan intraoperatif dapat meningkatkan kenyamanan pasien selama pembedahan. Nutrisi oral pasca operasi dini juga sangat penting untuk menjaga homeostasis tubuh, mempercepat pemulihan, dan memungkinkan pasien untuk kembali beraktivitas (Sriwahyunita and Futriani 2024).

Nyeri post operasi merupakan keluhan yang paling sering dialami oleh ibu pasca operasi caesar. Nyeri merupakan suatu pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan akibat dari kerusakan jaringan yang bersifat subjektif (Potter and Perry 2010). Selama tindakan operasi caesar, ibu tidak mengalami sensasi nyeri akibat pemberian anestesi. Namun, setelah efek anestesi menghilang, ibu akan merasakan nyeri post operasi, terutama di area insisi. Proses penyembuhan luka operasi caesar membutuhkan waktu yang cukup lama karena melibatkan banyak lapisan jaringan yang perlu diperbaiki. Rasa nyeri yang dirasakan pada bekas jahitan adalah bagian normal dari proses penyembuhan ini. Meskipun demikian, rasa nyeri yang intens dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan menyebabkan ketidaknyamanan.

Mayoritas ibu bersalin yang menjalani operasi caesar (85,5%) mengalami nyeri pada tingkat sedang hingga berat dalam 24 jam pertama pasca operasi (Demelash et al. 2020). Rasa nyeri pasca operasi caesar umumnya akan mencapai puncaknya dalam 24-48 jam pertama (Solehati and Rustina 2015). Meskipun demikian, durasi nyeri dapat lebih panjang dan bervariasi antar individu. Faktor seperti persepsi, toleransi individu terhadap nyeri, ambang nyeri dan cara mengelola nyeri juga dapat mempengaruhi durasi nyeri. Beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi durasi dan intensitas nyeri pasca operasi meliputi : usia, spiritualitas (mencakup keyakinan terhadap kekuatan spiritual atau Tuhan, dapat menjadi mekanisme koping yang efektif dalam menghadapi rasa sakit), budaya (setiap budaya memiliki cara yang berbeda dalam memahami dan mengatasi nyeri), tingkat pendidikan (seseorang dengan pendidikan yang lebih tinggi cenderung melaporkan

tingkat nyeri yang lebih tinggi setelah operasi), pengalaman nyeri sebelumnya (seseorang yang pernah mengalami nyeri sebelumnya memiliki kecenderungan untuk mampu mengelola nyeri dengan lebih baik), sikap dan keyakinan (sikap positif atau negatif terhadap nyeri dapat mempengaruhi intensitas nyeri yang dirasakan), tingkat kecemasan (masalah psikologis: cemas, dapat memperparah rasa nyeri), dan penggunaan anastesi spinal yang sering digunakan untuk operasi caesar (Rahmayati, Hardiansyah, and Nurhayati 2018).

Nyeri pasca sectio caesarea akan menimbulkan reaksi fisik dan psikologi pada ibu seperti gangguan terhadap mobilisasi, pemenuhan *Activity of Daily Living* (ADL) dan Inisiasi Menyusu Dini (IMD), serta kesulitan dalam perawatan bayi. Bahkan jika nyeri tidak dikelola dengan baik, dapat meningkatkan risiko depresi post-partum yang berdampak negatif pada ikatan ibu-anak (*bounding attachment*) dan proses pemulihan (P. G. Barash, 2009, dalam Admass et al. 2024). Ibu memerlukan upaya untuk mengendalikan rasa nyeri agar dapat beradaptasi terhadap nyeri pasca sectio caesarea dan mempercepat proses pemulihannya. Pemulihan dini sangat penting terutama bagi ibu yang melahirkan melalui operasi caesar agar dapat segera merawat bayinya setelah menjalani tindakan operasi.

Managemen atau penatalaksanaan nyeri secara umum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu farmakologis dan non farmakologis. Terapi farmakologis dilakukan dengan pemberian obat analgesik yang diresepkan oleh dokter. Analgesik merupakan golongan obat yang dapat mengurangi atau menghilangkan nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Nyeri yang dirasakan seseorang dapat dikontrol dengan mengkonsumsi obat pereda nyeri. Penggunaan analgesik merupakan komponen integral dalam manajemen nyeri pasca sectio caesarea yang memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi ibu (Admass et al. 2024). Penggunaan anti inflamasi non steroid (AINS) dapat digunakan sebagai analgesik pilihan pada persalinan sectio caesarea sehingga dapat menghindari efek samping opioid. Ketoprofen dan ketorolak merupakan obat golongan AINS yang dapat digunakan untuk terapi analgetik pasca sectio caesarea. Pemberian analgesik perlu mempertimbangkan ketepatan indikasi, ketepatan obat dan ketepatan dosis (Prasetyaningrum, Irnanda, and Haryanti 2016).

Terapi non farmakologis merupakan alternatif yang relatif aman dipergunakan untuk mengelola nyeri. Dalam upaya mengatasi nyeri, khususnya pasca operasi caesar, terapi non farmakologis semakin diminati. Teknik relaksasi banyak diaplikasikan untuk menurunkan tingkat nyeri pasca sectio caesarea. Relaksasi adalah suatu cara untuk menurunkan nyeri dengan menurunkan ketegangan otot, mengistirahatkan atau merelaksasikan otot-otot (Potter and Perry 2010). Relaksasi dapat mengurangi ketegangan otot, tubuh secara alami dapat

meningkatkan ambang toleransi terhadap rasa sakit. Beberapa teknik relaksasi yang populer meliputi: 1) Pernapasan dalam, melibatkan pernapasan yang lambat dan dalam untuk merangsang produksi endorfin, zat penghilang rasa sakit alami tubuh. Endorfin bekerja dengan cara menghambat sinyal nyeri yang dikirim ke otak, 2) *Progressive Muscle Relaxation* (PMR), dengan teknik mengencangkan dan melemaskan otot secara bergantian, dapat mengurangi ketegangan otot, menurunkan tekanan darah, dan sirkulasi darah, 3) Relaksasi Benson, menggabungkan unsur spiritual dengan relaksasi fisik untuk menciptakan kondisi yang tenang dan damai, meredakan kecemasan dan mengurangi intensitas nyeri, 4) *Guided imagery*, melibatkan penggunaan imajinasi untuk menciptakan visualisasi yang menenangkan. Dengan memfokuskan pikiran pada gambar yang menyenangkan, tubuh dapat merespons dengan relaksasi.

Terapi non farmakologis lainnya, berupa *massage* (pijatan) dapat meredakan nyeri, mengurangi ketegangan otot, dan meningkatkan sirkulasi darah. Beberapa jenis pijatan yang efektif untuk mengelola nyeri seperti : 1) akupunktur, dengan teknik penusukan jarum pada titik-titik tertentu di tubuh untuk merangsang aliran energi dan mengurangi nyeri, 2) *deep tissue massage*, pijatan dengan memberikan tekanan yang lebih dalam pada otot dan jaringan ikat untuk melepaskan ketegangan yang mendalam, 3) pijat kaki dapat membantu meredakan nyeri di seluruh tubuh karena adanya banyak titik refleksi yang berhubungan dengan organ-organ dalam. Aromaterapi juga banyak dipergunakan sebagai terapi non farmakologi menggunakan minyak esensial, seperti lavender, untuk mengurangi nyeri dan meningkatkan kenyamanan. Aroma lavender memiliki efek menenangkan, dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan, serta meningkatkan kualitas tidur. Demikian pula dengan mendengarkan musik yang menenangkan menjadi cara yang efektif untuk mengurangi nyeri. Musik dapat mengalihkan perhatian dari rasa sakit dan memicu produksi endorfin, sehingga meningkatkan suasana hati dan mengurangi stres. Dengan memilih metode yang sesuai, setiap individu dapat menemukan cara yang paling efektif untuk meredakan nyeri dan meningkatkan kualitas hidupnya (Napisah 2022).

Selain mobilisasi dini dan penatalaksanaan nyeri pada luka operasi, hal-hal yang perlu diperhatikan pada pemulihan kondisi pasca sectio caesarea adalah:

1. Menyusui bayi

IMD adalah proses menyusui dimulai secepatnya segera setelah lahir. IMD dilakukan pada semua bayi dan ibu dalam kondisi bugar, sehat fisik dan jasmani, penyakit terkontrol tanpa memandang jenis persalinan (PP POGI, 2022). Dengan demikian, IMD dapat dilakukan segera pasca sectio caesarea. IMD dianjurkan dilakukan setelah kondisi ibu dan bayi stabil. IMD atau permulaan menyusui dini

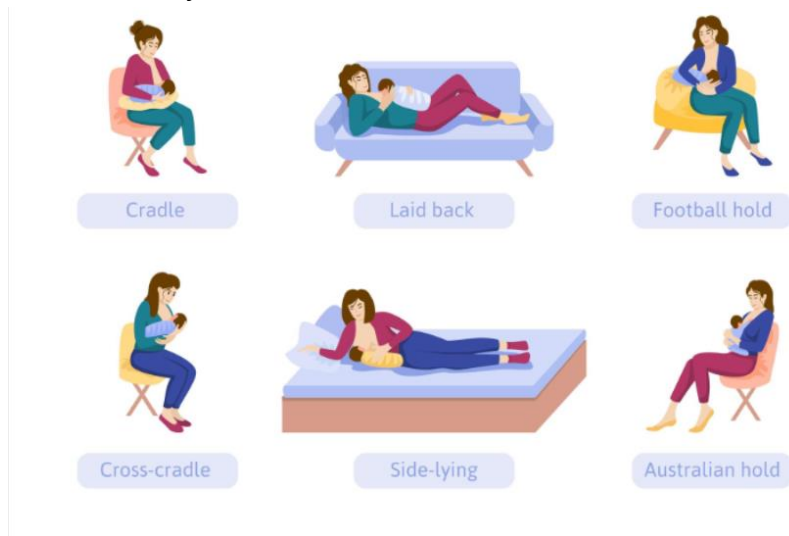
disebut juga sebagai proses *breast crawl*, yaitu bayi mulai menyusui sendiri setelah lahir (Fitriani 2021). Meskipun prosedur bedah dapat sedikit menghambat produksi ASI, namun rangsangan yang konsisten melalui aktivitas menyusui yang sering dapat merangsang *refleks let-down* dan meningkatkan produksi ASI. Tenaga kesehatan termasuk perawat maternitas dapat memfasilitasi proses IMD, mengajarkan teknik menyusui yang benar, melakukan penanganan nyeri, dan mengatur posisi menyusui yang paling sesuai. Perawat membantu ibu dan bayi menemukan posisi menyusui yang nyaman dan efektif, mengingat adanya keterbatasan gerak ibu pasca operasi. Posisi menyusui yang tepat dapat meminimalkan rasa nyeri pada luka bekas operasi, kelelahan, dan kesulitan dalam bergerak.



Gambar 3.6 Inisiasi Menyusu Dini
(<https://www.freepik.com> 2024)

Pengaturan posisi saat menyusui yang tepat dapat menjadi salah satu intervensi untuk meningkatkan kenyamanan ibu pasca sectio caesarea. Posisi *laid-back/semi-reclining* atau rebahan dirasakan lebih nyaman bagi ibu yang baru melahirkan, nyeri pada luka jahitan baik luka episiotomi ataupun luka operasi dirasakan lebih minimal dibandingkan duduk tegak, sehingga secara tidak langsung mendukung ibu untuk bertahan lebih lama dalam menyusui (Colson 2012). Hasil penelitian (Rini and Susanti 2018) membuktikan intervensi posisi menyusui *biologic nurturing baby led feeding* dapat menurunkan tingkat nyeri pada ibu pasca sectio caesarea. Intervensi ini mampu mengalihkan toleransi nyeri dan ambang batas nyeri saat dan setelah ibu menjalani aktifitas menyusui dan kontak langsung dengan bayi. Ketika proses menyusui, ibu dapat beradaptasi serta berespons terhadap nyeri dengan lebih baik, sehingga ibu lebih toleran terhadap rasa nyeri yang dialaminya. Saat menyusui, posisi ibu berbaring (rebahan) sambil bersandar, dengan sudut kemiringan antara 15°-64°, kemudian

bayi diletakkan di atas dada, dan dibiarkan melekat dengan sendirinya. Ibu merasa lebih nyaman, lebih tenang, dan lebih rileks, sehingga dapat mengurangi ketegangan otot dan nyeri.



Gambar 3.7 Breastfeeding Positions
(<https://www.freepik.com> 2024)

2. Pemenuhan asupan gizi

Setelah menjalani operasi caesar, ibu membutuhkan nutrisi yang mengandung tinggi kalori tinggi protein untuk menunjang proses penyembuhan luka dan produksi ASI yang berkualitas (Puspitasari et al. 2011). Status gizi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi proses penyembuhan luka post operasi (Balla, Paun, and Ludji 2018). Nutrisi yang seimbang dan bergizi tinggi sangat penting untuk mendukung kesehatan ibu dan bayi. Protein memiliki peran esensial dalam proses regenerasi jaringan dan percepatan penyembuhan luka. Sumber protein hewani seperti daging tanpa lemak, telur, dan ikan serta sumber protein nabati seperti kacang-kacangan sangat dianjurkan. Selain protein, mikronutrien seperti vitamin C, vitamin A, zinc, dan selenium juga berkontribusi signifikan dalam proses penyembuhan. Konsumsi buah-buahan dan sayuran segar secara rutin serta menjaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup merupakan langkah penting untuk mendukung proses penyembuhan (Hasanah 2024).

Kebutuhan nutrisi ibu pasca operasi caesar tidak hanya terbatas pada proses penyembuhan luka operasi, melainkan juga mencakup pemenuhan kebutuhan nutrisi untuk mendukung laktasi. Ibu membutuhkan berbagai macam nutrisi, termasuk karbohidrat, lemak, dan protein. Karbohidrat dan lemak berfungsi sebagai sumber energi utama untuk aktivitas sehari-hari dan produksi ASI. Protein penting untuk memperbaiki jaringan tubuh dan meningkatkan produksi ASI. Selain itu, vitamin dan mineral seperti vitamin C, vitamin A, zat besi,

dan yodium juga sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan ibu dan bayi. Lemak tidak hanya sebagai sumber energi, tetapi juga membantu penyerapan vitamin larut lemak dan mendukung perkembangan otak bayi (Hasanah 2024).

3. Perawatan luka operasi

Proses penyembuhan luka insisi menjadi fokus utama dalam perawatan pasca operasi. Penyembuhan luka adalah proses biologis yang kompleks yang melibatkan beberapa tahapan berikut:

a. Tahap homeostasis

Pada tahap ini tubuh akan menghentikan perdarahan melalui proses pembekuan darah

b. Tahap inflamasi

Tubuh merespons cedera dengan mengirimkan sel darah putih dan zat peradangan ke area luka untuk membersihkan jaringan yang rusak dan memulai proses perbaikan.

c. Tahap proliferasi

Tubuh akan membentuk jaringan baru (granulasi), pembentukan pembuluh darah baru (angiogenesis), dan penutupan luka oleh sel-sel epitel (epitelisasi)

d. Tahap maturasi

Tahap terakhir penyembuhan luka dengan pembentukan jaringan luka menjadi lebih kuat dan fleksibel

(Suprpto 2021).

Perawatan luka yang tepat sangat penting untuk mempercepat proses penyembuhan dan mencegah komplikasi. Untuk mendukung proses penyembuhan luka yang optimal, ibu perlu melakukan tindakan sebagai berikut:

a. Pengantian balutan luka

Pergantian balutan luka dilakukan untuk mencegah terjadinya kontaminasi oleh mikroorganisme patogen. Frekuensi penggantian balutan ditentukan berdasarkan volume eksudat luka, jenis balutan yang digunakan, serta rekomendasi mengenai perawatan luka dari tenaga kesehatan yang berkompeten.

b. Pembatasan aktivitas

Ibu pasca operasi caesar dianjurkan untuk membatasi aktivitas fisik yang meningkatkan tekanan intra-abdominal, seperti mengangkat beban berat atau melakukan gerakan yang melibatkan peregangan otot perut. Hal ini bertujuan untuk mencegah *dehiscence* luka dan hematoma. Aktivitas ringan seperti olah raga ringan masih dapat dilakukan untuk mempercepat penyembuhan, memperlancar sirkulasi darah, mencegah konstipasi, meningkatkan imunitas tubuh.

c. Pertahankan kebersihan luka

Luka harus dibersihkan secara teratur menggunakan larutan antiseptik yang sesuai dengan jenis luka dan anjuran dokter. Teknik pembersihan yang lembut sangat penting untuk menghindari trauma pada jaringan granulasi.

d. Penggunaan obat topikal

Jika diperlukan, dokter dapat meresepkan obat topikal seperti salep antibiotik atau gel untuk mempercepat proses epitelisasi dan mencegah infeksi.

e. Pemantauan tanda-tanda infeksi

Ibu diinstruksikan untuk memantau tanda-tanda infeksi, seperti terasa salit (nyeri), gatal, dan panas pada bekas luka operasi, perubahan warna kulit sekitar luka operasi menjadi kemerahan, terasa pembengkakan pada bekas luka operasi, dan keluarnya eksudat berupa cairan putih kekuningan (purulen) atau darah di sela-sela jahitan operasi. Jika muncul tanda-tanda infeksi, ibu dianjurkan untuk segera menghubungi tenaga kesehatan.

f. Penuhi kebutuhan istirahat

Istirahat yang cukup membantu tubuh memulihkan energi yang dibutuhkan untuk proses penyembuhan.

g. Penuhi nutrisi yang tepat dan seimbang

Nutrisi memegang peran penting dalam proses penyembuhan luka. Asupan nutrisi yang tepat akan membantu tubuh memperbaiki jaringan yang rusak dan mempercepat proses penyembuhan. Ibu pasca sectio caesar disarankan untuk mengonsumsi makanan bergizi meliputi:

- 1) Protein merupakan komponen utama dalam pembentukan jaringan tubuh, termasuk kulit. Asam amino yang terkandung dalam protein berfungsi sebagai bahan yang dipergunakan untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Sumber protein dapat berasal dari daging (sapi, ayam, ikan), telur, kacang-kacangan, produk susu (susu, yogurt, keju), tofu.
- 2) Vitamin C, berperan penting dalam produksi kolagen, yaitu protein yang memberikan kekuatan pada jaringan kulit. Vitamin C juga sebagai antioksidan yang melindungi sel dari kerusakan. Sumber vitamin C berupa buah-buahan (jeruk, jambu biji, pepaya, mangga, stroberi, lemon, kiwi), sayuran (brokoli, kembang kol, bayam, kale).
- 3) Zinc berperan dalam proses penyembuhan luka dengan membantu pembentukan kolagen dan meningkatkan fungsi sistem kekebalan tubuh. Sumber zinc berasal dari daging, kacang-kacangan.
- 4) Vitamin A penting untuk menjaga kesehatan kulit dan membantu proses regenerasi sel. Sumber vitamin A berasal dari sayuran (wortel, labu, bayam), buah-buahan (mangga, pepaya).

- 5) Kalori, berperan sebagai energi tambahan untuk proses penyembuhan.
- h. Konsumsi obat-obatan sesuai anjuran dokter
Konsumsi obat-obatan yang diberikan oleh dokter untuk mengurangi nyeri dan mencegah infeksi.
- i. Jaga kebersihan diri
Higiene pribadi yang baik, termasuk mandi secara teratur, sangat penting dalam proses penyembuhan luka. Jika dokter telah mengizinkan penggunaan perban tahan air, ibu dapat mandi dengan membasahkan area luka saat mandi dan menjaga kebersihan area luka. Penggunaan pakaian yang longgar dan berbahan katun dapat membantu menjaga kulit tetap kering dan mengurangi risiko iritasi.

4. Dukungan sosial

Pemberian dukungan sosial atau *social support*, baik dari keluarga (suami, orang tua), teman maupun tenaga kesehatan, sangat penting bagi ibu pasca melahirkan. Dukungan ini dapat membantu ibu beradaptasi dan mengatasi perubahan fisik dan emosi yang terjadi setelah melahirkan, serta mencegah terjadinya gangguan psikologis seperti *postpartum blues*. Kesejahteraan psikologis ibu akan meningkat dengan adanya dukungan sosial yang baik. Sebaliknya, pada ibu postpartum yang kurang mendapatkan dukungan dari suami dan keluarga dapat menyebabkan *postpartum blues* (Astri, Fatmawati, and Gartika 2020). Dukungan sosial suami, dukungan sosial keluarga dan dukungan sosial media sosial sangat dibutuhkan oleh ibu pasca bersalin dan dukungan sosial tersebut mempengaruhi terhadap terjadinya kejadian postpartum blues (Reviansyah 2021)

Bentuk dukungan keluarga dapat berupa pemberian motivasi bagi ibu yang baru menjalani operasi caesar untuk lebih aktif dalam melakukan mobilisasi dini. Perhatian dan semangat dari keluarga membuat ibu merasa lebih percaya diri untuk bergerak (Nadziroh, Kusumastuti, and Novita 2023). Kemandirian pasca persalinan caesar merujuk pada kemampuan seorang ibu dalam melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari secara mandiri, seperti pemenuhan kebutuhan mandi, makan, berpakaian, bergerak. Tingkat kemandirian ibu dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu tingkat pengetahuan ibu tentang perawatan luka operasi, jumlah kelahiran sebelumnya, usia, penerapan program mobilisasi dini, dan termasuk dukungan emosional yang bersumber dari keluarga (Herlina, 2011 dalam Indanah et al. 2021). Peningkatan tingkat kemandirian ibu dapat tercapai melalui pelaksanaan perencanaan pemulangan (*discharge planning*) yang bertujuan untuk memberikan pasien dan keluarga pengetahuan serta

keterampilan yang diperlukan dalam melanjutkan perawatan di rumah (Istiyati, Haryanto, and Subandono 2014).

Dukungan keluarga pada ibu pasca sectio caesarea juga berhubungan dengan pemberian kolostrum (Astuti, Nasriyah, and Wigati 2024). Pemberian kolostrum dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti umur, paritas, pendidikan, pengetahuan dan dukungan keluarga. Pemberian dukungan oleh keluarga, terutama suami memiliki korelasi dengan keberlangsungan ASI eksklusif (Suraeda 2020). Bentuk dukungan yang dapat diberikan oleh keluarga cukup bervariasi, meliputi: dukungan emosional dengan menjaga tutur kata sehingga ibu tidak tersinggung dan tidak stres; dukungan instrumental diwujudkan dengan membantu ibu mengurus atau merawat anak dan membantu menyelesaikan pekerjaan rumah ; dukungan informasi seputar pemberian ASI ; dan dukungan penilaian yang positif (Suraeda 2020). Selain faktor pendukung, terdapat beberapa hal yang dapat menghambat pemberian ASI eksklusif, seperti kurangnya pengetahuan tentang ASI, budaya yang tidak mendukung menyusui, dan kurangnya dukungan keluarga. Kurangnya dukungan, terutama dari suami, dapat menyebabkan stres pada ibu dan berdampak negatif pada produksi ASI

5. Kontrol ke pelayanan kesehatan terdekat

Setelah menjalani tindakan operasi caesar, ibu umumnya dapat kembali ke rumah setelah 3-5 hari masa perawatan di rumah sakit. Meskipun demikian, sangat penting bagi ibu untuk tetap melakukan pemeriksaan rutin (kontrol) ke fasilitas kesehatan terdekat. Adapun tujuan pemeriksaan atau kunjungan ibu pasca caesarea adalah untuk memantau proses penyembuhan, mendeteksi dini jika ada komplikasi, dan memastikan kesehatan ibu dan bayi tetap optimal.

Proses penyembuhan pasca sectio caesarea membutuhkan waktu pemulihan yang relatif lama. Proses penyembuhan setiap individu berbeda-beda, namun secara umum, berikut adalah tahapan yang akan dilalui:

a. Minggu pertama

- 1) Nyeri: rasa nyeri terutama pada area insisi luka operasi dapat diatasi dengan teknik farmakologis (mengonsumsi obat pereda nyeri yang telah diresepkan dokter) dan teknik non farmakologis.
- 2) Istirahat total: hindari melakukan aktivitas berat dan angkat beban
- 3) Perhatikan luka: jaga kebersihan luka, lakukan perawatan luka / ganti perban sesuai anjuran tenaga kesehatan
- 4) Kontrol rutin: lakukan kontrol ke tenaga kesehatan (dokter, perawat maternitas atau bidan) untuk memantau kondisi luka dan kesehatan secara umum

b. Minggu kedua hingga keempat

- 1) Nyeri berkurang: intensitas nyeri akan berkurang secara bertahap
- 2) Aktivitas ringan: mulai lakukan aktivitas ringan seperti berjalan-jalan singkat di dalam rumah
- 3) Perhatikan postur tubuh: saat mengangkat atau menggendong bayi, gunakan teknik yang benar untuk menghindari nyeri punggung
- 4) Kontrol rutin: terus lakukan kontrol ke tenaga kesehatan

c. Setelah 4 minggu

- 1) Aktivitas normal: secara bertahap, ibu dapat kembali melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya
- 2) Kontrol rutin: frekuensi kontrol dapat berkurang, namun tetap penting untuk tetap mengikuti anjuran tenaga kesehatan

Sebagai upaya menjaga kesehatan, ibu disarankan untuk mengikuti jadwal pemeriksaan kesehatan yang telah ditentukan. Pelayanan kesehatan ibu nifas, termasuk ibu post sectio caesarea minimal empat kali dengan waktu kunjungan ibu dan bayi baru lahir bersamaan, yaitu pada enam jam sampai dengan dua hari setelah persalinan, pada hari ke-3 sampai dengan hari ke-7 setelah persalinan, pada hari ke-8 sampai dengan hari ke-28 setelah persalinan, dan pada hari ke-29 sampai dengan 42 hari setelah persalinan. Adapun jenis pelayanan kesehatan ibu nifas yang diberikan meliputi: 1) anamnesis, 2) pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi dan suhu, 3) pemeriksaan tanda-tanda anemia, 4) pemeriksaan tinggi fundus uteri, 5) pemeriksaan kontraksi uteri, 6) pemeriksaan kandung kemih dan saluran kencing, 7) pemeriksaan lochia dan perdarahan, 8) pemeriksaan jalan lahir, 9) pemeriksaan payudara dan pendampingan pemberian ASI eksklusif, 10) identifikasi risiko tinggi dan komplikasi pada masa nifas, 11) pemeriksaan status mental ibu, 12) pelayanan kontrasepsi pasca persalinan, 13) pemberian Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dan konseling, 14) pemberian kapsul vitamin A.

Bagi ibu bersalin yang telah melakukan kunjungan nifas sebanyak empat kali dapat dihitung telah melakukan kunjungan nifas lengkap (KF lengkap) (Kementerian Kesehatan RI 2023). Studi mengenai kunjungan masa nifas di Indonesia menunjukkan bahwa kunjungan masa nifas di Indonesia mayoritas (80%) menerapkan minimum standar kunjungan masa nifas pada layanan kesehatan adalah tiga kali atau hingga KF3. Beberapa faktor perilaku kesehatan pada ibu nifas yang mempengaruhi kunjungan masa nifas meliputi: 1) faktor predisposisi (mayoritas faktor sikap dan pengetahuan), 2) faktor pendukung (kemudahan akses transportasi), dan 3) faktor pendukung yaitu peran tenaga kesehatan dan dukungan keluarga ((Zalukhu and Girsang 2023).

D. Tantangan dan Solusi dalam Proses Pemulihan Pasca Sectio Caesarea

Operasi caesar merupakan prosedur yang sangat bermanfaat, terutama dalam situasi darurat persalinan, misalnya ketika persalinan berlangsung lama, *fetal distress*, atau malposisi janin sehingga tidak memungkinkan untuk persalinan pervaginam. Meskipun demikian, tindakan operasi caesar sama seperti jenis operasi lainnya, dapat menimbulkan risiko masalah kesehatan baik pada ibu maupun bayinya (Sungkar and Basrowi 2020). Persalinan dengan operasi caesar memiliki risiko yang jauh lebih besar untuk mengalami komplikasi serius, bahkan terjadinya kematian (Maryanti and Endrike M 2019). Beberapa komplikasi yang dapat terjadi pada ibu pasca operasi caesar meliputi nyeri pada luka insisi, infeksi puerperal (nifas), penurunan mobilitas, cedera pada kandung kemih, perdarahan post-operatif, dan kejadian tromboemboli, waktu pemulihan yang lebih lambat setelah melahirkan, keterlambatan dalam memulai menyusui dan kontak kulit ke kulit, serta peningkatan kemungkinan komplikasi pada kehamilan berikutnya (Ratna, Ermianti, and Widiastih 2012) ; (WHO 2021).

Asuhan keperawatan yang komprehensif, termasuk mobilisasi dini, sangat penting untuk mencegah terjadinya komplikasi tersebut (Brunner, L & Suddarth 2013). Namun, nyeri pasca operasi merupakan hambatan utama dalam pelaksanaan mobilisasi dini pada ibu pasca sectio caesarea (Ditya, Zahari, and Afriwardi 2016). Nyeri yang dirasakan berdampak terhadap ketidaknyamanan secara fisik, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran akan terbukanya luka operasi. Hal ini menjadi alasan utama ibu menolak untuk melakukan mobilisasi. Ibu pasca sectio caesarea lebih memilih untuk berbaring sehingga dapat mengakibatkan kekakuan sendi, kontraktur otot, gangguan postur tubuh, dan nyeri tekan (Rottie and Saragih 2019). Padahal, mobilisasi dini setelah operasi sangat dianjurkan untuk mengurangi intensitas nyeri, mempercepat proses penyembuhan luka dan mencegah terjadinya komplikasi pasca bedah (Smeltzer, S. C., & Bare 2001).

Luka merupakan gangguan pada kontinuitas jaringan anatomi yang dapat disebabkan oleh berbagai etiologi, baik eksogen maupun endogen. Proses penyembuhan luka dipengaruhi oleh berbagai variabel, termasuk luas dan kedalaman luka, lokasi anatomis, kapasitas regeneratif jaringan, serta faktor sistemik seperti vaskularisasi, status nutrisi, dan imunitas (Potter and Perry 2010). Proses penyembuhan luka diawali sejak terjadinya cedera dan berlangsung melalui empat fase, yakni hemostasis, inflamasi, proliferasi, dan maturasi. Mobilisasi akan meningkatkan perfusi jaringan, sehingga suplai oksigen dan nutrisi ke area luka meningkat. Hal ini diperlukan untuk proses perbaikan sel dan mempercepat penyembuhan luka (Potter and Perry 2010).

Mobilisasi dini merupakan suatu intervensi yang bertujuan untuk mempertahankan fungsi fisiologis pasien dan mempercepat pemulihan pasca operasi. Pada pasien pasca operasi caesar, mobilisasi dini dapat dimulai segera setelah kondisi pasien stabil dan efek anestesi hilang (Rasjidi 2009). Manfaat dari mobilisasi dini adalah mencegah kekakuan sendi dan otot, memperlancar sirkulasi darah dan mengurangi nyeri supaya proses penyembuhan luka lebih cepat (Rustianawati et al. 2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyembuhan luka pada ibu pasca sectio caesarea adalah nutrisi, mobilisasi dan personal hygiene (Puspitasari et al. 2011). Penelitian-penelitian telah membuktikan bahwa mobilisasi dini memberikan pengaruh terhadap penyembuhan luka ibu pasca sectio caesarea (Eriyani, Shalahuddin, and Maulana 2018); (Mustikarani, Purnani, and Mualimah 2019) .

Insisi pada persalinan sectio caesarea menimbulkan risiko tinggi terjadinya infeksi luka, perdarahan, dan rupture uteri. Infeksi pasca operasi dapat berkembang menjadi sepsis jika daya tahan tubuh ibu lemah. Infeksi luka operasi (ILO) caesarea merupakan masalah kesehatan maternal yang signifikan dan berkontribusi terhadap angka kematian ibu yang tinggi di Indonesia. Status gizi, kadar hemoglobin (Hb), mobilisasi dini, dan manajemen luka merupakan faktor-faktor yang terbukti mempengaruhi insidensi infeksi luka operasi (Trisnawati, Manggul, and Hamat 2023) ; (Kartikasari and Apriningrum 2020).

Keadaan malnutrisi dapat menghambat proses penyembuhan luka secara signifikan. Kekurangan nutrisi membuat tubuh lebih rentan terhadap infeksi, memperlambat pembentukan jaringan baru, dan memperpanjang waktu perawatan di rumah sakit. Hasil penelitian (Kartikasari and Apriningrum 2020) menunjukkan ibu pasca caesarea dengan status gizi tidak normal mempunyai risiko 1,86 kali lebih tinggi untuk mengalami infeksi luka operasi dibandingkan responden dengan status gizi normal.

Hambatan budaya yang berkembang di masyarakat dalam memenuhi kebutuhan nutrisi ibu pasca operasi merupakan tantangan yang kompleks. Adat istiadat dan tradisi lokal yang membatasi konsumsi makanan bergizi, seperti telur, ikan, dan daging, telah menjadi norma sosial yang sulit diubah. Padahal jenis makanan tersebut mengandung protein, zat besi, dan nutrisi penting lainnya yang sangat dibutuhkan untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak dan meningkatkan produksi ASI. Kepercayaan tradisional yang mengutamakan pantangan makanan tertentu seringkali mengabaikan aspek kesehatan yang krusial bagi ibu dan bayi. Dampaknya proses penyembuhan luka menjadi lebih lambat, risiko infeksi meningkat, dan produksi ASI juga menjadi terganggu (Hasanah 2024).

Demikian pula, nutrisi yang tidak adekuat dapat menyebabkan kerentanan bagi ibu untuk mengalami anemia. Infeksi luka operasi pada ibu pasca sectio caesarea dengan anemia sebesar 8,9 kali lebih tinggi dibandingkan ibu yang tidak mengalami anemia (Kartikasari and Apriningrum 2020). Anemia dapat menyebabkan hipoksia jaringan, termasuk pengiriman oksigen ke jaringan luka. Oksigen sangat diperlukan untuk aktivitas makrofag dalam melawan infeksi. Ketika pasokan oksigen terganggu, kemampuan makrofag dalam menghancurkan bakteri dan memicu respons imun menjadi terhambat, sehingga meningkatkan risiko infeksi (Wodajo, Belayneh, and Gebremedhin 2017).

Risiko infeksi luka operasi lebih tinggi pada ibu yang tidak mendapatkan perawatan luka yang baik sebesar 0,03 kali dibandingkan dengan ibu yang mendapatkan perawatan luka yang baik (Kartikasari and Apriningrum 2020). Perawatan luka adalah salah satu keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh setiap perawat. Keterampilan merawat luka sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya infeksi, termasuk pada ibu yang baru menjalani operasi caesar. Dengan mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan untuk perawatan luka, risiko infeksi dapat diminimalkan. Perawat juga memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga tentang cara merawat luka di rumah. Setelah diajarkan perawatan luka, diharapkan ibu dan keluarga mampu melanjutkan perawatan luka di rumah dan pada akhirnya dapat mencegah terjadinya infeksi.

E. Simpulan

Sectio caesarea merupakan prosedur medis yang penting untuk menyelamatkan nyawa ibu dan bayi. Tenaga kesehatan perlu memberikan informasi yang akurat kepada ibu hamil mengenai risiko dan manfaat dari berbagai pilihan persalinan, sehingga ibu dapat membuat keputusan yang tepat.

ERAS adalah pendekatan modern dalam perawatan pasca operasi caesar dengan metode serangkaian tindakan sebelum, selama, dan setelah operasi untuk meminimalkan stres pada tubuh ibu. Manfaat ERAS untuk mempercepat proses pemulihan, mengurangi nyeri, menurunkan risiko komplikasi infeksi, dan meningkatkan kepuasan.

Proses pemulihan pasca sectio caesarea membutuhkan perhatian khusus, baik dari segi fisik maupun psikologis. Tantangan dalam pemulihan terkait dengan nyeri, mobilisasi dan perubahan psikologis. Strategi pemulihan melalui mobilisasi dini, manajemen nyeri, pemberian dukungan sosial, pemenuhan nutrisi seimbang, perawatan luka, istirahat cukup, dan kontrol secara rutin ke tenaga kesehatan guna memantau kondisi kesehatan ibu dan bayi.

F. Referensi

- Admass, Biruk Adie, Fikadu Tadesse Diress, Demeke Yilkal Fentie, and Nigussie Simeneh Endalew. 2024. "Maternal Satisfaction and Associated Factors with Postcesarean Section Pain Management: A Cross-Sectional Study." *Anesthesiology Research and Practice* 2024 (1). <https://doi.org/10.1155/2024/4885678>.
- Adshead, D., I. Wrench, and M. Woolnough. 2016. "Enhanced Recovery for Elective Caesarean Section." *BJA Education* 20 (10): 354–57. <https://doi.org/10.1016/j.bjae.2020.05.003>.
- Astilia, Astilia. 2024. "Penerapan Protocol Eras (Enhanced Recovery After Surgery) Berbasis Bukti Di Ruang Operasi: Systematic Review." *Informasi Dan Promosi Kesehatan* 3 (1): 72–29. <https://doi.org/10.58439/ipk.v3i1.217>.
- Astri, Riani, Ariani Fatmawati, and Gina Gartika. 2020. "Dukungan Sosial Pada Ibu Postpartum Primipara Terhadap Kejadian Postpartum Blues." *JURNAL KESEHATAN PERINTIS (Perintis's Health Journal)* 7 (1): 16–21. <https://doi.org/10.33653/jkp.v7i1.417>.
- Astuti, Dwi, Nasriyah Nasriyah, and Atun Wigati. 2024. "Dukungan Keluarga Terhadap Pemberian Kolostrum Pada Ibu Postpartum Sectio Caesarea." *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan* 15 (1): 68–77. <https://doi.org/10.26751/jikk.v15i1.2180>.
- Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. 2023. "Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 Dalam Angka." Jakarta.
- Balla, Juldin D. E., Rafael Paun, and Ina Debora Ratu Ludji. 2018. "Factors Related to Healing Process of Sectio Caesarea Surgical Wound." *Unnes Journal of Public Health* 7 (2): 126–32. <https://doi.org/10.15294/ujph.v7i2.21705>.
- Betran, A. P., M. R. Torloni, J. J. Zhang, and A. M. Gülmezoglu. 2016. "WHO Statement on Caesarean Section Rates." *BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology* 123 (5): 667–70. <https://doi.org/10.1111/1471-0528.13526>.
- Bollag, Laurent, Grace Lim, Pervez Sultan, Ashraf S. Habib, Ruth Landau, Mark Zakowski, Mohamed Tiouririne, Sumita Bhambhani, and Brendan Carvalho. 2021. "Society for Obstetric Anesthesia and Perinatology: Consensus Statement and Recommendations for Enhanced Recovery After Cesarean." *Anesthesia and Analgesia* 132 (5): 1362–77. <https://doi.org/10.1213/ANE.0000000000005257>.
- Brunner, L & Suddarth, D. 2013. *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah*. 12th ed. Jakarta: EGC.
- Caughey, Aaron B., Stephen L. Wood, George A. Macones, Ian J. Wrench, Jeffrey Huang, Mikael Norman, Karin Pettersson, et al. 2018. "Guidelines for

- Intraoperative Care in Cesarean Delivery: Enhanced Recovery After Surgery Society Recommendations (Part 2)." *American Journal of Obstetrics and Gynecology* 219 (6): 533–44. <https://doi.org/10.1016/j.ajog.2018.08.006>.
- Colson, Suzanne. 2012. "Biological Nurturing: The Laid-Back Breastfeeding Revolution." *Midwifery Today with International Midwife*, no. 101.
- Demelash, Getamesay, Yophtahe Woldegerima, Amare Hailekiros, and Wubie Birlie. 2020. "Postoperative Pain After Cesarean Section at University of Gondar Comprehensive Specialized Hospital." *Research Square*, 1–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-124364/v1>.
- Ditya, Wira, Asril Zahari, and Afriwardi Afriwardi. 2016. "Hubungan Mobilisasi Dini Dengan Proses Penyembuhan Luka Pada Pasien Pasca Laparatomi Di Bangsal Bedah Pria Dan Wanita RSUP Dr. M. Djamil Padang." *Jurnal Kesehatan Andalas* 5 (3): 724–29. <https://doi.org/10.25077/jka.v5i3.608>.
- Eriyani, Theresia, Iwan Shalahuddin, and Indra Maulana. 2018. "Luka Post Operasi Sectio Pengaruh Mobilisasi Dini Terhadap Penyembuhan Luka Post Sectio Caesarea." *Buletin Media Informasi Kesehatan* 14 (2): 182–90.
- Fitriani, Umar. 2021. *Inisiasi Menyusu Dini (IMD) Dan Kelangsungan ASI Anak Di Bawah Dua Tahun*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management.
- Greenshields, Nicole, and Monty Mythen. 2020. "Enhanced Recovery After Surgery." *Current Anesthesiology Reports* 10 (1): 49–55. <https://doi.org/10.1007/s40140-020-00372-y>.
- Habib, Ashraf S., and Unyime Ituk. 2018. "Enhanced Recovery after Cesarean Delivery." *F1000Research* 7 (0): 1–11. <https://doi.org/10.12688/f1000research.13895.1>.
- Hasanah, Firdatul. 2024. "Meningkatnya Kejadian Operasi Sectio Caesarea Di Indonesia: Peran Pola Makan Dalam Proses Penyembuhan." 2024. https://unair.ac.id/post_fetcher/fakultas-vokasi-meningkatnya-kejadian-operasi-sectio-caesarea-di-indonesia-peran-pola-makan-dalam-proses-penyembuhan/.
- Hedderson, Monique, Derrick Lee, Eric Hunt, Kimberly Lee, Fei Xu, Alex Mustille, Jessica Galin, et al. 2019. "Enhanced Recovery After Surgery to Change Process Measures and Reduce Opioid Use After Cesarean Delivery." *Obstetric Gynecology* 134 (3): 511–19. <https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000003406>.Enhanced.
- <https://www.freepik.com>. 2024.
- Indanah, Sri Karyati, Qurrotu A'yuni Aulia, and Fera Wardana. 2021. "Hubungan Status Paritas Dan Mobilisasi Dini Dengan Kemandirian Ibu Post Sectio Caesaria." *The 13 Th University Research Colloqium, Sekolah Tinggi Ilmu*

Kesehatan Muhammadiyah Klaten, 660–65.
<http://repository.urecol.org/index.php/proceeding/article/view/1461/1428>.

- Istiyati, Siti, Samsi Haryanto, and Jarot Subandono. 2014. "Pelaksanaan Discharge Planning Pada Pasien Post Sectio Caesaria." *Jurnal Kebidanan Dan Keperawatan* 10 (2): 103–14. <https://doi.org/10.1201/b21955-8>.
- Kartikasari, Rina, and Nelly Apriningrum. 2020. "Determinan Terjadinya Infeksi Luka Operasi (ILO) Post Sectio Caesarea." *Faletehan Health Journal* 7 (3): 162–69. <https://journal.lppm-stikesfa.ac.id/index.php/FHJ/article/download/195/67/>.
- Kementerian Kesehatan RI. 2023. "Profil Kesehatan Indonesia 2023." Jakarta.
- Kesty, Cindy, and Nuswil Bernolian. 2022. "Enhanced Recovery after Cesarean Section (ERACS)." 2022. https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/236/enhanced-recovery-after-caesarean-section-eracs.
- Lecturio Nursing. 2024. "Nursing Knowledge : Early Ambulation after Surgery." 2024. <https://www.lecturio.com/nursing/free-cheat-sheet/early-ambulation-after-surgery/#cheatsheetdownload-regwall>.
- Macones, George A., Aaron B. Caughey, Stephen L. Wood, Ian J. Wrench, Jeffrey Huang, Mikael Norman, Karin Pettersson, et al. 2019. "Guidelines for Postoperative Care in Cesarean Delivery: Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) Society Recommendations (Part 3)." *American Journal of Obstetrics and Gynecology* 221 (3): 247.e1-247.e9. <https://doi.org/10.1016/j.ajog.2019.04.012>.
- Mustikarani, Yola Alqorien, Weni Tri Purnani, and Miftakhul Mualimah. 2019. "Pengaruh Mobilisasi Dini Terhadap Penyembuhan Luka Post Sectio Caesaria Pada Ibu Post Sectio Caesaria Di Rs Aura Syifa Kabupaten Kediri." *Jurnal Kesehatan* 12 (1): 56–62. <https://doi.org/10.23917/jk.v12i1.8957>.
- Mylonas, Ioannis, and Klaus Friese. 2015. "Indications for and Risks of Elective Cesarean Section." *Deutsches Arzteblatt International* 112 (29–30): 489–95. <https://doi.org/10.3238/arztebl.2015.0489>.
- Nadziroh, Yetti Dianca A'Yun, Istiana Kusumastuti, and Astrid Novita. 2023. "Hubungan Dukungan Keluarga, Peran Bidan Dan Motivasi Ibu Dengan Perilaku Mobilisasi Dini Pasca SC Di RSIA Brawijaya Duren Tiga Jakarta Tahun 2022." *SIMFISIS Jurnal Kebidanan Indonesia* 2 (4): 418–25. <https://doi.org/10.53801/sjki.v2i4.141>.
- Napisah, Pipih. 2022. "Intervensi Untuk Menurunkan Nyeri Post Sectio Caesarea." *HEALTHY: Jurnal Inovasi Riset Ilmu Kesehatan* 1 (2): 92–100. <https://doi.org/10.51878/healthy.v1i2.1113>.

- Potter, P A, and A G. Perry. 2010. *Buku Ajar Fundamental Keperawatan: Konsep, Proses, Dan Praktik*. Edisi 4 Vo. Jakarta: EGC.
- PP POGI. 2022. *Seksio Sesarea : Panduan Klinis*. Jakarta: Pengurus Pusat POGI.
- Prasetyaningrum, Erna, Dara Camelia Irnanda, and Sri Haryanti. 2016. "Kerasionalan Penggunaan Obat Analgetik Pada Pasien Sectio Caesarea Di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Semarang Periode Juli – Desember 2016." *Jurnal Ilmiah Cendekia Eksakta*, 67–70.
- Prawirohardjo, Sarwono. 2014. *Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal Dan Neonatal*. 6th ed. Jakarta: Bina Pustaka.
- Puspitasari, Herlina Abriani, H Basirun, Al Ummah, Tri Sumarsih, Jurusan Keperawatan Stikes, and Muhammadiyah Gombong. 2011. "Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penyembuhan Luka Post Operasi Sectio Caesarea (SC)." *Jurnal Ilmiah Kesehatan Keperawatan* 7 (1): 1–10.
- Rahmayati, El, Raihan Hardiansyah, and Nurhayati. 2018. "Pengaruh Aromaterapi Lemon Terhadap Penurunan Skala Nyeri Pasien Post Operasi Laparatomi." *Jurnal Kesehatan Dan Kedokteran* 9 (3): 427–32. <https://doi.org/10.56127/jukeke.v1i3.934>.
- Rasjidi, I. 2009. *Manual Seksio Sesarea Dan Laparotomi Kelainan Adneksa*. Jakarta: CV Sagung Seto.
- Ratna, Pratiwi, Ermianti, and Restuning Widiasih. 2012. "Penurunan Intensitas Nyeri Akibat Luka Post Sectio Caesarea Setelah Dilakukan Latihan Teknik Relaksasi Pernapasan Menggunakan Aromaterapi." *Students E-Journal*, 1–15.
- Reviansyah, Y.S. Moch. 2021. "Dukungan Sosial Pada Postpartum Blues." *Universitas Muhammadiyah Surakarta*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rini, Susilo, and Indri Heri Susanti. 2018. "Penurunan Nyeri Pada Ibu Post Sectio Caesaria Pasca Intervensi Biologic Nurturing Baby Led Feeding." *Medisains* 16 (2): 83. <https://doi.org/10.30595/medisains.v16i2.2801>.
- Rottie, Julia, and Rianti Erlita Saragih. 2019. "Pengaruh Mobilisasi Dini Terhadap Penyembuhan Luka Post Sectio Caesarea Di Irina D Bawah RSUP Prof Dr. R. D. Kandou Manado." *Journal Of Community and Emergency* 7 (3): 431–40.
- Ruspita, Ida, Siti Cholifah, and Rafhani Rosyidah. 2023. "Pain Score and Quality of Post Cesarean Section Recovery with ERACS Method." *JNKI (Jurnal Ners Dan Kebidanan Indonesia) (Indonesian Journal of Nursing and Midwifery)* 11 (1): 1. [https://doi.org/10.21927/jnki.2023.11\(1\).1-10](https://doi.org/10.21927/jnki.2023.11(1).1-10).
- Rustianawati, Yuni, Sri Karyati, Rizka Himawan, Kata Kunci, Intensitas Nyeri, and Ambulasi Dini. 2013. "Efektivitas Ambulasi Dini Terhadap Penurunan Intensitas Nyeri Pada Pasien Post Operasi Laparatomi Di RSUD Kudus."

- Sarafino, E. P., and T. W. Smith. 2011. *Health Psychology: Biopsychosocial Interactions*. New York: John Wiley & Sons, inc.
- Sari, Afriana Crusita. 2024. "Pentingnya Mobilisasi Dini Pada Pasien Post Operasi." 2024. https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/3334/pentingnya-mobilisasi-dini-pada-pasien-post-operasi.
- Smeltzer, S. C., & Bare, B. G. 2001. *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah*. 8th ed. Jakarta: EGC.
- Solehati, Tetti, and Yeni Rustina. 2015. "Benson Relaxation Technique in Reducing Pain Intensity in Women after Cesarean Section." *Anesthesiology and Pain Medicine* 5 (3). <https://doi.org/10.5812/aapm.22236v2>.
- Sriwahyunita, Neneng, and Elfira Sri Futriani. 2024. "Efektifitas Metode Eracs an Non Eracs Terhadap Penurunan Respon Nyeri Dan Mempercepat Mobilisasi Pada Sectio Caecarea." *Malahayati Nursing Journal* 6 (3): 975–85. <https://doi.org/10.33024/mnj.v6i3.11081>.
- Sungkar, Ali, and Ray Wagiu Basrowi. 2020. "Rising Trends and Indication of Caesarean Section in Indonesia." *World Nutrition Journal* 4 (S2): 1–7. <https://doi.org/10.25220/wnj.v04.s2.0001>.
- Suprpto. 2021. *Bahan Ajar: Perawatan Luka Modern Dan Pengkajian Fisik*. Kedua. Makasar: LP2M AKPER Sandi Karsa.
- Suraeda. 2020. "Dukungan Suami Dan Keluarga Terhadap Pemberian ASI Eksklusif Oleh Ibu Di Desa Sulilie Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
- Trisnawati, Reineldis Elsidianastika, Makrina Sedista Manggul, and Viviana Hamat. 2023. "Determinan Yang Berhubungan Dengan Kejadian Infeksi Luka Sectio Caesarea." *Quality: Jurnal Kesehatan* 17 (2): 149–56. <https://doi.org/10.36082/qjk.v17i2.1249>.
- WHO. 2021. "Caesarean Section Rates Continue to Rise, amid Growing Inequalities in Access." 2021.
- Wodajo, Samuel, Mehretu Belayneh, and Samson Gebremedhin. 2017. "Magnitude and Factors Associated With Post-Cesarean Surgical Site Infection at Hawassa University Teaching and Referral Hospital, Southern Ethiopia: A Cross-Sectional Study." *Ethiopian Journal of Health Sciences* 27 (3): 283–90. <https://doi.org/10.4314/ejhs.v27i3.10>.
- World Health Organization. 2015. "WHO Statement on Caesarean Section Rates." Geneva. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(80\)91104-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(80)91104-6).
- Zalukhu, Junimiserya, and Bina Melvia Girsang. 2023. "Kajian Faktor Perilaku Kesehatan Ibu Nifas Yang Mempengaruhi Kunjungan Masa Nifas Di

G. Glosarium

A

ADL: adalah singkatan dari Activity Daily Living, yaitu aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti mandi, mencuci dan menyisir rambut, menggosok gigi, mengganti baju, eliminasi : BAB dan BAK, makan dan minum, dll

AINS: adalah singkatan dari Anti Inflamasi Non Steroid, atau dalam bahasa Inggris *Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs* (NSAIDs) adalah kelompok obat yang umum digunakan untuk meredakan berbagai gejala, seperti nyeri, demam, dan peradangan.

AKI: adalah singkatan dari Angka Kematian Ibu, yaitu jumlah kematian perempuan akibat kehamilan atau dalam waktu 42 hari setelah melahirkan, per 100.000 kelahiran hidup.

APH: adalah singkatan dari Antepartum Haemorrhage, yaitu kondisi medis yang ditandai dengan perdarahan aktif atau pasif dari jalan lahir pada ibu hamil setelah usia kehamilan mencapai 24 minggu dan sebelum dimulainya persalinan.

C

CPD: adalah singkatan dari *Cephalopelvic Disproportion*, yaitu suatu kondisi ukuran atau bentuk panggul ibu yang terlalu sempit sehingga kepala janin tidak dapat melewati jalan lahir saat persalinan.

D

Discharge Planning: adalah suatu pendekatan interdisipliner meliputi pengkajian kebutuhan klien tentang perawatan kesehatan diluar rumah sakit, disertai dengan kerjasama dengan klien dan keluarga klien dalam mengembangkan rencana-rencana perawatan setelah perawatan di rumah sakit.

Dehiscence: adalah keadaan terbukanya lapisan-lapisan jaringan yang menyusun dinding luka, baik itu lapisan kulit, jaringan subkutan, maupun lapisan yang lebih dalam, akibat gagal dalam proses penyembuhan luka.

E

ERAS: adalah singkatan dari *Enhanced Recovery After Surgery*, yaitu sebuah pendekatan komprehensif yang bertujuan untuk mempercepat proses pemulihan pasien setelah operasi.

ERACS: adalah singkatan dari *Enhanced Recovery After Caesarean Section*, yaitu penerapan ERAS pada operasi caesar.

H

HDK: adalah singkatan dari Hipertensi dalam Kehamilan, yaitu suatu kondisi ibu hamil ditandai dengan peningkatan tekanan darah di atas 140/90 mmHg setelah usia kehamilan 20 minggu.

HIV: adalah singkatan dari *Human Immunodeficiency Virus*, yaitu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, dalam hal ini virus dapat menular dari ibu yang terinfeksi HIV kepada bayinya selama kehamilan, persalinan, atau menyusui.

I

ILO: adalah singkatan dari Infeksi luka operasi, yaitu kondisi luka insisi operasi terkontaminasi oleh bakteri, virus, atau jamur, dapat memperlambat proses penyembuhan luka dan dapat menyebabkan komplikasi.

IMD: adalah singkatan dari Inisiasi Menyusu Dini, yaitu proses meletakkan bayi baru lahir di dada ibunya (*skin to skin contact*) segera setelah kelahiran dengan tujuan agar bayi mencari puting susu ibunya dan mulai menyusui.

K

KB: adalah singkatan dari Keluarga Berencana, yaitu suatu upaya untuk merencanakan kehamilan dalam rangka menuju keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

P

PMR: adalah singkatan dari *Progressive Muscle Relaxation*, yaitu teknik relaksasi yang melibatkan menegangkan dan mengendurkan secara bergantian kelompok-kelompok otot di seluruh tubuh.

POGI: adalah singkatan dari Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia yaitu organisasi profesi yang menaungi para dokter spesialis kebidanan dan kandungan di Indonesia.

Postpartum blues: adalah munculnya perasaan sedih pada wanita di masa-masa awal setelah melahirkan.

R

ROM: adalah singkatan dari Range of Motion, yaitu batas pergerakan yang bisa dilakukan oleh sebuah sendi.

RUI: adalah singkatan dari *Rupture Uteri Imminent*, yaitu komplikasi obstetri yang serius dan dapat mengancam jiwa ibu dan janin, ditandai dengan penipisan progresif dinding uterus, terutama pada bekas luka operasi sebelumnya, berpotensi menyebabkan robekan spontan selama kehamilan atau persalinan.

S

Sectio caesarea atau biasa disebut operasi caesar atau *caesarean section*: adalah salah satu tindakan persalinan untuk mengeluarkan bayi melalui sayatan pada abdomen/ (laparotomi) dan uterus (histerotomi).

SOP: adalah singkatan dari Standar Operasional Prosedur, yaitu panduan tertulis yang berisi langkah-langkah yang harus diikuti secara sistematis, terstruktur dan menjadi acuan bagi perawat dalam melakukan tindakan keperawatan.

T

TFU: adalah singkatan dari Tinggi Fundus Uteri, yaitu pengukuran jarak antara simfisis pubis hingga fundus uteri untuk memantau proses involusi uteri.

V

VBAC: adalah singkatan dari *Vaginal Birth After Caesarean Section*, yaitu upaya untuk melahirkan secara normal (pervaginam) bagi ibu yang sebelumnya pernah melahirkan melalui operasi caesar.

W

WHO: adalah singkatan dari *World Health Organization*, yaitu Lembaga internasional yang ditunjuk oleh PBB untuk memimpin upaya global dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

CHAPTER 4

MENGELOLA KESEHATAN IBU DENGAN KOMPLIKASI GIZI PASCA PERSALINAN

Ns. Hesti Ratna Sari, M.Kep.

A. Pendahuluan/Prolog

Pada masa nifas terjadi perubahan fisiologis dan anatomis diantaranya yaitu uterus, lochea, vagina, perineum dan payudara, saat nifas juga memiliki beberapa kebutuhan dasar meliputi kebutuhan nutrisi, aktivitas, istirahat, perawatan payudara, perawatan vulva, dan eliminasi. Nutrisi merupakan zat yang diperlukan oleh tubuh untuk keperluan metabolismenya. Kebutuhan gizi pada masa nifas terutama bila menyusui akan meningkat 25%, karena berguna untuk proses kesembuhan karena sehabis melahirkan dan untuk memproduksi air susu yang cukup untuk menyehatkan bayi semua itu akan meningkat tiga kali dari kebutuhan biasa. Nutrisi yang di konsumsi harus bermutu tinggi, bergizi dan cukup kalori. Kalori bagus untuk proses metabolisme tubuh, kerja organ tubuh, proses pembentukan ASI.

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan masyarakat di suatu negara. AKI di Indonesia termasuk tinggi diantara Negara Association Of Southeast Asian Nation (ASEAN). Data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017, AKI di Indonesia masih tinggi sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup. Pemenuhan gizi ini sebagai upaya mencegah penyebab AKI. Penyebab AKI khususnya Ekplamsia dapat dicegah dengan mencukupi kebutuhan mikronutrien ibu. Untuk kehamilan yang optimal, ibu membutuhkan antioksidan penting seperti selenium, enzim Q10, fish oil, vitamin C dan vitamin E. mikronutrien ini merupakan asupan gizi dalam jumlah yang kecil, Sehingga kadang tidak hanya dipenuhi dengan bentuk makanan langsung, bisa jadi melalui suplemen makanan (Kutipan Lestari, 2023).

Angka Kematian Ibu (AKI) didunia (2019) yaitu sebanyak 303.000 jiwa. Kemudian Angka Kematian Ibu (AKI) di ASEAN yaitu sebesar 235 per 100.000 kelahiran hidup (ASEAN, 2020). Prevalensi angka kematian ibu (AKI) di Indonesia menempati posisi tertinggi di asia tenggara yaitu sebesar 307/100.000 kelahiran hidup. Penurunan AKI dan AKB merupakan salah satu target dari utama sustainable development goals (SGDs). Terdapat sembilan tujuan SGDs, dua diantaranya berkaitan dengan peningkatan kesehatan ibu, tujuan SDGs lebih dititik beratkan kepada kematian ibu terhadap kehamilan dan persalinan, dalam hal ini SDGs

memiliki target 70 per 100.000 kelahiran hidup untuk angka kematian ibu (Kutipan Lestari, 2023)

B. KEK dengan Pasca Persalinan

Kekurangan Energi Kronis (KEK) adalah keadaan status gizi seseorang buruk yang disebabkan karena kurangnya konsumsi pangan sumber energi yang mengandung zat gizi makronutrien yang diperlukan banyak oleh tubuh dan mikronutrien yang diperlukan sedikit oleh tubuh. (Kutipan Rizki,). Ibu Nifas yang teridentifikasi sebagai gizi kurang berdasarkan pengukuran LiLA ($<23,5$ cm) atau IMT ($<18,5$ kg/m²)

Upaya pemulihan kesehatan ibu nifas adalah dengan penyediaan makanan yang memadai, yakni ibu nifas harus banyak mengonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang, cukup protein, mineral, vitamin, serta makanan tambahan sebanyak 500 kalori perhari (pada enam bulan kedua 500 kkal/hari), karena selain berguna untuk produksi Air Susu Ibu (ASI) juga berfungsi sebagai proses perbaikan sel-sel tubuh yang telah rusak selama proses persalinan, mengingat pentingnya pemulihan kesehatan dan pembentukan ASI, maka perlu adanya pengawasan apakah ibu memperoleh makanan dengan kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan bagi pemulihan tubuhnya, juga pengetahuan tersendiri bagi ibu nifas tentang pentingnya makanan bergizi seimbang.

Kebutuhan gizi protein sangat penting, terutama protein hewani karena berfungsi untuk mempercepat proses penyembuhan, dan pemulihan serta untuk memperlancar proses produksi ASI. Untuk pertumbuhan sel sebagai pengganti jaringan yang rusak. Dengan mengonsumsi makanan protein baik itu nabati maupun hewani pada ibu nifas maka proses penyembuhan luka perineum akan semakin cepat sembuh dan kering.

Ibu nifas sebaiknya mengonsumsi minimal telur, tahu, tempe dan daging atau ikan bila ada. Kecuali ibu nifas alergi dengan ikan laut tertentu atau alergi telur sejak hamil, maka sumber protein yang menyebabkan alergi tersebut dihindari. Bila alergi jenis protein tertentu misal ikan laut, ibu nifas boleh mencari ganti sumber protein dari daging ternak dan unggas juga dari protein nabati seperti kacang-kacangan. Asupan kalori yang dibutuhkan per-hari 500 kalori dan dapat ditingkatkan sampai 2700 kalori.

Asupan cairan perhari ditingkatkan sampai 3000 ml dengan 12 asupan susu 1000 ml. Suplemen zat besi dapat diberikan kepada ibu nifas selama 4 minggu pertama setelah kelahiran. Untuk mengembalikan alat-alat kandungan ke keadaan sebelum hamil maka kebutuhan energi ibu dalam sehari adalah 2800 kalori dan protein 64 gr. Semua itu akan meningkat 3 kali dari kebutuhan biasa.

Kebutuhan energi ibu nifas/ibu menyusui sebagai kebutuhan tambahan kalori pada 6 bulan pertama kira-kira 700 kkal/hari dan ibu menyusui bayi yang berumur 2 tahun rata-rata sebesar 400 kkal/hari Ibu nifas yang menjalani proses persalinan secara spontan atau normal tidak ada pantangan makanan, setelah proses persalinan selesai ibu boleh makan dan minum seperti biasanya, akan tetapi ibu nifas harus memperhatikan jumlah kalori dan proteinnya (Heryanto, Herwandar and Yanti Rohidin, 2021). Sebagian besar ibu nifas masih banyak yang belum mengetahui tentang kebutuhan nutrisi selama masa nifas, serta manfaat dan kerugian jika kebutuhan nutrisinya tidak terpenuhi. Masih ada ibu nifas yang tidak mengetahui bahwa kebutuhan cairan yang harus diminum selama masa nifas/menyusui yaitu 8 gelas/hari. (Rini. 2024)

C. Program Unicef Untuk Gizi Ibu Nifas

1. Intervensi Asam Folat dan zat Besi

Suplementasi tunggal zat besi, atau dikombinasikan dengan suplementasi asam folat, direkomendasikan untuk ibu nifas selama 6-12 minggu setelah melahirkan, di daerah yang memiliki masalah anemia pada kehamilan merupakan masalah kesehatan masyarakat (>20%)

2. Penanggulangan Cacingan

Pemberian obat cacing secara rutin dengan albendazole atau mebendazole) direkomendasikan untuk ibu nifas dan ibu menyusui, di daerah yang endemis cacing penyebab penyakit cacingan dan di mana anemia merupakan masalah kesehatan masyarakat yang serius.

3. Lainnya

Suplementasi vitamin A pada ibu nifas tidak direkomendasikan untuk mencegah morbiditas dan mortalitas ibu dan bayi.

- a. Kebijakan, undang-undang, dan pedoman untuk meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan
- b. Pendidikan gizi dan konseling terkait makanan yang bergizi dan aman, aktivitas fisik dan istirahat, penambahan berat badan yang sesuai, dan suplementasi mikronutrien.
- c. penilaian antropometri (tinggi badan, berat badan, IMT atau LILA), konseling dan rujukan jika diperlukan
- d. Pemantauan penambahan berat badan selama
- e. kehamilan dan pascapersalinan
- f. Skrining anemia dan pengobatan.
- g. makanan bergizi

D. Mengelola Gizi Ibu Pasca Persalinan

1. Jenis gizi

a. Kandungan Zat Besi

Pada wanita menyusui berkisar antara 10 hingga 30 mg per hari , tergantung padaketersediaan hayati zat besi dari makanan. Penyerapan zat besi dipengaruhi oleh jenis zat besi dalam makanan. Zat besi non-heme adalah bentuk utama zat besi dalam makanan dan hadir dalam banyak sayuran. Penyerapannya dipengaruhi oleh status zat besi seseorang dan beberapa faktor di dalamnya makanan, termasuk fitat, senyawa fenolik pengikat zat besi, dan kalsium, yang menurunkan penyerapan, dan asam askorbat, yang memfasilitasi penyerapan (26). Sebaliknya, penyerapan zat besi heme, yang hanya terdapat pada daging, unggas dan ikan, tidak terlalu dipengaruhi oleh faktor makanan dan diatur oleh status zat besi seseorang dan tubuh jumlah total zat besi heme yang dikonsumsi. Suplementasi zat besi terbukti efektif untuk meningkatkan konsentrasi hemoglobin pada wanita hamil dan tidak hamil dan suplementasi zat besi telah direkomendasikan sebagai pendekatan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan hasil kesehatan ibu dan bayi di kelompok umur yang berbeda . Pada beberapa wanita, konsumsi suplemen zat besi secara oral telah dikaitkan dengan penyakit ini efek samping yang mempengaruhi sistem pencernaan, seperti diare, sembelit, mual dan muntah . Gejala-gejala ini umumnya meningkat keparahannya seiring dengan meningkatnya jumlah unsur besi dan ketika suplemen diminum saat perut kosong. Peningkatan insiden efek samping gastrointestinal pada orang dewasa menerima 25–222 mg unsur besi setiap hari sebagai besi sulfat, senyawa besi yang paling umum diresepkan, dibandingkan dengan mereka yang menerima plasebo, telah dilaporkan, tetapi hubungan antara gastrointestinal efek samping suplementasi dan dosis zat besi masih belum jelas Suplementasi zat besi oral, baik sendiri atau dalam kombinasi dengan asam folat, dapat diberikan pada masa nifaswanita selama 6-12 minggu setelah melahirkan untuk mengurangi risiko anemia di tempat gestasional anemia (WHO.2016)

b. Pemberian Suplement asam Folat

Menurut Permenkes RI No 28 tahun 2019

Tabel 4.1 Pemberian Suplemen Asam Folat

Usia /tahun	Kebutuhan (g)	Bulan
19-29	500	Enam bulan pertama
30-49	500	Enam bulan kedua

Kebutuhan 500 mcg asam folat, dan ini bisa dipenuhi dari asupan makanan dan minuman (jus buah dan jus sayur). Sumber asupan asam folat bisa didapatkan dari sayur-sayuran seperti bayam, brokoli, rumput laut, kecambah, kacang-kacangan (kacang kedelai, kacang hijau, kacang merah dan padi-padian), roti diperkaya gandum, buah jeruk, alpukat (avokad), daging merah, dan hati ayam.

c. Karbohidrat

Menurut permenkes RI Nomor 28 Tahun 2019

Tabel 4.2 Pemberian Karbohidrat

Usia /tahun	Kebutuhan (g)	Bulan
19-29	405	Enam bulan pertama
30-49	395	Enam bulan kedua

Makanan yang mengandung karbohidrat kompleks, seperti gandum, kacang-kacangan, sayur, dan buah, merupakan pilihan yang baik untuk mencukupi kebutuhan energi selama masa menyusui. Hal ini karena karbohidrat kompleks dicerna lebih lambat oleh tubuh daripada karbohidrat sederhana, sehingga dapat memasok energi lebih lama dan menjaga gula darah tetap stabil.

d. Kalsium

Menurut permenkes RI Nomor 28 Tahun 2019

Tabel 4.3 Pemberian Kalsium

Usia /tahun	Kebutuhan (g)	Bulan
19-29	1200	Enam bulan pertama
30-49	1200	Enam bulan kedua

Ibu menyusui perlu memenuhi asupan protein yang dibutuhkan oleh bayi guna membentuk jaringan saraf dan otaknya. Menurut penelitian, asupan protein yang cukup dari ASI berperan penting dalam pertumbuhan otak bayi yang akan mendukung kecerdasannya kelak. Beberapa jenis makanan yang merupakan sumber protein adalah telur, daging tanpa lemak, ikan, produk olahan susu, kacang-kacangan atau biji-bijian, dan gandum utuh.

e. Lemak sehat

Menurut permenkes RI Nomor 28 Tahun 2019

Tabel 4.4 Pemberian lemak Sehat

Usia /tahun	Lemak total(g)	Omega 3(g)	Omega (g)	Bulan
19-29	67,2	1,3	14	Enam bulan pertama
30-49	62.2	1,3	14	Enam bulan kedua

Ibu menyusui dianjurkan menghindari lemak jahat, seperti lemak jenuh atau lemak trans yang dapat ditemukan pada mentega, minyak kelapa sawit, krim, serta daging dan susu berlemak (whole milk). mengonsumsi makanan dengan lemak sehat yang mengandung omega-3. Lemak sehat tersebut bisa didapatkan dengan mengonsumsi ikan laut, alpukat, kacang-kacangan, biji-bijian, serta minyak zaitun. Ikan laut sering disarankan untuk dikonsumsi ibu menyusui karena mengandung protein tinggi serta omega-3, yang terdiri dari DHA dan EPA. Nutrisi ini penting untuk perkembangan mata dan otak bayi, serta menunjang tumbuh kembangnya agar kelak ia menjadi anak yang cerdas.

f. Protein

Menurut permenkes RI Nomor 28 Tahun 2019

Tabel 4.5 Pemberian Protein

Usia /tahun	Kebutuhan (g)	Bulan
19-29	80	Enam bulan pertama
30-49	75	Enam bulan kedua

asupan protein yang cukup dari ASI berperan penting dalam pertumbuhan otak bayi yang akan mendukung kecerdasannya kelak. Beberapa jenis makanan yang merupakan sumber protein adalah telur, daging tanpa lemak, ikan, produk olahan susu, kacang-kacangan atau biji-bijian, dan gandum utuh.

2. Kebutuhan Energi

Menurut permenkes RI Nomor 28 Tahun 2019

Tabel 4.6 Kebutuhan Energi

Usia /tahun	Kebutuhan (kkal)	Bulan
19-29	2580	Enam bulan pertama
30-49	2550	Enam bulan kedua

Energi dibutuhkan makhluk hidup dalam setiap siklus kehidupan mulai dari periode kehamilan, menyusui, masa bayi, masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa dan masa lansia. Energi diperoleh melalui asupan makanan sehari-hari utamanya dari bahan makanan sumber karbohidrat, protein dan lemak. Kebutuhan energi didefinisikan sebagai angka konsumsi energi individu yang diperoleh melalui asupan makanan dan ditujukan untuk menutupi pengeluaran energi yang berasal dari metabolisme basal, aktivitas fisik dan specific dynamic action. Metabolisme basal merupakan energi yang dibutuhkan tubuh untuk melakukan aktivitas vital diantaranya memompa jantung, mencerna makanan, bernapas, memperbaiki sel tubuh serta membuang racun dalam tubuh. Metabolism basal setiap inidividu berbeda-beda, berdasarkan jenis kelamin, umur, berat badan dan tinggi badan

3. Kebutuhan Air

Menurut permenkes RI Nomor 28 Tahun 2019

Tabel 4.7 Kebutuhan Air

Usia/tahun	Kebutuhan (ml)	Bulan
19-29	3150	Enam bulan pertama
30-49	3000	Enam bulan kedua

Air merupakan komponen yang sangat penting yang dibutuhkan oleh tubuh untuk proses metabolisme. Air berfungsi sebagai zat pelarut hasil pencernaan. Selain itu air juga berfungsi sebagai pengatur panas tubuh melalui proses respirasi. Tubuh manusia dewasa mengandung 70% air sehingga merupakan komponen terbesar di dalam struktur tubuh manusia. Air bersumber dari air alam yang telah tersedia dan dapat dimanfaatkan secara langsung, selain itu air juga banyak terdapat di hampir semua makanan. Buah dan sayuran adalah bahan makanan yang banyak mengandung air hingga 95%

4. Pola makan

Pola makan dengan porsi kecil tapi sering. Pola makan ini dapat membuat tubuh lebih berenergi. Setelah melahirkan adalah makan dengan porsi kecil tapi sering. Kalau ibu terbiasa makan 3 kali sehari dengan porsi besar, ubahlah pola tersebut. Misalnya dengan mengatur porsi makan lebih sedikit, tapi 5 kali dalam satu hari.

5. Istirahat dan Tidur

- Istirahat adalah suatu keadaan dimana kegiatan jasmaniah menurun yang berakibat badan menjadi lebih segar. Sedangkan tidur adalah suatu keadaan relative tanpa sadar yang penuh ketenangan tanpa kegiatan yang merupakan urutan siklus yang berulang-ulang dan masing-masing menyatakan fase kegiatan otak dan badaniah yang kedua (Kutipan Aryamani, 2023)
- Tidur adalah proses yang berfungsi untuk memulihkan energi dan kesejahteraan (Potter & Perry, 2010). Tidur adalah proses yang diperlukan manusia untuk pembentukan sel-sel tubuh yang baru, perbaikan sel-sel tubuh yang rusak (natural healing mechanism), memberi waktu organ tubuh untuk istirahat maupun untuk menjaga keseimbangan metabolisme dan biokimia tubuh. Karena fungsi tidur adalah melindungi tubuh, konservasi energi, restorasi otak, homeostasis, meningkatkan fungsi immunitas, dan regulasi suhu tubuh (Kutipan Fatmawati, 2019)
- Istirahat dan tidur merupakan kebutuhan dasar yang mutlak harus dipenuhi oleh semua orang. Istirahat dan tidur yang cukup, tubuh baru dapat berfungsi secara optimal. Istirahat dan tidur sendiri memiliki makna yang berbeda pada setiap individu. Secara umum, istirahat berarti suatu keadaan tenang, relaks,

tanpa tekanan emosional dan bebas dari perasaan gelisah. Beristirahat bukan berarti tidak melakukan aktivitas sama sekali, terkadang berjalan-jalan di taman juga bisa dikatakan sebagai suatu bentuk istirahat(Kutipan Aryamani,2023)

Kebutuhan istirahat orang dewasa sesuai dengan kondisinya normal 30 sampai 1,5 jam sehari dan kebutuhan tidur seorang dewasa Normal Nya waktu Tidur Usia 18-40 tahun: orang dewasa membutuhkan waktu tidur 7-8 jam setiap hari.

6. Vitamin

Menurut permenkes RI Nomor 28 Tahun 2019

Tabel 4.8 Pemberian Vitamin

Usia	Vit A (RE)	Vit D (mcg)	Vit E (mcg)	Vit K (mcg)	Vit B1 (mg)	Vit B2 (mg)	Vit B3 (mg)	Vit B5 (mg)	Vit B6 (mg)	Vit B12 (mcg)	Biotin (mcg)	Kolin (mg)	Vit C (mg)	Bulan
19-29	950	15	19	55	01.05	01.06	17	07.00	01.09	05.00	35	550	115	6 bulan pertama
30-49	950	15	19	55	01.05	01.06	17	07.00	01.09	05.00	35	550	115	6 bulan kedua

Vitamin adalah sekelompok senyawa organik berbobot molekul kecil yang memiliki fungsivital dalam metabolisme organisme. Dipandang dari sisienzimologi (ilmu tentang enzim), vitamin adalah kofaktor dalam reaksi kimia yang dikatalisasi oleh enzim. Terdapat 13 jenis vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh untuk dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Vitamin tersebut antara lain vitamin A, C, D, E, K, dan B (tiamin, riboflavin, niasin, asam pantotenat, biotin, vitamin B6, vitamin B12, dan folat). Walau memiliki peranan yang sangat penting, tubuh hanya dapat memproduksi vitamin D dan vitamin K dalam bentuk provitamin yang tidak aktif.Oleh karena itu,tubuh memerlukan asupan vitamin yang berasal dari makanan yang kita konsumsi.Buah-buahan dan sayuran terkenal memiliki kandungan vitamin yang tinggidan haltersebut sangatlah baik untuk tubuh. Asupan vitamin lain dapat diperoleh melalui suplemen makanan. Berbeda dengan vitamin yang larut dalam lemak, jenis vitamin larut dalam air hanya dapat disimpan dalam jumlah sedikit dan biasanya akan segera hilang bersama aliranmakanan. Saat suatu bahan pangan dicerna oleh tubuh, vitamin yang terlepas akan masuk ke dalam aliran darah dan beredar ke seluruh bagian tubuh. Apabila tidak dibutuhkan, vitamin iniakan segera dibuang tubuh bersama urin. Oleh karena hal inilah, tubuh membutuhkan asupan vitamin larut air secara terus-menerus

7. Serat

Menurut permenkes RI Nomor 28 Tahun 2019

Usia /tahun	Kebutuhan (g)	Bulan
19-29	37	Enam bulan pertama
30-49	36	Enam bulan kedua

Serat adalah suatu polisakarida dengan sepuluh atau lebih unit monomer sakarida yang tidak dapat dihidrolisis oleh enzim-enzim di saluran pencernaan manusia. Pada dasarnya, selain pada tumbuhan, serat dapat ditemukan pada jamur dan alga. Namun, sejauh ini, kajian ilmiah lebih banyak dilakukan terhadap serat-serat pangan yang bersumber dari tumbuhan (Barber et al., 2020). Serat juga dapat membantu proses pencernaan, penyerapan nutrisi dan sekresi endokrin dalam usus halus kandungan serat banyak terdapat dalam umbi dan rimpang.

E. Hambatan dalam Mengakses Pelayanan Kesehatan

Hambatan yang terjadi dalam pemenuhan kebutuhan gizi untuk ibu nifas adalah faktor umur, pendidikan, pendapatan, pekerjaan, pengetahuan, sosial budaya dan ekonomi. Kebutuhan nutrisi bukan hanya memperhatikan jumlah yang dikonsumsi, melainkan juga memperhatikan zat gizi yang harus dipenuhi diantaranya karbohidrat, protein, lemak dan vitamin. Pantang makanan yang dilakukan oleh ibu nifas dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya, faktor pengetahuan yang kurang tentang manfaat makanan tinggi dapat mempengaruhi pola konsumsi makanan. Hal tersebut dapat disebabkan oleh kurangnya informasi sehingga dapat terjadi kesalahan dalam memahami kebutuhan gizi. Faktor pendidikan, semakin tinggi pendidikan yang dimiliki seseorang maka semakin mudah pula menangkap dan mencerna suatu informasi yang diberikan oleh faktor ekonomi dapat mempengaruhi perubahan status gizi karena makanan bergizi membutuhkan pendanaan yang tidak sedikit. Faktor pekerjaan, dengan bekerja tingkat interaksi dengan orang lain akan lebih tinggi sehingga secara tidak langsung dapat bertukar pengalaman maupun pengetahuan dalam memilih makanan. Jika seseorang tidak bekerja maka semakin jarang untuk berinteraksi dan bertukar pengalaman maupun pengetahuan tentang memilih makanan yang baik bagi tubuhnya. Faktor usia, semakin matang usia seorang ibu nifas akan semakin mudah dalam menerima informasi mengenai kebutuhan nutrisinya, sebaliknya jika umur dan tingkat kematangannya dalam berfikir logis belum cukup maka akan sulit dalam menerima informasi mengenai gizi. Faktor budaya, adanya kebiasaan yang merugikan atau pantangan terhadap makanan tertentu juga dapat mempengaruhi status gizi, misalnya, di beberapa daerah, terdapat larangan makan pisang dan pepaya.

Padahal, makanan tersebut merupakan sumber vitamin yang sangat baik dan adajuga larangan makan ikan karena ikan di anggap dapat menyebabkan darah nifas berbau padahal ikan merupakan sumber protein yang sangat baik bagi ibu nifas(Mahayati

F. Simpulan

Pengelolaan gizi pasca persalinan adalah Upaya pemulihan kesehatan ibu nifas dengan penyediaan makanan yang memadai, yakni ibu nifas harus banyak mengkonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang, cukup protein, mineral, vitamin, serta makanan tambahan sebanyak 500 kalori perhari (pada enam bulan kedua 500 kkal/hari), karena selain berguna untuk produksi Air Susu Ibu (ASI) juga berfungsi sebagai proses perbaikan sel-sel tubuh yang telah rusak selama proses persalinan.

G. Referensi

- Kevin. 2024, Nutrisi Penting dari Makanan Ibu Menyusui agar Bayi Cerdas
<https://www.alodokter.com/nutrisi-penting-dari-makanan-ibu-menyusui-agar-bayi-cerdas>
- Stanford Children Health. Diakses pada 2021. The New Mother: Taking Care of Yourself After Birth.
- Myhealth.gov. Diakses pada 2021. Postnatal Diet.
- Arismawati.FD, DKK, 2020, Prinsip Ilmu Gizi, CV Media Sains Indonesia, Jawa Barat, ISBN 978-623-362-698-9
- Fatmawati R, NurHidayat, Gambaran Pola tidur ibu Nifas,INFOKes, VOL 9 NO 2, September 2019, ISSN : 2086 – 2628
- Abselian.PU, DKK, 2021 Dasar dasar Fisiologi Untuk Praktik Keperawatan,EurekaMedia Aksara; Jawa Tengah ISBN 978-623-151-746-3
- Putri.E.S,Ramie, A,Maria, 2022, pemenuhan kebutuhan Nutrisi pada ibu Nifas berdasarkan sosial Budaya, Journal of Intan Nursing, Vol. 1, No. 1, Maret 2022, Vol. 1, <https://doi.org/10.54004/join.v1i2.xx>
- Rahayu.NA, Purnomo.W, 2024. Faktor-faktor yang berhubungan dengan kurag energi Kronis pada wanita hamil di Inonesia , Jurnal Promotif Preventif,vol. 7, No. 3 Juni 2024, Hal. 562–568, p-ISSN: 2622 – 6014; e-ISSN: 2745 – 8644
- Jumain, Dewi,TR.S,,2021, Buku Ajar Farmakologi II, Unit Penelitian Politeknik Makasar; Makasar ISBN 978-623-5648-11-8

Harna, DKK,2023, Kekurangan Energi Kronik pada Ibu Hamil, Penamuda media; Yogyakarta ISBN978-623-09-7038-2

Permenkes No 28 tahun 2019

Kemenkes, 2024, laporan Akuntabilitas Kinerja Instalasi Pemerintah (Lakip) Direktorat Gizi Kesehatan Ibu Dan anak , Kemenkes, Jakarta

UNICEF,2023,Gizi Ibu di Indonesia Analisi Lanskap dan Rekomendasi, UNICEF

H. Glosarium

WUS = Wanita Usia Subur

CHAPTER 5

PENDIDIKAN DAN DUKUNGAN UNTUK IBU YANG MENGALAMI GANGGUAN KESEHATAN MENTAL

Nurmah Rachman, S.Kep., Ns., M.Med.Ed.

A. Pendahuluan

Kesehatan mental adalah kondisi kesejahteraan psikologis yang memengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak. Kesehatan mental yang baik penting untuk kemampuan seseorang dalam mengatasi stres, menjalani hubungan sosial yang sehat, serta membuat keputusan yang tepat dalam kehidupan sehari-hari. Namun, gangguan kesehatan mental dapat terjadi pada siapa saja, termasuk ibu yang baru saja melahirkan. Periode postpartum, atau pasca-persalinan, merupakan waktu yang penuh dengan perubahan fisik dan emosional yang signifikan bagi seorang wanita. Meskipun proses kelahiran adalah pengalaman yang membahagiakan, banyak ibu yang juga mengalami tantangan emosional yang besar.

Kesehatan mental ibu setelah melahirkan, dipengaruhi oleh perubahan hormon estrogen dan progesteron yang berperan selama kehamilan. Kedua hormon ini diproduksi dalam jumlah besar oleh plasenta, tetapi setelah bayi lahir kedua hormon ini terjadi penurunan. Perubahan hormon ini dapat mempengaruhi suasana hati dan emosi ibu, hal ini dapat meningkatkan risiko gangguan mental seperti: depresi postpartum (*baby blues*) atau bahkan depresi. Hormon estrogen berperan dalam menjaga kehamilan, merangsang pertumbuhan dan pengembangan organ reproduksi, serta meningkatkan aliran darah rahim. Estrogen juga mempengaruhi suasana hati, energi dan kecenderungan emosional ibu. Sedangkan hormon progesteron berfungsi untuk mengurangi kontraksi rahim selama kehamilan, mendukung produksi ASI dan stabilitas hormon (Teaford, 2015)

Penurunan kadar estrogen dapat mempengaruhi kadar serotonin yaitu neurotransmitter yang berperan dalam mengatur suasana hati. Hormon estrogen berfungsi untuk meningkatkan produksi serotonin di otak, sehingga ketika estrogen menurun, ibu bisa merasa lebih cemas atau tertekan. Ada juga hormon lain yang berperan penting yaitu prolactin, prolactin adalah hormon yang merangsang produksi ASI dan juga berperan dalam pengaturan *mood* dan *stress*. Prolactin juga dapat menyebabkan perasaan cemas atau depresi pada ibu postpartum, terutama jika tingkat stress atau tekanan meningkat.

Stress atau tekanan meningkat ketika ibu merasa lelah akibat tidur yang terganggu, menyusui atau merawat bayi yang membutuhkan perhatian sepanjang waktu. Kelelahan dapat mempengaruhi kemampuan ibu untuk mengatasi stress dan dapat memicu perasaan cemas atau tertekan. Seringkali ibu setelah melahirkan merasa cemas mengenai peran baru mereka sebagai ibu. Banyak ibu yang merasa terisolasi secara social setelah melahirkan, baik karena jarak dengan keluarga atau teman, maupun karena tidak ada dukungan sosial sehingga ibu merasa cemas. Selain itu jika ibu mengalami komplikasi setelah melahirkan seperti: section caesarea (SC) maupun penyakit lain. Dapat menyebabkan trauma fisik dan emosional((Shin*, 2022).

Jika ibu postpartum tidak mendapat perhatian yang cukup, cara ibu merawat diri sendiri, berinteraksi dengan bayi dan menjalani peran sebagai ibu. Maka Kesehatan ibu akan mempengaruhi hubungan ibu dengan bayi. Misalnya ibu mungkin merasa tidak termotivasi untuk memberikan makan bayi, menjaga kebersihan, atau memberi perhatian yang cukup pada perkembangan bayi. Dukungan dari pasangan, keluarga, teman, atau kelompok pendukung ibu dapat membantu mengurangi perasaan terisolasi dan memberikan rasa aman.

Profesional kesehatan bisa membantu mengidentifikasi gejala depresi atau gangguan kecemasan dan memberikan dukungan serta pengobatan yang tepat. Mengatur waktu untuk beristirahat dan merawat diri sendiri sangat penting bagi ibu postpartum. Mengambil waktu untuk tidur yang cukup, melakukan aktivitas yang menyenangkan atau hanya beristirahat dari rutinitas bisa membantu meringankan stress. Melakukan kegiatan fisik ringan, seperti berjalan kaki atau yoga, serta praktik relaksasi seperti meditasi atau pernapasan dalam dapat membantu mengurangi stress dan meningkatkan kesejahteraan mental((itri Ariyanti Abidin1, 2022)

Kesehatan mental ibu postpartum adalah isu yang semakin mendapat perhatian dikalangan peneliti dan tenaga medis, terutama karena dampaknya yang luas terhadap kesejahteraan ibu dan perkembangan anak. Studi-studi yang menunjukkan bahwa gangguan Kesehatan mental pada ibu postpartum merupakan kondisi yang cukup umum dan memerlukan penanganan yang serius. Menurut berbagai penelitian sekitar 10 hingga 20 % ibu yang baru melahirkan mengalami gangguan kesehatan mental, seperti depresi postpartum, kecemasan, dan gangguan stress pasca trauma Chung et al., 2011; Stewart et al., 2014). Kondisi ini tidak hanya memengaruhi kesehatan ibu, tetapi juga dapat berdampak negatif pada hubungan ibu-anak, yang berpotensi mempengaruhi perkembangan bayi dan dinamika keluarga.

Depresi Postpartum (DPP) adalah salah satu gangguan mental yang paling umum terjadi pada ibu pasca-partum. Berdasarkan data dari *American Psychological*

Association, prevalensi DPP berkisar antara 10% hingga 15% di negara-negara maju, meskipun di beberapa negara berkembang angka ini bisa lebih tinggi. Penelitian oleh *Gavin et al. (2005)* menyatakan bahwa faktor-faktor yang berkontribusi terhadap depresi postpartum meliputi perubahan hormonal, stres psikososial, kelelahan fisik, dan kurangnya dukungan sosial. Hormon yang berfluktuasi setelah persalinan, seperti penurunan estrogen dan progesteron, dapat mempengaruhi suasana hati dan kestabilan emosional ibu.

Selain Depresi Postpartum, ibu postpartum juga dapat mengalami gangguan kecemasan yang sering kali saling berhubungan dengan depresi. Penelitian yang dilakukan oleh *Goodman dan Tyer-Viola (2010)* menunjukkan bahwa sekitar 10-15% ibu postpartum mengalami kecemasan yang signifikan, yang sering kali berhubungan dengan ketakutan terhadap kemampuan merawat bayi atau kecemasan mengenai kesejahteraan bayi. Gangguan kesehatan mental pada ibu tidak hanya berdampak pada kesejahteraan ibu itu sendiri, tetapi juga dapat memengaruhi perkembangan anak. Penelitian yang dilakukan oleh *Stewart et al. (2014)* menemukan bahwa ibu yang mengalami depresi postpartum memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk mengalami kesulitan dalam membentuk ikatan emosional yang sehat dengan bayinya.

B. Strategi Pencegahan Dan Intervensi

Penanganan gangguan kesehatan mental ibu postpartum dapat dilakukan melalui berbagai intervensi yang berbasis bukti (*evidence-based practice*), seperti terapi perilaku kognitif (*Cognitif Behavior Therapy*), konseling, serta dukungan kelompok atau individu. *Sockol et al. (2013)* menunjukkan bahwa *Cognitif Behavior Therapy* efektif dalam mengurangi gejala depresi postpartum, dengan memberikan alat untuk mengelola stres dan pola pikir negatif. Selain itu, pendekatan berbasis *mindfulness* juga telah terbukti dapat membantu mengurangi kecemasan dan stres pada ibu postpartum (Bennett et al., 2013).

Pendekatan pencegahan melalui pendidikan tentang kesehatan mental juga memiliki peran penting. *Shin et al. (2014)* menekankan bahwa pendidikan kepada ibu dan keluarga mengenai tanda-tanda gangguan mental postpartum dapat meningkatkan deteksi dini, memungkinkan intervensi yang lebih cepat dan mengurangi dampak jangka panjang dari gangguan mental. Contoh kasus, seorang ibu bernama Yani, berusia 30 tahun, melahirkan anak pertama secara normal. Setelah beberapa minggu, Yani merasa sangat cemas dan tidak dapat tidur. Dia merasa sangat lelah meskipun sudah tidur beberapa jam, dan mulai merasa bahwa dirinya bukan ibu yang baik. Ia merasa bersalah karena tidak bisa merawat bayinya dengan baik dan merasa terisolasi meski dikelilingi keluarga. Ibu Yani didiagnosis

dengan depresi postpartum setelah berkonsultasi dengan seorang profesional kesehatan mental.

World Health Organization (WHO) menyarankan berbagai tindakan untuk mencegah dan mengelola gangguan mental pada ibu postpartum. Pencegahan yang disarankan melibatkan pendekatan berbasis bukti dan keterlibatan berbagai pihak, baik tenaga medis, keluarga, maupun masyarakat. Berikut adalah beberapa tindakan pencegahan yang dapat dilakukan. Penyuluhan kepada ibu hamil dan keluarga mengenai kesehatan mental sangat penting untuk mencegah gangguan mental postpartum. WHO menyarankan agar ibu dan keluarga diberikan informasi yang memadai tentang tanda-tanda gangguan mental postpartum dan cara-cara untuk menghadapinya. Hal ini dapat mengurangi stigma terhadap gangguan mental dan mendorong ibu untuk mencari bantuan jika mengalami gejala-gejala yang tidak biasa.

Contoh Tindakan Pencegahan: Diadakan sesi edukasi selama kunjungan antenatal untuk memberikan informasi tentang perasaan yang umum setelah melahirkan, perbedaan antara *baby blues* dan depresi postpartum, serta cara-cara untuk mengurangi stres dan kecemasan. Informasi ini juga bisa disampaikan melalui brosur atau materi digital yang bisa diakses oleh ibu dan keluarganya

Cognitive Behavioral Therapy (CBT) adalah terapi psikologis yang berbasis pada teori bahwa cara berpikir (kognisi) dapat memengaruhi perasaan dan perilaku. CBT membantu ibu untuk mengidentifikasi dan mengubah pola pikir negatif atau distorsi kognitif yang dapat memperburuk perasaan cemas atau depresi. Terapi ini juga mengajarkan keterampilan untuk mengatasi stres dan meningkatkan kualitas hidup. Sebuah penelitian meta-analisis oleh *Sockol et al. (2013)* menunjukkan bahwa CBT efektif dalam mengurangi gejala depresi dan kecemasan pada ibu postpartum. Penelitian ini menunjukkan bahwa CBT tidak hanya membantu ibu mengatasi gejala mental, tetapi juga memperbaiki kualitas hubungan ibu-anak dan meningkatkan perasaan kontrol dan optimisme.

Menurut *Dennis & Dowswell (2013)* dalam penelitian mereka juga menunjukkan bahwa CBT sangat efektif dalam mengurangi gangguan mental pada ibu yang mengalami depresi postpartum. Dengan mengadakan sesi CBT individual atau kelompok untuk ibu yang mengalami depresi atau kecemasan postpartum. Terapi ini bisa dilakukan di rumah sakit, puskesmas, atau melalui platform daring untuk mempermudah akses ibu.

Dukungan Sosial dan Terapi Kelompok, yang diberikan oleh pasangan, keluarga, teman, atau kelompok ibu lainnya dapat mengurangi perasaan kesepian dan meningkatkan kesejahteraan emosional. Terapi kelompok, di mana ibu postpartum dapat berbagi pengalaman dan mendapatkan dukungan dari sesama

ibu, terbukti efektif dalam mengurangi gejala depresi dan kecemasan. Hasil penelitian oleh *Leahy-Warren et al. (2011)* menunjukkan bahwa dukungan sosial yang kuat dapat memperbaiki kesehatan mental ibu dan mengurangi gejala depresi postpartum. Terapi kelompok juga dapat meningkatkan keterampilan ibu dalam merawat bayi dan mengurangi perasaan terisolasi.

Selain itu *Dennis et al. (2013)* menemukan bahwa program dukungan kelompok yang melibatkan ibu-ibu lainnya dapat meningkatkan perasaan memiliki komunitas dan mengurangi kecemasan dan depresi. Menyediakan kelompok dukungan ibu, di mana ibu postpartum dapat berbagi perasaan, pengalaman, dan solusi terhadap tantangan yang dihadapi. Kelompok ini bisa dipandu oleh tenaga kesehatan atau konselor berlisensi dan dapat diselenggarakan secara tatap muka maupun daring.

Mindfulness-Based Interventions (MBI) melibatkan teknik meditasi dan kesadaran diri untuk membantu ibu menjadi lebih fokus pada momen sekarang dan mengurangi perasaan stres dan cemas. Intervensi ini melibatkan latihan kesadaran napas, meditasi, dan latihan relaksasi untuk membantu ibu mengelola stres. Hasil penelitian oleh *Bennett et al. (2013)* menunjukkan bahwa MBI, termasuk latihan mindfulness, terbukti efektif dalam mengurangi kecemasan, depresi, dan stres pada ibu postpartum. Teknik mindfulness dapat membantu ibu merasa lebih tenang, mengurangi pikiran negatif, dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan.

Menurut *Segal et al. (2018)* juga menemukan bahwa MBI dapat meningkatkan kualitas tidur dan mengurangi gejala depresi pada ibu postpartum. Memberikan kelas *mindfulness* untuk ibu postpartum yang berfokus pada teknik pernapasan dalam dan latihan meditasi sederhana. Kelas ini dapat dilakukan secara tatap muka atau daring dengan instruktur terlatih.

Intervensi Psikososial Berbasis Komunitas, mencakup pemberdayaan ibu untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat sekitar mereka, termasuk keluarga, teman, dan kelompok sosial. Program ini bertujuan untuk mengurangi isolasi sosial ibu dan membangun jaringan dukungan yang kuat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh *Dennis et al. (2013)* menunjukkan bahwa program berbasis komunitas yang melibatkan pendidikan dan dukungan sosial dapat mengurangi gejala depresi dan meningkatkan kesehatan mental ibu. Program ini juga membantu ibu mengembangkan keterampilan pengasuhan yang lebih baik dan merasa lebih percaya diri dalam merawat anak.

Penelitian lain yang dilakukan oleh *Shin et al. (2014)* juga melaporkan bahwa dukungan komunitas, termasuk kelompok ibu dan program pendidikan, dapat mengurangi stres psikososial dan meningkatkan kesejahteraan emosional ibu. Menyediakan program dukungan berbasis komunitas yang mencakup pendidikan

tentang kesehatan mental postpartum, serta tempat bagi ibu untuk bertemu dan berbagi pengalaman. Ini bisa mencakup pertemuan rutin dengan ibu lain di komunitas yang sama, atau program yang disediakan oleh puskesmas atau lembaga lokal.

Pendidikan Kesehatan dan Pemantauan Rutin, memberikan pendidikan kesehatan tentang kesehatan mental kepada ibu hamil dan ibu baru serta melakukan pemantauan kesehatan mental secara rutin untuk mendeteksi gangguan mental lebih awal sangat penting dalam pencegahan dan penanganan gangguan kesehatan mental postpartum. Beberapa hasil penelitian *Gavin et al. (2005)* menunjukkan bahwa skrining kesehatan mental yang rutin selama kunjungan pasca-persalinan dapat membantu mendeteksi depresi atau kecemasan pada tahap awal, memungkinkan intervensi yang lebih cepat. Hasil penelitian yang lain menurut *Stewart et al. (2014)* juga menekankan pentingnya pemantauan kesehatan mental ibu untuk mencegah masalah yang lebih serius di kemudian hari (*Perinatal mental health and psychosocial risk screening in a community maternal and child health setting: evaluation of a digital platform, 2018*). Dengan melakukan skrining depresi menggunakan instrumen yang valid seperti *Edinburgh Postnatal Depression Scale* (EPDS) selama kunjungan pasca-persalinan untuk mendeteksi ibu yang berisiko mengalami gangguan mental. Jika terdeteksi adanya gejala, ibu dapat dirujuk untuk mendapatkan intervensi lebih lanjut (*Settings, 2021*).

C. Program Kesehatan Ibu Postpartum

Transisi menjadi menjadi orang tua biasanya merupakan masa penyesuaian emosional yang intens diperparah oleh gangguan tidur, kelelahan, dan kecemasan tentang merawat dan mengasuh bayi. Ibu yang memiliki pengalaman melahirkan traumatis, atau ibu yang memiliki bayi baru lahir yang sakit dan/ atau dirawat di rumah sakit, mungkin berisiko lebih tinggi mengalami masalah Kesehatan mental. Kesehatan mental ibu postpartum dapat mempengaruhi banyak aspek kehidupan ibu dan bayi termasuk ibu untuk merawat bayi, kesejahteraan emosional dan hubungan ibu dan anak. Program ini bertujuan untuk mendeteksi, mencegah dan memberikan perawatan bagi gangguan Kesehatan mental yang mungkin dialami ibu postpartum.

Mengidentifikasi penyakit mental postpartum dan memberikan dukungan psikologis yang tepat dan kemungkinan perawatan psikiatris adalah penting. Pada saat yang sama, pastikan bahwa kondisi medis lainnya seperti: anemia, atau kelainan tiroid atau penggunaan zat, tidak menyebabkan atau berkontribusi pada gejala-gejala tersebut. Gejala umum postpartum blues adalah suasana hati yang buruk, labil emosional, mudah menangis, kelelahan, dan mudah tersinggung. Gejala-

gejala ini bersifat sementara, dimulai segera setelah melahirkan dan hilang dengan sendirinya dalam beberapa minggu pertama postpartum.

Ciri-ciri lain yang membedakan postpartum *blues* dari episode depresi mayor adalah kuangnya gejala yang parah, seperti insomnia terus menerus, pikiran bersalah atau tidak berharga atau keinginan bunuh diri. Postpartum blues bersifat membatasi diri dan tidak memerlukan perawatan selain kepastian dan dukungan. Depresi postpartum dapat memengaruhi ibu pada usia atau status sosial ekonomi apapun dari budaya apapun. Faktor risiko biologis dapat mencakup riwayat depresi, atau depresi yang tidak diobati selama kehamilan, sementara faktor risiko psikososial dapat mencakup dukungan social yang buruk dan kejadian kehidupan yang penuh tekanan, termasuk masalah yang terkait dengan Kesehatan bayi.

Mendukung ibu postpartum dengan kesehatan mental memerlukan pendekatan yang berpusat pada keluarga dan memiliki banyak sisi berdasarkan kebutuhan dan pengalaman individu ibu dan keluarganya. Ada alat untuk mendeteksi kecemasan dan depresi postpartum, namanya "*The Edinburgh Postnatal Depression Scale* (EPDS)" jika ibu menjawab Ya untuk salah satu pertanyaan ini, itu menandakan perlunya tindak lanjut lebih lanjut untuk menentukan apakah ibu mengalami depresi. Skala depresi postpartum EPDS di kembangkan untuk membantu professional kesehatan dalam mendeteksi ibu yang menderita postpartum depresi.

Menggunakan skala ini terdiri dari 10 pernyataan pendek, seorang ibu postpartum mencentang salah satu dari empat kemungkinan jawaban yang paling dekat dengan apa yang ibu rasakan selama seminggu terakhir. Ibu postpartum dengan mudah menyelesaikan dalam waktu kurang dari lima menit. Tanggapan diberi skor 1, 2, dan 3, berdasarkan keseriusan gejala. Butir 3, 5, hingga 10 terbalik ibu yang mendapat skor diatas 12 atau 13 cenderung menderita depresi dan harus mencari pertolongan medis. Skala menunjukkan bagaimana perasaan ibu postpartum selama seminggu sebelumnya dan mungkin berguna untuk mengulangi skala setelah dua minggu.

Adapun petunjuk untuk penggunaan alat EPDS, yakni: (1) ibu postpartum memeriksa respon yang paling dekat dengan apa yang ibu rasakan selama tujuh hari sebelumnya. (2) semua 10 item harus diselesaikan. (3) perhatian harus diberikan untuk menghindari kemungkinan ibu mendiskusikan jawabannya dengan orang lain, (4) ibu harus menyelesaikan tangga nada sendiri, kecuali ibu memiliki kesulitan atau membaca yang terbatas. (5) skala dapat digunakan pada 6 hingga 8 minggu setelah postpartum atau selama kehamilan.

Program kesehatan ibu postpartum, untuk mendeteksi, mencegah dan memberikan perawatan bagi ibu postpartum. Dengan mendeteksi masalah

Kesehatan mental sejak dini, termasuk depresi postpartum (*baby blues*), kecemasan atau gangguan stress pasca trauma. Memastikan ibu postpartum memiliki akses yang mudah ke pelayanan perawatan Kesehatan, baik di tingkat puskesmas, rumah sakit atau layanan telemedicine. Meningkatkan dukungan social bagi ibu postpartum dengan melibatkan keluarga, teman atau kelompok pendukung untuk mengurangi rasa kesepian atau terisolasi.

Program Kesehatan memberikan edukasi kepada ibu dan keluarga tentang pentingnya menjaga kesehatan mental serta cara-cara untuk mengelola stress dan kecemasan pada ibu postpartum. Selain itu menyediakan intervensi atau pengobatan yang tepat bagi ibu yang mengalami gangguan kesehatan mental, seperti; depresi atau kecemasan baik berupa terapi psikologis. Misalnya terapi perilaku kognitif atau pengobatan obat antidepresan atau anxiolytics. Gejala depresi atau kecemasan bisa memberikan bantuan untuk mengatasi masalah kesehatan mental seperti: meditasi, Latihan pernapasan atau berkonsultasi dengan professional kesehatan.

Salah satu program kesehatan, yang dapat diberikan untuk membantu ibu postpartum dalam mengatasi masalah Kesehatan mental. Misalnya meditasi, khususnya teknik seperti *mindfulness* dan pernapasan dalam, dapat membantu ibu mengurangi kecemasan dan stres. Selama meditasi, ibu diajarkan untuk fokus pada pernapasan atau pikiran positif, yang dapat membantu menenangkan pikiran dan mengurangi perasaan cemas. Dengan mengurangi kecemasan, ibu bisa merasa lebih tenang dan lebih mampu menghadapi tuntutan hidup sehari-hari.

Adapun jenis meditasi yang dapat dipraktikkan atau di latihkan kepada ibu postpartum. Seperti: (1) *Mindfulness meditation*: dengan fokus pada pernapasan dan menerima setiap pikiran serta perasaan tanpa menghakimi; (2) *Guided meditation*, ibu mengikuti panduan suara yang menuntun ibu untuk merilekskan tubuh dan pikiran; (3) Body scan meditation, dimana ibu fokus pada setiap bagian tubuh untuk melepaskan ketegangan fisik dan mental; (4) *Loving-Kindness Meditation* (Metta): Fokus pada pemeliharaan kasih sayang terhadap diri sendiri dan orang lain, membantu ibu merasakan kedamaian batin.

Untuk membantu ibu memberikan kedamaian batin, mungkin program pelayanan kesehatan dalam memberikan edukasi atau Latihan tentang pengelolaan tubuh dan pikiran ibu postpartum melalui *meditation mindfulness*. Dengan Langkah-langkah sebagai berikut:

1. Posisi, ibu duduk dengan nyaman di lantai atau di kursi dengan kaki datar di lantai, tangan di pangkuan, dan tubuh ibu tegak namun santai.
2. Fokus pada sensasi tubuh ibu, dengan mengarahkan pada perasaan sentuhan kursi atau tempat duduk, serta berat badan ibu.

3. Biarkan pikiran ibu datang dan pergi tanpa menilai atau mencoba mengubahnya. Jika muncul perasaan cemas atau kuatir, terima mereka tanpa menghakimi.
4. Dilakukan selama 10 hingga 15 menit, jangan terlalu keras pada diri sendiri jika pikiran sering mengembara, cukup membawa perhatian Kembali dengan lembut.

Selain *meditation mindfulness*, ada juga *loving-kindness meditation* (Metta meditation) dan *Nature sound meditation* (meditasi dengan fokus pada suara alam). Adapun Langkah-langkah:

1. Ibu postpartum duduk dengan nyaman, punggung tegak, tangan di pangkuan
2. Ibu menutup mata dan membayangkan seseorang yang di sayangi, seperti pasangan atau anak. Fokus mengirimkan perasaan kasih sayang dengan mantra (doa-doa) atau pikiran positif seperti "semoga kamu Bahagia, sehat dan damai selalu"
3. Dilakukan dengan waktu 10 sampai 15 menit

Untuk latihan *Nature Sound Meditation* (meditasi dengan fokus pada suara alam). Caranya dengan posisi ibu duduk atau berbaring dengan nyaman, dengarkan suara alam seperti suara ombak, hujan atau suara alam lainnya. Ibu memfokuskan perhatian pada suara tersebut, biarkan suara itu membawa ketenangan dan menenangkan pikiran ibu tersebut. Jika ibu merasa pikirannya mulai melayang, ibu bisa membawa perhatian kembali ke suara alam tersebut. Dilakukan selama 10 sampai 20 menit untuk relaksasi yang mendalam.

D. Hambatan Dalam Pelayanan Kesehatan Mental

Beberapa hambatan dalam pelayanan Kesehatan mental bagi ibu, terutama dalam penerapan intervensi seperti *cognitive behavior therapy*, *mindfulness* serta meditasi, yakni:

1. Stigma

Salah satu hambatan terbesar yang dihadapi oleh ibu dengan gangguan Kesehatan mental adalah stigma sosial terhadap masalah kesehatan mental. Banyak ibu merasa malu atau takut dihakimi jika mengakui bahwa mereka mengalami gangguan mental. Hal ini dapat menyebabkan ketidakmampuan untuk mencari bantuan atau mengikuti intervensi yang ditawarkan.

Dampak ketidakmampuan untuk mengatasi stigma ini dapat menghalangi ibu untuk mengakses layanan kesehatan mental, termasuk terapi *cognitive behavior therapy* (CBT), MBI atau meditasi.

2. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman

Baik ibu sendiri maupun keluarga atau bahkan tenaga kesehatan seringkali memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai pentingnya pencegahan dan intervensi kesehatan mental. Misalnya tidak semua orang familiar dengan

pendekatan CBT atau MBI dan manfaatnya untuk mengatasi gangguan mental pada ibu.

Dampak, dari kurang pemahaman ini dapat menghalangi penerimaan atau keberhasilan dari pendekatan-penekatan ini. Terutama dalam kasus terapi CBT yang memerlukan pemahaman konsep yang lebih mendalam mengenai pola pikir dan perasaan.

3. Keterbatasan sumber daya dan akses ke layanan Kesehatan

Banyak ibu yang tinggal didaerah dengan akses terbatas terhadap layanan kesehatan mental, termasuk terapi berbasis bukti seperti CBT, atau fasilitas untuk meditasi dan pelatihan mindfulness.

Dampak dari hambatan aksesibilitas ini menyebabkan ibu tidak memperoleh layanan yang mereka butuhkan. Dan intervensi yang sudah terbukti efektif menjadi tidak terjangkau.

4. Keterbatasan Waktu

Ibu memiliki tanggungjawab untuk merawat anak, rumah tangga dan pekerjaan seringkali kesulitan menemukan waktu untuk mengikuti sesi terapi atau latihan meditasi. Intervensi seperti CBT dan mindfulness memerlukan komitmen waktu yang tidak sedikit.

Dampak kekurangan waktu yang disebabkan oleh kewajiban lain membuat ibu merasa kesulitan untuk terapi atau intervensi lain yang akhirnya mengurangi keberhasilan dalam pencegahan dan pengelolaan gangguan mental.

5. Kondisi Kesehatan fisik

Ibu yang mengalami gangguan kesehatan mental seringkali juga menghadapi masalah Kesehatan fisik yang dapat memperburuk kondisi psikologis mereka. Misalnya ibu yang baru melahirkan bisa mengalami gangguan tidur atau kelelahan berat yang membuat mereka tidak mampu fokus pada intervensi psikologis.

Kondisi fisik yang buruk mengurangi efektivitas intervensi seperti meditasi atau mindfulness yang memerlukan perhatian dan konsentrasi penuh.

6. Perbedaan dalam pendekatan terapeutik dan budaya

Pendekatan psikoterapi seperti CBT, mindfulness dan meditasi mungkin belum diterima atau dipahami dalam beberapa budaya atau kelompok sosial. Beberapa ibu mungkin lebih terbiasa dengan pendekatan medis konvensional atau kepercayaan spiritual yang berbeda dalam mengatasi masalah Kesehatan mental.

Hal ini bisa menyebabkan penolakan terhadap intervensi berbasis psikologis yang modern atau perasaan tidak cocok dengan metode yang diajarkan dalam terapi, meskipun secara ilmiah terbukti efektif.

7. Keterbatasan dukungan sosial

Ibu yang tidak dapat dukungan sosial yang memadai, baik dari pasangan, keluarga, atau teman-teman mungkin merasa kesulitan untuk mengikuti rencana terapi atau meluangkan waktu untuk diri mereka sendiri. Dukungan sosial adalah elemen penting dalam keberhasilan terapi dan intervensi kesehatan mental.

Tanpa dukungan emosional yang memadai, ibu lebih rentan mengalami kesulitan dalam mengelola stress atau gangguan kesehatan mental, yang membuat intervensi sulit untuk di terapkan dengan sukses.

8. Keterbatasan pelatihan professional kesehatan

Banyak tenaga medis dan professional kesehatan tidak memiliki pelatihan khusus dalam intervensi berbasis psikologi seperti CBT, mindfulness atau meditasi. Ketidak mampuan untuk mengidentifikasi atau menangani gangguan kesehatan mental pada ibu dengan pendekatan ini mengurangi kemungkinan keberhasilan pengobatan.

Tenaga kesehatan yang tidak terlatih dengan pendekatan ini mungkin memberikan perawatan yang kurang efektif, sehingga menghalangi ibu untuk mendapatkan manfaat yang optimal dari intervensi tersebut.

9. Efek jangka panjang dari gangguan kesehatan mental

Ibu yang mengalami gangguan kesehatan mental dalam waktu lama mungkin merasa kesulitan untuk menerima intervensi atau merasa bahwa upaya untuk sembuh tidak akan berhasil. Ketidakmampuan untuk melihat adanya perubahan positif dalam jangka pendek bisa mempengaruhi motivasi untuk melanjutkan terapi.

Jika ibu merasa terapi atau intervensi tidak efektif, mereka mungkin berhenti melanjutkan pengobatan atau tidak berusaha untuk mencegah masalah lebih lanjut, mengurangi keberhasilan jangka panjang dari intervensi tersebut.

10. Keterbatasan pendanaan dan pembiayaan

Banyak layanan kesehatan mental yang berfokus pada *cognitive behavior therapy* (CBT), *mindfulnessbased intervention* (MBI) dan meditasi memerlukan biaya yang tidak terjangkau oleh sebagian ibu teruma mereka yang dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu.

Dampaknya tanpa adanya akses atau dukungan finansial yang memadai, ibu tidak bisa mendapatkan intervensi yang dibutuhkan untuk mengelola Kesehatan mental mereka.

E. Kesimpulan

Pendidikan dan dukungan bagi ibu yang mengalami gangguan kesehatan mental sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan mengurangi

dampak negatif pada kesejahteraan fisik dan emosional. Pendekatan pencegahan dan intervensi berbasis keperawatan seperti, cognitive behavior therapy (CBT), mindfulness-based intervention (MBI), dan meditasi telah terbukti efektif dalam membantu ibu mengatasi stress, kecemasan, depresi dan gangguan Kesehatan mental lainnya.

Dengan menyediakan dukungan yang tepat dan Pendidikan yang memadai, ibu dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan mental yang mereka hadapi. Namun pelaksanaan pencegahan dan intervensi tersebut seringkali menghadapi berbagai hambatan, baik dari faktor internal maupun eksternal. Stigma social terhadap gangguan Kesehatan mental, kurangnya pengetahuan tentang terapi berbasis bukti, keterbatasan akses terhadap layanan Kesehatan, dan keterbatasannya waktu yang dimiliki oleh ibu untuk mengikuti intervensi adalah beberapa tantangan utama yang perlu diatasi.

Selain itu dukungan sosial yang kurang, keterbatasan pelatihan tenaga medis dan hambatan budaya juga turut memperburuk efektivitas pelayanan kesehatan mental bagi ibu. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, diperlukan pendekatan yang lebih terintegrasi yang melibatkan kolaborasi antara tenaga medis, keluarga, dan masyarakat. Penyuluhan tentang kesehatan mental, peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan mental serta dukungan emosional yang kuat dari lingkungan sosial ibu sangat diperlukan agar pencegahan dan intervensi kesehatan mental dapat berhasil diterapkan.

Dengan langkah-langkah ini, ibu akan lebih mampu mengelola kesehatan mental mereka, meningkatkan kesejahteraan pribadi, serta memberikan pengasuhan yang lebih baik bagi anak-anak mereka.

F. Referensi

- itri Ariyanti Abidin¹, 2. W. (2022). Parenting Style and Emotional Well-Being Among Adolescents: The Role of Basic Psychological Needs Satisfaction and Frustration. *Frontiers in Psychology / www.frontiersin.org*, 10.
- Perinatal mental health and psychosocial risk screening in a community maternal and child health setting: evaluation of a digital platform. (2018). *Primary Health Care Research & Development*, 7.
- Settings, I. R. (2021). *Guidance MENTAL HEALTH AND PSYCHOSOCIAL SUPPORT IN EMERGENCY SETTINGS*. Unicef.
- Shin*, H. (2022). Social support and psychological well-being in younger and older adults: The mediating effects of basic psychological need satisfaction. *Department of Psychology, Jeonbuk National University, Jeonju, South Korea*, 14.

Teaford, D. G. (2015). Identification of Postpartum Depression. *JOGNN*, 44, 578-586; 2015, 9.

CHAPTER 6

MENDUKUNG IBU DENGAN TANTANGAN KESEHATAN SESKSUAL PASCA PERSALINAN

Wulida Litaqia, S.Kep., Ners., M.Kep.

A. Pendahuluan/Prolog

Kehamilan dan persalinan adalah periode yang membawa perubahan besar dalam kehidupan seorang ibu, baik secara fisik, emosional, maupun psikologis (Yanti & Fatmasari, 2023). Setelah proses persalinan, tubuh ibu harus beradaptasi dengan berbagai perubahan yang diperlukan untuk pemulihan. Salah satu aspek penting yang sering kali terabaikan adalah kesehatan seksual pasca persalinan (Az-Zahra et al., 2023). Banyak ibu yang merasa terisolasi dengan tantangan yang mereka hadapi setelah melahirkan, terutama dalam hal kehidupan seksual mereka. Perubahan hormonal, fisik, dan psikologis yang terjadi pasca persalinan dapat mempengaruhi kehidupan seksual ibu, baik secara langsung maupun tidak langsung (Elok, 2020). Penurunan gairah seksual, rasa sakit saat berhubungan seksual, serta masalah dengan pelumasan vagina adalah beberapa masalah yang sering dialami oleh ibu pasca melahirkan. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kelelahan, stres, perubahan hormon, serta peran baru sebagai ibu (Yuliana & Hakim, 2020).

Selain itu, kesehatan seksual ibu juga dipengaruhi oleh faktor emosional. Banyak ibu yang merasa cemas, tertekan, atau bahkan mengalami depresi pasca persalinan, yang dapat mengurangi keinginan untuk berhubungan seksual. Banyak pula ibu yang merasa tidak nyaman dengan tubuh mereka setelah melahirkan, yang dapat berpengaruh pada keintiman dengan pasangan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai perubahan fisik dan emosional pasca persalinan, serta pendekatan yang sensitif terhadap tantangan ini, sangat penting dalam mendukung pemulihan kesehatan seksual ibu (Nelsi et al., 2019). Mendukung kesehatan seksual ibu setelah persalinan tidak hanya melibatkan perawatan fisik, tetapi juga perhatian terhadap aspek emosional dan psikologis. Melalui pendekatan yang holistik, yang mencakup edukasi, dukungan sosial, dan perawatan medis yang tepat, tantangan ini dapat diatasi dengan baik. Tujuan dari bab ini adalah untuk membahas berbagai tantangan kesehatan seksual yang dihadapi ibu pasca persalinan dan memberikan panduan yang jelas untuk mendukung ibu agar dapat pulih dengan baik, baik secara fisik maupun emosional.

Sebagai tambahan, banyak penelitian dan literatur yang telah mengkaji tantangan ini dan memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai kesehatan seksual ibu setelah melahirkan. Studi oleh (Ratnaningsih, 2019a) menunjukkan bahwa sekitar 40% ibu mengalami penurunan gairah seksual pada tahun pertama setelah melahirkan, sementara penelitian lain oleh (Edy, 2018) mengungkapkan bahwa masalah fisik seperti nyeri vaginal dan kekeringan vagina terjadi pada sekitar 60% ibu yang menyusui. (Nuryana et al., 2024) juga menyoroti peran penting dukungan psikososial dalam meningkatkan kualitas kehidupan seksual ibu setelah persalinan.

B. Perubahan Fisik Setelah Persalinan dan Dampak Kesehatan Seksual

Setelah persalinan, tubuh ibu mengalami berbagai perubahan fisik yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan, termasuk kesehatan seksual (Lubis, 2016). Perubahan fisik ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pemulihan dari proses kelahiran, fluktuasi hormon, dan adaptasi tubuh terhadap peran baru sebagai ibu (Yanti & Fatmasari, 2023). Banyak dari perubahan ini memerlukan perhatian khusus karena dapat berpengaruh langsung pada kenyamanan ibu saat berhubungan seksual dan kualitas kehidupan seksual secara keseluruhan.

1. Perubahan Hormonal

Salah satu perubahan fisik yang paling signifikan setelah persalinan adalah perubahan hormonal. Kehamilan menyebabkan lonjakan besar dalam kadar hormon estrogen dan progesteron, yang berperan penting dalam mendukung proses kehamilan dan persalinan. Namun, setelah melahirkan, kadar hormon ini menurun drastis, yang mempengaruhi banyak sistem tubuh, termasuk sistem reproduksi (Natalia & Handayani, 2022)

- a. Penurunan Hormon Estrogen: Salah satu dampak utama dari penurunan hormon estrogen adalah berkurangnya pelumasan alami pada vagina, yang menyebabkan kekeringan vaginal. Kekeringan ini dapat menyebabkan rasa tidak nyaman, iritasi, atau bahkan rasa sakit saat berhubungan seksual. Penurunan estrogen juga dapat memperlambat proses penyembuhan jaringan yang terluka selama persalinan, seperti robekan perineum atau episiotomy (Jesica & Friadi, 2019).
- b. Perubahan Kadar Prolaktin dan ASI: Hormon prolaktin, yang bertanggung jawab untuk produksi ASI, meningkat setelah melahirkan. Meskipun prolaktin penting untuk menyusui, kadar prolaktin yang tinggi dapat menyebabkan penurunan gairah seksual pada beberapa ibu. Beberapa ibu juga melaporkan bahwa menyusui secara eksklusif menyebabkan penurunan libido, yang dapat

memperburuk ketidakseimbangan antara kebutuhan seksual pribadi dan peran baru sebagai ibu (Gunawan et al., 2025)

Penurunan hormon estrogen ini, yang sering kali lebih jelas bagi ibu yang menyusui, juga dapat menyebabkan perubahan pada elastisitas jaringan vagina, yang memengaruhi kenyamanan saat berhubungan seksual (Yusuf & Armanto, 2021). (Guintivano et al., 2018) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kekeringan vagina adalah salah satu keluhan utama yang dilaporkan oleh ibu menyusui dalam beberapa bulan pertama setelah melahirkan.

2. Penyembuhan Luka dan Pemulihan Fisik

Selama persalinan, terutama pada persalinan yang melibatkan robekan atau episiotomi (pemotongan perineum), ibu dapat mengalami luka yang membutuhkan waktu untuk sembuh. Penyembuhan luka ini bisa memengaruhi kenyamanan fisik ibu dan menjadi hambatan dalam kehidupan seksual.

- a. Episiotomi dan Robekan Perineum: Pada persalinan vaginal yang melibatkan episiotomi atau robekan perineum, ibu perlu waktu untuk pemulihan. Area perineum adalah bagian tubuh yang sangat sensitif, dan pemulihan dari luka di area ini bisa memerlukan waktu hingga enam minggu atau lebih, tergantung pada keparahan luka tersebut. Rasa nyeri atau ketidaknyamanan pada area perineum dapat membuat ibu enggan atau merasa tidak nyaman untuk berhubungan seksual pada awal pasca persalinan (Ratnaningsih, 2019b)
- b. Perubahan pada Otot Panggul: Otot-otot panggul ibu juga mengalami peregangan atau bahkan kerusakan selama proses melahirkan. Otot-otot ini sangat penting dalam mendukung organ-organ panggul dan berperan dalam kenyamanan seksual. Beberapa ibu mengalami kelemahan otot panggul setelah melahirkan, yang dapat menyebabkan gejala seperti inkontinensia urin, prolaps organ panggul, atau rasa tidak nyaman saat berhubungan seksual (Informasi & Indonesia, 2018). Suralaga et al., (2020) menunjukkan bahwa latihan penguatan otot panggul, seperti latihan Kegel, sangat membantu dalam meningkatkan fungsi seksual dan kualitas hidup ibu pasca persalinan.

3. Perubahan pada Vagina dan Saluran Reproduksi

Proses persalinan dapat menyebabkan perubahan permanen pada struktur vagina dan saluran reproduksi yang memengaruhi kehidupan seksual ibu. Salah satu perubahan ini adalah:

- a. Peregangan dan Elastisitas Vagina: Selama persalinan, terutama jika bayi besar atau persalinan dilakukan dengan bantuan alat, vagina dapat meregang dengan signifikan. Beberapa ibu melaporkan bahwa setelah melahirkan, mereka merasa bahwa vagina mereka "longgar" atau kehilangan elastisitasnya,

yang dapat memengaruhi kenyamanan saat berhubungan seksual (Khasanah & Sulistyawati, 2017).

- b. Perubahan pada Serviks: Setelah melahirkan, serviks yang sebelumnya tertutup rapat untuk menjaga janin tetap di dalam rahim akan mengalami perubahan. Serviks bisa sedikit lebih terbuka atau lebih elastis, yang dapat mempengaruhi kenyamanan dan fungsi seksual ibu pasca persalinan. Meskipun perubahan ini biasanya bersifat sementara, beberapa ibu mungkin merasa bahwa hal itu memengaruhi keintiman seksual dengan pasangan mereka (Yanti & Fatmasari, 2023)

4. Kelelahan dan Perubahan Energi

Setelah melahirkan, banyak ibu yang mengalami kelelahan yang ekstrem akibat proses persalinan yang panjang dan berat, ditambah dengan kebutuhan untuk merawat bayi yang baru lahir (Afrina et al., 2024a). Kelelahan fisik ini sangat mempengaruhi energi dan motivasi untuk terlibat dalam aktivitas seksual.

- a. Kelelahan Fisik: Setelah melahirkan, terutama jika ibu menyusui dan terjaga semalaman untuk memberi makan bayi, tubuh ibu dapat merasa sangat lelah. Kelelahan fisik ini sering kali menjadi penghalang terbesar untuk kembali terlibat dalam hubungan seksual, meskipun tubuh ibu sudah pulih dari luka fisik (Oktafia & Deviana, 2021)
- b. Perubahan Pola Tidur: Tidur yang terganggu juga dapat mempengaruhi kadar energi ibu dan menyebabkan penurunan gairah seksual. Gangguan tidur setelah persalinan terkait erat dengan penurunan gairah seksual ibu, karena kelelahan yang berlarut-larut mengurangi minat pada hubungan seksual (Fatmawati et al., 2019)

5. Pengaruh Menstruasi dan Kesehatan Seksual

Setelah persalinan, ibu akan mengalami perubahan dalam siklus menstruasi, terutama jika menyusui. Beberapa ibu mungkin mengalami penundaan menstruasi hingga mereka berhenti menyusui, sementara yang lain mungkin kembali menstruasi lebih cepat (Reni Adha & Bantas, 2020).

- a. Pengaruh Menstruasi: Menstruasi pertama setelah melahirkan dapat menyebabkan ketidaknyamanan atau perubahan dalam tingkat energi ibu. Beberapa ibu mungkin merasa tidak nyaman untuk berhubungan seksual selama menstruasi pertama, meskipun hal ini bersifat sementara (Djannah et al., 2022).
- b. Kesehatan Seksual setelah Menstruasi: Setelah menstruasi kembali, beberapa ibu mengalami perubahan dalam siklus menstruasi, seperti periode yang lebih berat atau lebih ringan dari biasanya. Perubahan ini bisa memengaruhi

keinginan untuk berhubungan seksual, terutama bagi ibu yang merasa tidak nyaman dengan perubahan tersebut (Djannah et al., 2022).

6. Tantangan Kesehatan Seksual Pasca Persalinan

Setelah melahirkan, banyak ibu yang menghadapi tantangan kesehatan seksual yang dapat mempengaruhi kehidupan intim mereka dengan pasangan. Proses persalinan, baik itu persalinan vaginal maupun melalui operasi caesar, membawa perubahan fisik, hormon, dan emosional yang mendalam yang mempengaruhi keinginan, kenyamanan, dan pengalaman seksual ibu. Tantangan-tantangan ini sangat bervariasi antara individu, tergantung pada faktor-faktor seperti jenis kelamin bayi, durasi dan cara persalinan, kondisi fisik ibu, dukungan sosial, serta keadaan emosional dan psikologis ibu pasca melahirkan (Djannah et al., 2022).

Dalam bagian ini, kita akan membahas beberapa tantangan utama yang sering dialami oleh ibu pasca persalinan terkait dengan kesehatan seksual. Tantangan-tantangan ini mencakup penurunan gairah seksual, masalah dengan rasa sakit atau ketidaknyamanan saat berhubungan seksual, perubahan pada fungsi seksual, serta gangguan kesehatan mental yang dapat mempengaruhi kehidupan seksual ibu.

1. Penurunan Gairah Seksual

Salah satu tantangan utama yang dihadapi ibu pasca persalinan adalah penurunan gairah seksual. Banyak ibu yang melaporkan penurunan minat terhadap hubungan seksual setelah melahirkan. Penurunan gairah seksual ini bisa bersifat sementara atau bahkan jangka panjang, tergantung pada berbagai faktor fisik dan psikologis (Ratnaningsih, 2019b).

a. Faktor-faktor fisik yang mempengaruhi gairah seksual:

- 1) Kekeringan Vagina: Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penurunan kadar estrogen setelah melahirkan dapat menyebabkan kekeringan vagina, yang sering kali mengarah pada ketidaknyamanan atau rasa sakit saat berhubungan seksual. Kekeringan ini bisa sangat mengganggu gairah seksual ibu, yang secara psikologis dapat mengurangi minat untuk berhubungan seksual (Nurhapipa et al., 2017).
- 2) Kelelahan: Pasca persalinan, ibu sering kali merasa sangat lelah karena banyaknya tanggung jawab yang harus dihadapi, seperti menyusui, mengurus bayi, dan menyesuaikan diri dengan rutinitas baru. Kelelahan fisik dan mental ini membuat ibu kurang berenergi untuk terlibat dalam aktivitas seksual (Djannah et al., 2022a). Snyder et al., (2022) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kelelahan adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi penurunan gairah seksual pada ibu pasca persalinan.

3) Perubahan Tubuh: Banyak ibu yang merasa tidak percaya diri dengan perubahan tubuh mereka setelah melahirkan. Perubahan-perubahan seperti perut yang membesar, perubahan pada payudara, atau bekas luka akibat episiotomi atau caesar dapat menyebabkan rasa tidak nyaman atau bahkan rasa malu yang mengurangi minat seksual ibu (Nurhapipa et al., 2017). Ibu cenderung memiliki perasaan tidak puas dengan penampilan tubuh pasca melahirkan dapat menyebabkan penurunan gairah seksual ibu (Snyder et al., 2022).

b. Faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi gairah seksual:

1) Peran Baru sebagai Ibu: Menjadi ibu pertama kali adalah perubahan besar dalam hidup seorang wanita. Banyak ibu merasa stres dan cemas mengenai peran baru ini, yang dapat mengganggu keseimbangan emosional mereka. Ketidaknyamanan psikologis ini sering kali diterjemahkan ke dalam penurunan gairah seksual, karena ibu mungkin merasa bahwa mereka lebih fokus pada perawatan anak daripada hubungan intim (Dewi Pramanik et al., 2020).

2) Depresi Pasca Persalinan (PPD): Sekitar 10-20% ibu baru mengalami depresi pasca persalinan (PPD), yang mempengaruhi kesejahteraan emosional dan fisik mereka (Gunawan et al., 2025). Depresi ini dapat mengurangi minat seksual, karena gejala PPD termasuk kelelahan ekstrem, rasa cemas, dan kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya menyenangkan. Dennis et al., (2018) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa ibu dengan PPD lebih cenderung mengalami penurunan gairah seksual dan sering kali merasa kurang terhubung dengan pasangan mereka secara seksual.

2. Rasa Sakit atau Ketidaknyamanan saat Berhubungan Seksual

Bagi banyak ibu, rasa sakit atau ketidaknyamanan saat berhubungan seksual pasca persalinan adalah masalah yang signifikan. Masalah ini biasanya disebabkan oleh dua faktor utama: penyembuhan dari luka persalinan dan perubahan pada struktur fisik vagina dan area panggul.

a. Episiotomi atau Robekan Perineum: Pada persalinan vaginal, episiotomi atau robekan perineum adalah prosedur umum yang dilakukan untuk memperlancar proses kelahiran. Meskipun tindakan ini membantu proses persalinan, area perineum yang terluka memerlukan waktu untuk sembuh. Selama masa pemulihan, ibu mungkin merasa kesakitan atau ketidaknyamanan ketika melakukan hubungan seksual. Bourg et al. (2017) menunjukkan bahwa sekitar 50% ibu yang melahirkan secara vaginal melaporkan ketidaknyamanan atau rasa sakit saat berhubungan seksual dalam enam bulan pertama setelah persalinan.

- b. Kekeringan Vagina: Seperti yang telah dibahas sebelumnya, penurunan kadar estrogen setelah melahirkan, terutama bagi ibu yang menyusui, dapat menyebabkan kekeringan vagina yang membuat hubungan seksual menjadi tidak nyaman atau menyakitkan. Beberapa ibu melaporkan bahwa meskipun mereka memiliki keinginan seksual, mereka merasa tidak nyaman atau bahkan sakit saat berhubungan seksual. Gustafsson et al. (2018) mengungkapkan bahwa masalah kekeringan vagina pada ibu menyusui sering kali disebabkan oleh rendahnya kadar estrogen, dan sering kali mengarah pada pengurangan kepuasan seksual.

3. Gangguan Kesehatan Mental

Selain faktor fisik, kesehatan mental ibu juga memainkan peran penting dalam kehidupan seksual mereka setelah melahirkan. Banyak ibu yang menghadapi tantangan psikologis pasca persalinan yang secara langsung mempengaruhi kehidupan seksual mereka.

- a. Depresi Pasca Persalinan (PPD): Depresi pasca persalinan adalah kondisi yang cukup umum, yang berdampak pada kualitas hidup ibu, termasuk kehidupan seksual mereka. Ibu yang mengalami depresi mungkin merasa cemas, lelah, atau kehilangan minat pada hampir semua aspek kehidupan, termasuk seks. Dennis et al. (2018) menemukan bahwa ibu dengan gejala depresi pasca persalinan cenderung memiliki kehidupan seksual yang kurang memuaskan dan mengalami penurunan keinginan seksual.
- b. Kecemasan dan Stres: Selain PPD, kecemasan yang berlebihan mengenai perawatan bayi, kekhawatiran akan masa depan, atau stres dari tanggung jawab baru dapat mengalihkan perhatian ibu dari kehidupan seksual mereka. Ibu yang tertekan atau cemas sering kali merasa tidak tertarik pada hubungan intim karena mereka merasa lebih fokus pada pekerjaan rumah tangga atau perawatan bayi.
- c. Hubungan dengan Pasangan: Komunikasi yang terbuka dan dukungan dari pasangan sangat penting dalam menjaga kehidupan seksual yang sehat pasca persalinan. Namun, banyak pasangan yang merasa tertekan atau terisolasi setelah kelahiran anak pertama. Ketegangan dalam hubungan ini, baik itu karena kurangnya waktu bersama atau kurangnya komunikasi yang efektif, dapat menyebabkan penurunan kepuasan seksual. Doss et al. (2016) menemukan bahwa stres pasangan dapat berkontribusi pada penurunan kualitas kehidupan seksual ibu, terutama jika pasangan tidak memberikan dukungan emosional yang dibutuhkan ibu.

4. Pengaruh Penyusuan ASI

Penyusuan ASI, meskipun memiliki banyak manfaat kesehatan bagi ibu dan bayi, juga dapat mempengaruhi kehidupan seksual ibu (Nurhapipa et al., 2017). Produksi ASI yang meningkat setelah melahirkan meningkatkan kadar prolaktin, yang dapat menyebabkan penurunan gairah seksual pada beberapa ibu.

- a. Kelelahan dan Stres: Proses menyusui yang berlangsung terus-menerus dapat menyebabkan kelelahan, yang memperburuk penurunan gairah seksual (Djannah et al., 2022b). (Oktafia & Deviana, 2021) menyebutkan bahwa ibu yang menyusui cenderung merasa lelah dan tidak memiliki energi untuk aktivitas seksual. Hal ini diperburuk oleh ketegangan mental yang dirasakan oleh ibu yang berjuang untuk menyeimbangkan antara menyusui, merawat bayi, dan mengurus rumah tangga.
- b. Perubahan Sensitivitas Payudara: Selama menyusui, payudara ibu menjadi lebih sensitif dan mungkin terasa tidak nyaman ketika disentuh atau terlibat dalam aktivitas seksual. Seigny et al. (2015) menjelaskan bahwa meskipun payudara memiliki peran dalam kehidupan seksual, mereka sering kali menjadi area yang lebih sensitif setelah melahirkan, yang dapat mengurangi keinginan seksual dan kenyamanan saat berhubungan seksual.

C. Perawatan untuk Mendukung Kesehatan Seksual Pasca Persalinan

Perawatan kesehatan seksual pasca persalinan merupakan bagian integral dari pemulihan ibu setelah melahirkan. Setelah persalinan, tubuh ibu mengalami berbagai perubahan yang mempengaruhi aspek fisik, hormonal, dan psikologis yang berhubungan langsung dengan kesehatan seksual. Perawatan yang tepat sangat penting untuk membantu ibu mengatasi tantangan yang mungkin mereka hadapi, seperti rasa sakit, kekeringan vagina, penurunan gairah seksual, dan masalah emosional yang mempengaruhi hubungan intim. Dalam konteks ini, perawatan pasca persalinan tidak hanya melibatkan pemulihan fisik, tetapi juga memperhatikan aspek psikologis dan emosional, serta memberikan dukungan sosial yang memadai.

Pada bagian ini, kita akan membahas berbagai pendekatan dan strategi perawatan yang dapat membantu ibu menjaga dan meningkatkan kesehatan seksual mereka setelah melahirkan. Perawatan ini mencakup edukasi, dukungan psikologis, pengelolaan masalah fisik, serta pemulihan melalui latihan fisik dan terapi medis yang sesuai.

1. Edukasi Mengenai Kesehatan Seksual Pasca Persalinan

Edukasi adalah langkah pertama yang sangat penting dalam mendukung kesehatan seksual ibu setelah melahirkan (Oktafia et al., 2022). Banyak ibu yang tidak sepenuhnya menyadari perubahan fisik yang terjadi setelah persalinan dan

bagaimana perubahan tersebut dapat mempengaruhi kehidupan seksual mereka. Edukasi yang diberikan kepada ibu dapat mencakup informasi tentang pemulihan fisik pasca persalinan, penggunaan pelumas, serta waktu yang tepat untuk memulai aktivitas seksual kembali.

Poin-poin penting yang perlu disampaikan dalam edukasi:

- a. Kekeringan Vagina dan Penggunaan Pelumas: Banyak ibu mengalami kekeringan vagina pasca persalinan, terutama yang menyusui. Edukasi tentang penggunaan pelumas berbasis air yang aman dapat membantu mengurangi ketidaknyamanan atau rasa sakit saat berhubungan seksual. Penggunaan pelumas dapat menjadi solusi sementara untuk mengatasi kekeringan vagina sambil tubuh ibu pulih secara alami (Dewi Pramanik et al., 2020).
- b. Waktu yang Tepat untuk Memulai Aktivitas Seksual: Ibu perlu diberikan informasi mengenai kapan waktu yang aman untuk memulai kembali hubungan seksual setelah melahirkan. Meskipun beberapa ibu merasa siap untuk berhubungan seksual lebih awal, umumnya disarankan untuk menunggu hingga 6 minggu pasca persalinan agar tubuh dapat pulih dengan baik, terutama jika ada jahitan atau luka pada area perineum. Waktu ini juga penting untuk memastikan bahwa ibu tidak mengalami infeksi atau komplikasi setelah melahirkan (Djannah et al., 2022b).
- c. Perubahan Tubuh dan Pengelolaan Stres Emosional: Edukasi mengenai perubahan tubuh pasca persalinan, seperti penurunan bentuk tubuh, perubahan pada payudara, atau efek samping lain yang berhubungan dengan kehamilan, dapat membantu ibu mengurangi kecemasan terkait penampilan fisik mereka. Menyadari bahwa perubahan ini adalah bagian normal dari pemulihan tubuh pasca melahirkan dapat membantu ibu menerima diri mereka dengan lebih baik. (Guintivano et al., 2018).

Edukasi yang komprehensif ini penting untuk meningkatkan kesadaran ibu dan membantu mereka mempersiapkan diri dengan lebih baik terhadap tantangan yang dihadapi dalam kehidupan seksual setelah melahirkan. Menurut penelitian oleh Yelland et al. (2015), edukasi yang efektif terkait perawatan pasca persalinan dapat meningkatkan kualitas kehidupan seksual ibu dan mengurangi kecemasan yang terkait dengan hubungan seksual setelah melahirkan.

2. Dukungan Psikologis dan Komunikasi Terbuka

Dukungan psikologis sangat penting dalam perawatan kesehatan seksual pasca persalinan. Banyak ibu yang menghadapi tantangan psikologis, seperti kecemasan atau depresi pasca persalinan (PPD), yang dapat memengaruhi gairah seksual mereka. Postpartum depression (PPD), yang meliputi perasaan cemas, kesedihan, atau kehilangan minat terhadap aktivitas sehari-hari, dapat

memperburuk masalah seksual ibu. Oleh karena itu, penting untuk memberikan dukungan emosional yang memadai baik dari pasangan, keluarga, maupun tenaga medis.

Langkah-langkah untuk memberikan dukungan psikologis:

- a. Terapi dan Konseling: Jika ibu mengalami gejala depresi atau kecemasan pasca persalinan, terapi psikologis atau konseling sangat dianjurkan. Terapi perilaku kognitif (CBT) telah terbukti efektif dalam mengatasi kecemasan dan depresi setelah melahirkan, yang dapat meningkatkan gairah seksual dan hubungan intim (Inne Yelisni, 2023).
- b. Komunikasi Terbuka dengan Pasangan: Salah satu hal yang sering kali diabaikan setelah melahirkan adalah komunikasi antara pasangan mengenai kebutuhan seksual. Setelah melahirkan, pasangan harus bekerja sama untuk memahami perasaan dan tantangan yang dihadapi ibu. Membuka ruang untuk komunikasi yang terbuka dan mendukung akan membantu ibu merasa lebih nyaman dan mengurangi rasa cemas atau tertekan tentang hubungan seksual (Afrina et al., 2024b).
- c. Penerimaan Diri dan Dukungan dari Pasangan: Dukungan pasangan yang terbuka dan penuh perhatian dapat meningkatkan perasaan penerimaan diri ibu, yang berhubungan langsung dengan kualitas hubungan seksual. Pasangan yang memahami perasaan dan kebutuhan ibu dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung, meningkatkan keintiman dan gairah seksual ibu (Afrina et al., 2024b).

3. Pengelolaan Masalah Fisik: Pelumas, Latihan, dan Terapi Medis

Masalah fisik seperti kekeringan vagina, rasa sakit atau ketidaknyamanan saat berhubungan seksual, dan kelemahan otot panggul dapat mengganggu kualitas kehidupan seksual ibu pasca persalinan. Oleh karena itu, berbagai perawatan medis dan fisik harus dipertimbangkan untuk membantu ibu memulihkan kenyamanan seksual mereka.

Langkah-langkah pengelolaan fisik:

- a. Penggunaan Pelumas: Seperti yang telah dibahas sebelumnya, penggunaan pelumas berbasis air merupakan solusi sementara untuk mengatasi kekeringan vagina. Pelumas dapat membantu mengurangi rasa sakit atau ketidaknyamanan yang disebabkan oleh kekeringan, memungkinkan ibu untuk berhubungan seksual dengan lebih nyaman. Pelumas harus dipilih dengan hati-hati untuk menghindari iritasi atau infeksi.
- b. Latihan Otot Panggul (Kegel): Latihan Kegel yang bertujuan untuk memperkuat otot-otot panggul dapat membantu ibu yang mengalami kelemahan otot panggul pasca persalinan. Latihan ini tidak hanya bermanfaat untuk

meningkatkan kontrol terhadap fungsi urin, tetapi juga dapat meningkatkan kenyamanan dan kenikmatan selama hubungan seksual. Bourg et al. (2017) menyatakan bahwa latihan Kegel dapat membantu mengatasi masalah seperti inkontinensia urin dan prolaps organ panggul, yang keduanya dapat mengganggu kesehatan seksual ibu.

- c. Terapi Medis dan Pengobatan: Dalam beberapa kasus, perawatan medis tambahan mungkin diperlukan. Misalnya, jika ibu mengalami masalah serius dengan pelumasan vagina atau gejala nyeri seksual yang berkepanjangan, dokter dapat meresepkan terapi hormon estrogen topikal untuk meningkatkan pelumasan vagina. Selain itu, obat-obatan untuk mengatasi depresi atau kecemasan pasca persalinan juga dapat membantu mengatasi tantangan emosional yang mengganggu kehidupan seksual ibu.

4. Menjaga Kesehatan Mental dan Kesejahteraan Emosional

Perawatan kesehatan seksual tidak hanya terbatas pada pengelolaan masalah fisik, tetapi juga memperhatikan kesehatan mental ibu. Setelah melahirkan, ibu dapat mengalami gangguan emosional yang mempengaruhi libido dan keinginan seksual mereka. Oleh karena itu, perawatan psikologis dan emosional sangat penting.

Pendekatan untuk meningkatkan kesehatan mental:

- a. Mindfulness dan Relaksasi: Teknik mindfulness dan relaksasi, seperti meditasi atau yoga, dapat membantu ibu mengurangi stres dan kecemasan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kenyamanan dalam kehidupan seksual. Cohen et al. (2019) menunjukkan bahwa latihan mindfulness dapat meningkatkan kualitas kehidupan seksual ibu dengan mengurangi stres dan meningkatkan penerimaan terhadap perubahan tubuh mereka.
- b. Dukungan Sosial: Mendapatkan dukungan sosial dari keluarga, teman, atau kelompok ibu dapat membantu mengurangi perasaan terisolasi yang sering kali dirasakan setelah melahirkan. Dukungan sosial yang kuat dapat meningkatkan kesejahteraan emosional ibu, yang pada gilirannya dapat meningkatkan keintiman dan kehidupan seksual ibu.

5. Kesimpulan

Perawatan kesehatan seksual pasca persalinan harus dipandang sebagai bagian penting dari pemulihan ibu setelah melahirkan. Dengan pendekatan yang holistik—yang melibatkan edukasi, dukungan psikologis, pengelolaan masalah fisik, serta perhatian terhadap kesejahteraan emosional—ibu dapat mengatasi tantangan yang mereka hadapi dan memulihkan kehidupan seksual yang sehat. Dukungan dari pasangan, keluarga, dan tenaga medis sangat penting untuk

memastikan bahwa ibu dapat menjalani kehidupan seksual yang memuaskan setelah persalinan.

D. Simpulan

Perawatan kesehatan seksual pasca persalinan merupakan aspek krusial dalam pemulihan ibu setelah melahirkan, yang sering kali diabaikan atau kurang mendapat perhatian dalam banyak sistem perawatan kesehatan. Tantangan yang dihadapi oleh ibu pasca persalinan sangat bervariasi, namun sebagian besar terkait dengan perubahan fisik, hormonal, dan psikologis yang mempengaruhi kehidupan seksual mereka. Penurunan kadar hormon estrogen, terutama pada ibu yang menyusui, menyebabkan kekeringan vagina, penurunan elastisitas jaringan genital, dan ketidaknyamanan fisik yang bisa memperburuk gairah seksual. Selain itu, kelelahan fisik dan emosional yang disebabkan oleh tanggung jawab merawat bayi, penyembuhan luka pada area perineum, serta perubahan tubuh setelah persalinan, sering kali menjadi hambatan besar bagi ibu untuk terlibat dalam hubungan seksual. Secara psikologis, ibu juga berisiko mengalami depresi pasca persalinan (PPD) yang mempengaruhi keinginan dan kenyamanan dalam berhubungan intim.

Namun, dengan pendekatan perawatan yang holistik, tantangan ini dapat dikelola dengan baik. Edukasi mengenai perubahan fisik dan seksual pasca persalinan menjadi langkah awal yang sangat penting, karena dapat membantu ibu memahami kondisi tubuh mereka dan mengurangi kecemasan yang mungkin timbul. Dukungan psikologis juga memegang peranan besar dalam mengurangi stres dan meningkatkan kualitas hubungan intim, karena komunikasi terbuka dengan pasangan dan dukungan mental dapat memperkuat ikatan emosional yang esensial dalam kehidupan seksual. Selain itu, perawatan medis yang tepat, seperti penggunaan pelumas untuk mengatasi kekeringan vagina dan latihan otot panggul untuk memperkuat fungsi seksual, dapat mempercepat pemulihan fisik dan memperbaiki kenyamanan seksual. Dukungan sosial dari pasangan dan keluarga sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan ibu, baik secara fisik maupun emosional. Dengan pendekatan yang komprehensif dan perhatian terhadap setiap aspek kesehatan ibu pasca persalinan, ibu dapat mengatasi tantangan kesehatan seksual mereka dengan lebih baik dan kembali menikmati kehidupan seksual yang sehat dan memuaskan.

E. Referensi

Afrina, R., Rukiah, N., Keperawatan, P. S., & Kesehatan, I. (2024a). Hubungan Tingkat Kelelahan dan Dukungan Sosial Suami dengan Baby Blues Maternal pada Ibu Pasca ... (Rina Afrina, Nining Rukiah) Hubungan Tingkat Kelelahan dan Dukungan Sosial Suami dengan Baby Blues Maternal pada Ibu Pasca

- Melahirkan di Wilayah Bogor Selatan Tahun 2024. *Jurnal Sains Dan Teknologi*, 6(1), 148–157. <https://doi.org/10.55338/saintek.v6i1.3346>
- Afrina, R., Rukiah, N., Keperawatan, P. S., & Kesehatan, I. (2024b). Hubungan Tingkat Kelelahan dan Dukungan Sosial Suami dengan Baby Blues Maternal pada Ibu Pasca ... (Rina Afrina, Nining Rukiah) Hubungan Tingkat Kelelahan dan Dukungan Sosial Suami dengan Baby Blues Maternal pada Ibu Pasca Melahirkan di Wilayah Bogor Selatan Tahun 2024. *Jurnal Sains Dan Teknologi*, 6(1), 148–157. <https://doi.org/10.55338/saintek.v6i1.3346>
- Az-Zahra, H. Z., Tonasih, Yulianti, R., Adinda, Ainaya, Anggi, Hasna, Nabilla, & Rahma. (2023). HUBUNGAN HORMON ADAPTASI FISILOGI DAN PSIKOLOGI PADA MASA NIFAS. *Jurnal Maternitas Kebidanan*, 8(2).
- Dennis, C. L., Brown, H. K., Wanigaratne, S., Fung, K., Vigod, S. N., Grigoriadis, S., Marini, F., & Brennenstuhl, S. (2018). Prevalence, Incidence, and Persistence of Postpartum Depression, Anxiety, and Comorbidity among Chinese Immigrant and Nonimmigrant Women: A Longitudinal Cohort Study. *Canadian Journal of Psychiatry*, 63(1), 44–53. <https://doi.org/10.1177/0706743717720689>
- Dewi Pramanik, N., Sri Rahayu, E., & Studi kebidanan Bogor Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung, P. (2020). *PENDAMPINGAN IBU PASCASALIN DAN KUALITAS HUBUNGAN SEKSUAL Postpartum Maternal Accompaniment and Quality of Maternal Sexual Intercourse*. 12. <https://doi.org/10.34011/juriskesbdg.v12i2.887>
- Djannah, R., Susanti, D., Karya, A., & Husada, B. (2022a). PERUBAHAN POLA AKTIFITAS SEKSUAL PADA IBU PASCA MELAHIRKAN A B S T R A K. *Jurnal Ilmu Kesehatan Karya Bunda Husada*, 8(1).
- Djannah, R., Susanti, D., Karya, A., & Husada, B. (2022b). PERUBAHAN POLA AKTIFITAS SEKSUAL PADA IBU PASCA MELAHIRKAN A B S T R A K. In *Jurnal Ilmu Kesehatan Karya Bunda Husada* (Vol. 8, Issue 1).
- Edy. (2018). *PERBEDAAN DISFUNGSI SEXUAL WANITA YANG MELAHIRKAN SECARA PERVAGINAM DENGAN EPISIOTOMY MEDIOLATERAL DAN SEKSIO SESAREA*.
- Elok, R. A. (2020). *FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESIAPAN IBU NIFAS UNTUK MEMULAI AKTIVITAS SEKSUAL PASCA NIFAS DI PMB ALFU FITRIYAH KOTA SURABAYA*. STIKes Ngudia Husada .
- Fatmawati, R., Hidayah, N., Iii, D., & Surakarta, M. (2019). GAMBARAN POLA TIDUR IBU NIFAS. In *INFOKES* (Vol. 9, Issue 2).
- Guintivano, J., Sullivan, P. F., Stuebe, A. M., Penders, T., Thorp, J., Rubinow, D. R., & Meltzer-Brody, S. (2018). Adverse life events, psychiatric history, and biological predictors of postpartum depression in an ethnically diverse

- sample of postpartum women. *Psychological Medicine*, 48(7), 1190–1200. <https://doi.org/10.1017/S0033291717002641>
- Gunawan, D., Camillo, K. V., Gunadi, J. W., & Sanjaya, A. (2025). *Literature Review: Pengaruh Estrogen Terhadap Depresi Pasca Persalinan*.
- Informasi, J., & Indonesia, K. (2018). *LATIHAN OTOT DASAR PANGGUL DAN KOMUNIKASI SEKSUAL PADA IBU PASCASALIN (Pelvic Floor Muscle Exercise And Sexual Communication On Postpartum Woman)* (Vol. 4, Issue 2).
- Inne Yelisni. (2023). PENGARUH COGNITIVE BEHAVIOR THERAPY (CBT) TERHADAP DEPRESI POSTPARTUM: LITERATURE REVIEW. *Jurnal Inspirasi Kesehatan*, 1(2), 181–194. <https://doi.org/10.52523/jika.v1i2.71>
- Jesica, F., & Friadi, A. (2019). HUBUNGAN KADAR KORTISOL DAN PROSTAGLANDIN MATERNAL DENGAN PERSALINAN PRETERM DAN ATERM. In *Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan* (Vol. 10, Issue 1).
- Khasanah, N. A., & Sulistyawati, W. (2017). *ASUHAN NIFAS DAN MENYUSUI*. STIKes Majapahit Mojokerto.
- Lubis, N. L. (2016). *Psikologi Kespro: Wanita dan Perkembangan Reproduksi: Ditinjau dari Aspek Fisik dan Psikologinya*. Kencana.
- Natalia, L., & Handayani, I. (2022). KETIDAKNYAMANAN KEHAMILAN TRIMESTER III : SEBUAH LAPORAN KASUS ASUHAN KEHAMILAN. *Jurnal Kesehatan Siliwangi*, 3(2), 302–307. <https://doi.org/10.34011/jks.v3i2.1184>
- Nelsi, Y., Abbas, H. H., & Vitayani, S. (2019). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kecemasan pada Ibu Hamil terhadap Hubungan Seksual di RSIA Siti Khadijah I Makassar. *Window of Health: Jurnal Kesehatan*, 128–136. <https://doi.org/10.33096/woh.vi.164>
- Nurhapipa, Alhidayati, & Ayunda, G. (2017). FAKTOR -FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERILAKU SEKSUAL. *JOMIS (Journal Of Midwifery Science)*, 1.
- Nuryana, R., Elsanti, D., DIII Kebidanan, P., Tanawali Takalar, S., & Keperawatan, P. (2024). *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah* Kualitas Hidup Terkait Kesehatan Pada Ibu Hamil Pasca Operasi Caesar: Studi Longitudinal. In *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah* (Vol. 9, Issue 4).
- Oktafia, R., & Deviana, R. (2021). HUBUNGAN KELELAHAN POSTPARTUM DENGAN MOTIVASI PEMBERIAN ASI. *JURNAL KESEHATAN MERCUSUAR*, 4(2), 66–73. <https://doi.org/10.36984/jkm.v4i2.221>
- Oktafia, R., Rini Rahmayanti, & Dea Ainun Maghpira. (2022). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP PENCEGAHAN MASALAH PSIKOLOGIS PADA IBU PASCA MELAHIRKAN. *JURNAL ABDI MERCUSUAR*, 2(1), 1–8. <https://doi.org/10.36984/jam.v2i1.292>

- Ratnaningsih, E. (2019a). Kualitas Fungsi Seksual Ibu Postpartum Dengan Jahitan Perineum Diukur Menggunakan Female Sexual Function Index. *Jurnal SMART Kebidanan*, 6(2), 93. <https://doi.org/10.34310/sjkb.v6i2.277>
- Ratnaningsih, E. (2019b). Kualitas Fungsi Seksual Ibu Postpartum Dengan Jahitan Perineum Diukur Menggunakan Female Sexual Function Index. *Jurnal SMART Kebidanan*, 6(2), 93. <https://doi.org/10.34310/sjkb.v6i2.277>
- Reni Adha, N., & Bantas, K. (2020). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Waktu Kembalinya Menstruasi Pertama Pasca Persalinan di Wilayah Rural, Indonesia. *Jurnal Epidemiologi Kesehatan*.
- Snyder, K., Mollard, E., Bargstadt-Wilson, K., Peterson, J., Branscum, C., & Richards, T. (2022). Pelvic floor dysfunction in rural postpartum mothers in the United States: prevalence, severity, and psychosocial correlates. *Women & Health*, 62(9–10), 775–787. <https://doi.org/10.1080/03630242.2022.2146831>
- Suralaga, C., Krisnadewi, L. A. M., & Dinengsih, S. (2020). Pengaruh Senam Kegel Terhadap Kesiapan Diri Secara Seksual Ibu Primipara Di Rumah Sakit Umum Bangli Medika Canti Bali Tahun 2019. *Journal for Quality in Women's Health*, 3(2), 122–126. <https://doi.org/10.30994/jqwh.v3i2.60>
- Yanti, E. M., & Fatmasari, B. D. (2023). *Buku psikologi kehamilan, persalinan, dan nifas* (M. Nasrudin, Ed.). PT Nasya Expanding Management.
- Yuliana, W., & Hakim, B. N. (2020). *Emodemo Dalam Asuhan Kebidanan Masa Nifas*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia .
- Yusuf, M., & Armanto, R. P. (2021). Hormon Estrogen Pada Kondisi Inpartu. In *Seminar Nasional Riset Kedokteran (SENSORIK II)*.

F. Glosarium

PPD = Post Partum Depression

PROFIL PENULIS



Santi Wahyuni, S.Kp, M.Kep, Sp.Mat., Lahir di Bandung, 05 Januari 1977. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Kedokteran, Universitas Padjadjaran tahun 2000. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Program Magister Keperawatan, Fakultas Ilmu Keperawatan, Universitas Indonesia dan lulus tahun pada tahun 2007 serta Program Spesialis-1 Keperawatan Maternitas, Fakultas Ilmu Keperawatan, Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2008. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2000

sebagai staf pengajar di Akademi Perawat Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dan melaksanakan program magang di RSUD Kabupaten Sumedang selama 1 tahun. Penulis sejak Mei 2002 hingga saat ini bekerja sebagai pengajar di Program Studi Keperawatan Cirebon, Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Penulis mengampu mata Keperawatan Maternitas, Konsep Dasar Keperawatan, Keperawatan Dasar, Metodologi Keperawatan, Metodologi Penelitian, Etika Keperawatan dan Hukum Kesehatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, reviewer soal uji kompetensi nasional, publikasi artikel ilmiah dalam jurnal nasional maupun internasional, aktif mengikuti kegiatan ilmiah seperti pelatihan, workshop dan seminar. Penulis sebagai pendiri dan pembina Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa (PIKMA) SPIRIT, Asesor LAM-PT Kes, Auditor Audit Mutu Internal (AMI) Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, Pengurus DPD Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kota Cirebon, Pengurus Ikatan Perawat Maternitas Indonesia (IPEMI) Jawa Barat, Pengurus Yayasan Ahnaf Maulana Nafi, serta tergabung dalam tim vaksinator dan tim Health and Disaster (HADE) Center dari Center of Excellence (CoE) Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: santiwahyuni@dosen.poltekkestasikmalaya.ac.id
Motto: "Kesuksesan sejati diraih dengan sabar, diwarnai dengan keikhlasan, dan diukir dengan ikhtiar"

PROFIL PENULIS



Dr. Ns. Machmudah, M.Kep., Sp.Kep.Mat., Lahir di Tegal, 15 Desember 1972. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan FK Undip lulus pada tahun 2001. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Spesialis Keperawatan Maternitas pada Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia dan lulus tahun pada tahun 2011. Penulis menyelesaikan pendidikan Doktoral Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga dan lulus pada tahun 2024. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1996 sebagai perawat klinik di RSAB Harapan Kita Jakarta. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen tetap Departemen Keperawatan di Universitas Muhammadiyah Semarang mengampu mata kuliah Keperawatan Dasar, Keperawatan Maternitas dan Metodologi Penelitian. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: machmudah@unimus.ac.id



Enok Nurliawati, S.Kp., M.Kep., Lahir di Tasikmalaya, 27 Juli 1971. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 Keperawatan pada Akademi Keperawatan A. Yani, Cimahi lulus tahun 1993, melanjutkan ke jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Padjadjaran, Bandung, lulus tahun 1999. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Prgram Paska Sarjana Keperawatan di Universitas Indonesia dan lulus tahun pada tahun 2010. Riwayat pekerjaan 1994 s.d. sekarang sebagai dosen. Saat ini penulis bekerja di Universitas Bakti Tunas Husada mengampu mata kuliah Metodologi Keperawatan, Keperawatan Dasar, Keperawatan Maternitas dan Proses Keperawatan dan Berpikir Kritis. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan ilmiah lainnya.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: enoknurliawati@universitas-bth.ac.id

PROFIL PENULIS



Wulida Litaqia, S.Kep., Ners., M.Kep., Lahir di Sanggau, 28 Maret 1995.

Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan dan Profesi Ners, STIK Muhammadiyah Pontianak tahun 2018. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Magister Keperawatan pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan lulus tahun 2020. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2020 sebagai Dosen di STIKes Yarsi Pontianak sebagai dosen dan staff LPPM. Saat ini penulis bekerja di Universitas Tanjungpura Pontianak mengampu mata kuliah Keperawatan Maternitas, Kesehatan Reproduksi, dan Keperawatan Jiwa. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi artikel, pembicara seminar pada bidang kesehatan reproduksi dan jiwa ibu, anak dan remaja, serta kegiatan pengabdian masyarakat bidang kesehatan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: wulidalitaqia@ners.untan.ac.id

Motto: "Life Long Learning"

Ns. Hesti Ratna Sari, M.Kep., Lahir di Bandung, 21 November 1980 Pendidikan Diploma III Lulus Tahun 2002. Sarjana 2016 lanjut Ners 2018 dan magister Keperawatan Tahun 2020 Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2003 Sebagai Perawat Pelaksana di Rumah Sakit Serang lanjut Tahun 2012 Sebagai tenaga laboran dilaboratorium Keperawatan Pemerintah Kabupaten Serang dan Tahun 2021 Sebagai Tenaga Pengajar di Diploma III Keperawatan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sampai melalui e-mail: achmdfsl@contoh.com

Motto: "Living your life well"

Sinopsis

Buku ini membahas perawatan pasca persalinan dan kesehatan ibu dengan pendekatan yang holistik dan komprehensif. Setiap ibu yang baru saja melahirkan membutuhkan perhatian khusus dalam proses pemulihan fisik, mental, dan emosional. Buku ini mengulas berbagai aspek penting yang memengaruhi kesehatan ibu pasca melahirkan, serta tantangan yang sering dihadapi oleh ibu dalam menjalani masa pemulihan.

Dimulai dengan perawatan pasca melahirkan pada ibu dengan komplikasi perdarahan post partum, buku ini memberikan panduan yang jelas tentang cara menangani dan mencegah perdarahan, yang merupakan salah satu penyebab utama kematian ibu setelah persalinan. Selanjutnya, dibahas pula kesehatan seksual pasca persalinan, di mana buku ini menawarkan solusi dan edukasi tentang pentingnya pemulihan fungsi reproduksi untuk mengembalikan kualitas hidup seksual ibu setelah melahirkan.

Buku ini juga menyajikan bab tentang perawatan pasca operasi caesar, di mana ibu yang menjalani prosedur ini menghadapi tantangan pemulihan fisik yang lebih kompleks. Dalam hal ini, buku ini memberikan informasi tentang langkah-langkah perawatan yang tepat untuk mempercepat pemulihan dan mengurangi risiko komplikasi. Selain itu, bagi ibu dengan komplikasi gizi pasca persalinan, buku ini menawarkan wawasan mengenai pentingnya perawatan gizi yang tepat untuk mendukung pemulihan tubuh ibu.

Tak kalah penting, buku ini juga membahas aspek kesehatan mental ibu pasca melahirkan. Gangguan mental seperti depresi pasca persalinan adalah hal yang sering dihadapi oleh banyak ibu. Oleh karena itu, buku ini memberikan dukungan pendidikan dan pendekatan yang diperlukan untuk membantu ibu dalam mengelola gangguan mental pasca persalinan. Bab terakhir membahas tantangan kesehatan seksual pasca persalinan, dengan fokus pada bagaimana mendukung ibu yang mengalami perubahan fisik dan emosional yang mempengaruhi kehidupan seksual mereka.

Secara keseluruhan, buku ini memberikan informasi yang sangat berharga bagi tenaga medis, keluarga, dan para ibu yang sedang menjalani masa pemulihan pasca persalinan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang perawatan dan tantangan yang dihadapi ibu pasca melahirkan, diharapkan ibu dapat menjalani pemulihan dengan lebih baik, mendapatkan dukungan yang diperlukan, dan kembali menjalani kehidupan dengan lebih sehat dan bahagia.

Buku ini membahas perawatan pasca persalinan dan kesehatan ibu dengan pendekatan yang holistik dan komprehensif. Setiap ibu yang baru saja melahirkan membutuhkan perhatian khusus dalam proses pemulihan fisik, mental, dan emosional. Buku ini mengulas berbagai aspek penting yang memengaruhi kesehatan ibu pasca melahirkan, serta tantangan yang sering dihadapi oleh ibu dalam menjalani masa pemulihan.

Dimulai dengan perawatan pasca melahirkan pada ibu dengan komplikasi perdarahan post partum, buku ini memberikan panduan yang jelas tentang cara menangani dan mencegah perdarahan, yang merupakan salah satu penyebab utama kematian ibu setelah persalinan. Selanjutnya, dibahas pula kesehatan seksual pasca persalinan, di mana buku ini menawarkan solusi dan edukasi tentang pentingnya pemulihan fungsi reproduksi untuk mengembalikan kualitas hidup seksual ibu setelah melahirkan.

Buku ini juga menyajikan bab tentang perawatan pasca operasi caesar, di mana ibu yang menjalani prosedur ini menghadapi tantangan pemulihan fisik yang lebih kompleks. Dalam hal ini, buku ini memberikan informasi tentang langkah-langkah perawatan yang tepat untuk mempercepat pemulihan dan mengurangi risiko komplikasi. Selain itu, bagi ibu dengan komplikasi gizi pasca persalinan, buku ini menawarkan wawasan mengenai pentingnya perawatan gizi yang tepat untuk mendukung pemulihan tubuh ibu. Tak kalah penting, buku ini juga membahas aspek kesehatan mental ibu pasca melahirkan. Gangguan mental seperti depresi pasca persalinan adalah hal yang sering dihadapi oleh banyak ibu. Oleh karena itu, buku ini memberikan dukungan pendidikan dan pendekatan yang diperlukan untuk membantu ibu dalam mengelola gangguan mental pasca persalinan. Bab terakhir membahas tantangan kesehatan seksual pasca persalinan, dengan fokus pada bagaimana mendukung ibu yang mengalami perubahan fisik dan emosional yang mempengaruhi kehidupan seksual mereka.

Secara keseluruhan, buku ini memberikan informasi yang sangat berharga bagi tenaga medis, keluarga, dan para ibu yang sedang menjalani masa pemulihan pasca persalinan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang perawatan dan tantangan yang dihadapi ibu pasca melahirkan, diharapkan ibu dapat menjalani pemulihan dengan lebih baik, mendapatkan dukungan yang diperlukan, dan kembali menjalani kehidupan dengan lebih sehat dan bahagia.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919

